

PENUNTUN PRAKTIKUM ASUHAN KEBIDANAN PERSALINAN

**Irfana Tri Wijayanti, S.Si.T., M.Kes., M.Keb.
Putu Ayu Ratna Darmayanti, STr.Keb., M.Kes.
Amanda Via Maulinda, STr.Keb., MKM.**

PENUNTUN PRAKTIKUM ASUHAN KEBIDANAN PERSALINAN

IRFANA TRI WIJAYANTI, S.Si.T, M.Kes., M.Keb
PUTU AYU RATNA DARMAYANTI, STr.Keb, M.Kes
AMANDA VIA MAULINDA, STr.Keb, MKM



**Nuansa
Fajar
Cemerlang**

PENUNTUN PRAKTIKUM ASUHAN KEBIDANAN PERSALINAN

Penulis:

Irfana Tri Wijayanti, S.Si.T, M.Kes., M.Keb
Putu Ayu Ratna Darmayanti, STr.Keb, M.Kes
Amanda Via Maulinda, STr.Keb, MKM

Desain Cover:

Ivan Zumarano

Tata Letak:

**Siti Hartina Fatimah
Achmad Faisal**

ISBN:

978-623-88659-0-1

Cetakan Pertama:

April, 2023

Hak Cipta 2023

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Copyright © 2023

by Penerbit Nuansa Fajar Cemerlang Jakarta

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website: www.nuansafajarcemerlang.com

Instagram: @bimbel.optimal

KATA PENGANTAR

Buku penuntun praktikum asuhan kebidanan persalinan ini sangat memberikan manfaat bagi mahasiswa kebidanan. Mahasiswa kebidanan dituntut untuk mampu memberikan asuhan yang tepat berdasarkan standar operasional prosedur sehingga meminimalkan adanya kesalahan dalam memberikan asuhan.

Pengalaman mahasiswa untuk belajar memberikan asuhan dimulai dari adanya pembelajaran praktikum di laboratorium. Desain pembelajaran praktikum yang telah dikonsep optimal untuk memberikan ketrampilan mahasiswa membutuhkan buku pedoman untuk acuan mahasiswa dalam belajar.

Denga disusun nya buku penuntun praktim asuhan kebidanan persalinan pasti akan memberikan kontribusi nyata dalam mengelola pembelajaran praktikum bagi mahasiswa. Semoga buku ini dapat dipergunakan oleh mahasiswa untuk belajar secara mandiri sehingga practical skill mahasiswa kebidanan dapat optimal.

Pati, 27 Desember 2022
Pengurus Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Cabang Pati
Bidang Pendidikan

Siti Marfu'ah, S.S.T., M.P.H.

PRAKATA

Dengan mengucapkan puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan buku Asuhan Kebidanan yang berjudul “Penuntun Praktikum Asuhan Kebidanan Persalinan”.

Dalam kesempatan yang baik ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besar pada Optimal yang telah memberikan kesempatan pada kami dalam penyusunan buku ini Doa restu dan dukungan dari para pimpinan institusi kami menjadi jalan terselesainya buku ini.

Penulis menya dari bahwa dalam penulisan Buku Asuhan Kebidanan ini banyak keterbatasan, kekurangan, maka dengan hati terbuka penulis menerima saran serta kritik dari para pembaca Akhir kata penulis ucapkan selamat membaca, smoga dapat memanfaatkan Buku Asuhan Kebidanan ini dengan dasar niat yang baik untuk mengimplementasikannya dalam memberikan pelayanan pada masyarakat.

Pati, 27 Desember 2022

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
PRAKATA	iv
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PRAKTIKUM PARTOGRAF.....	1
A. Deskripsi.....	2
B. Tujuan Pembelajaran.....	2
C. Uraian Materi	2
D. Rating Scale Belajar Keterampilan.....	7
E. Daftar Pustaka	14
F. Glosarium	15
BAB II PRAKTIKUM POSISI MENERAN.....	17
A. Deskripsi.....	18
B. Tujuan Pembelajaran.....	18
C. Uraian Materi	18
D. Rating Scale Belajar Keterampilan.....	21
E. Daftar Pustaka	24
F. Glosarium	25
BAB III PRAKTIKUM ASUHAN PERSALINAN NORMAL.....	27
A. Deskripsi.....	28
B. Tujuan Pembelajaran.....	28
C. Uraian Materi	28
D. Rating Scale Belajar Keterampilan.....	39
E. Daftar Pustaka	47
F. Glosarium	48
BAB IV PRAKTIKUM HEATING PERINEUM	51
A. Deskripsi.....	52
B. Tujuan Pembelajaran.....	52
C. Uraian Materi	52
D. Rating Scale Belajar Keterampilan.....	55
E. Daftar Pustaka	58
F. Glosarium	59
BAB V PRAKTIKUM VAGINAL TOUCHER (VT).....	61
A. Deskripsi.....	62
B. Tujuan Pembelajaran.....	62
C. Uraian Materi	62
D. Rating Scale Belajar Keterampilan.....	65

E.	Daftar Pustaka	68
F.	Glosarium	69
BAB VI PRAKTIKUM DISTOSIA BAHU		73
A.	Deskripsi	74
B.	Tujuan Pembelajaran	74
C.	Uraian Materi	74
D.	Rating Scale Belajar Keterampilan	81
E.	Daftar Pustaka	84
F.	Glosarium	85
BAB VII PRAKTIKUM MANUAL PLASENTA		89
A.	Deskripsi	90
B.	Tujuan Pembelajaran	90
C.	Uraian Materi	90
D.	Rating Scale Belajar Keterampilan	94
E.	Daftar Pustaka	97
F.	Glosarium	98
BAB VIII PRAKTIKUM KOMPRESI AORTA ABDOMINALIS		101
A.	Deskripsi	102
B.	Tujuan Pembelajaran	102
C.	Uraian Materi	102
D.	Rating Scale Belajar Keterampilan	106
E.	Daftar Pustaka	109
F.	Glosarium	110
BAB IX PRAKTIKUM AMNIOTOMI		113
A.	Deskripsi	114
B.	Tujuan Pembelajaran	114
C.	Uraian Materi	114
D.	Rating Scale Belajar Keterampilan	116
E.	Daftar Pustaka	119
F.	Glosarium	120
BAB X PRAKTIKUM EPISIOTOMI		123
A.	Pendahuluan	124
B.	Tujuan Pembelajaran	124
C.	Uraian Materi	124
D.	Rating Scale Belajar Keterampilan	129
E.	Daftar Pustaka	132
F.	Glosarium	133
BAB XI PRAKTIKUM PERTOLONGAN PERSALINAN SUNGSANG METODE BRACHT .		135
A.	Deskripsi	136
B.	Tujuan Pembelajaran	136

C.	Uraian Materi	136
D.	Rating Scale Belajar Keterampilan.....	138
E.	Daftar Pustaka	141
F.	Glosarium	142
BAB XII PRAKTIKUM KOMPRESI BIMANUAL INTERNA (KBI)		143
A.	Deskripsi.....	144
B.	Tujuan Pembelajaran	144
C.	Uraian Materi	144
D.	Rating Scale Belajar Keterampilan.....	146
E.	Daftar Pustaka	149
F.	Glosarium	150
BAB XIII PRAKTIKUM KOMPRESI BIMANUAL EKSTERNA (KBE)		151
A.	Deskripsi.....	152
B.	Tujuan Pembelajaran	152
C.	Uraian Materi	152
D.	Rating Scale Belajar Keterampilan.....	154
E.	Daftar Pustaka	157
F.	Glosarium	158
PROFIL PENULIS		159

BAB I

PRAKTIKUM PARTOGRAF

Irfana Tri Wijayanti, S.Si.T., M.Kes., M.Keb.



A. Deskripsi

Kematian ibu yang berhubungan dengan kehamilan, persalinan dan nifas sangat sering terjadi yang disebabkan oleh hipertensi dalam kehamilan, perdarahan dan sepsis. Terutama di negara berkembang, penyebab lainnya yaitu partus lama, partus tak maju, dan ruptura uteri. Untuk mengurangi resiko kematian dengan sebab-sebab di atas, maka diperlukan adanya deteksi dini kemajuan kehamilan, persalinan (Kusumastiwi, 2022).

Kemajuan persalinan dapat dilakukan pemantauan dengan menggunakan partograf. Pada bab ini mahasiswa mempelajari tentang konsep dan prosedur pengisian partograf.

B. Tujuan Pembelajaran**1. Tujuan Pembelajaran Umum**

Setelah mempelajari praktikum ini mahasiswa mampu mempraktikkan pengisian partograf

2. Tujuan Pembelajaran Khusus

Setelah mempelajari materi ini diharapkan dapat:

- a. Mahasiswa mampu memahami tentang partograf
- b. Mahasiswa mampu mempraktikkan pengisian partograf

C. Uraian Materi**1. Definisi**

Pengisian partograf dalam persalinan dapat menurunkan angka kematian maternal dan perinatal yang mampu meningkatkan tingkat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Penerapan partograph ditujukan pada kehamilan normal atau persalinan pervaginam dengan memperhatikan garis waspada dan garis tindakan sebagai titik tolak evaluasi pertolongan persalinan. Penggunaan partograf diharapkan dapat menurunkan angka kematian maternal dan perinatal. Partograf juga sebagai syarat legalnya persalinan atau sebagai perlindungan hukum bila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan dapat dipastikan bahwa ibu dan bayinya mendapatkan asuhan persalinan secara aman, akurat dan tepat waktu, serta membantu mencegah terjadinya penyulit persalinan (Haeriah, 2021).

Partograf memainkan peran penting dalam menentukan diagnosis persalinan, karena partograf adalah pedoman untuk manajemen dan

pengamatan persalinan normal yang akan memfasilitasi asisten persalinan dalam mendeteksi kasus darurat pada ibu dan janin (Pusat, 2016).

2. Tujuan

Berdasarkan pada (Afandi, 2017), tujuan Penggunaan Partograf :

- a. Sebagai alat untuk mencatat data pemantauan kondisi ibu, janin, grafik kemajuan persalinan, pemeriksaan laboratorium, membuat keputusan klinis serta asuhan apa saja yang diberikan tertulis secara rinci pada rekam medis
- b. Untuk mendukung sistem rujukan kebidanan sehingga asuhan kebidanan efektif dan efisien.
- c. Mencatat hasil observasi dan kemajuan persalinan
- d. Memantau proses persalinan normal
- e. Mendeteksi secara dini adanya masalah persalinan
- f. Membantu dalam proses pengambilan keputusan klinik (Haeriah M, 2021).

3. Indikasi

Berdasarkan (Afandi, 2017), (Pusat, 2016), (Yulizawati *et al.*, 2019)Indikasi Partograf harus digunakan untuk :

- a. Semua Ibu dalam fase aktif kala satu persalinan sampai dengan kelahiran bayi sebagai elemen penting asuhan persalinan
- b. Semua tempat pelayanan persalinan (PMB, Klinik, Puskesmas, Rumah Sakit)
- c. Semua penolong persalinan yang memberikan asuhan kepada ibu selama persalinan dan kelahiran

4. Kontrak Indikasi

Menurut (Afandi, 2017), (Pusat, 2016), (Yulizawati *et al.*, 2019), Kontra indikasi pengisian partograf adalah sebagai berikut:

- a. Wanita pendek, tinggi kurang dari 145 cm
- b. Perdarahan antepartum
- c. Preeklamsi – eklamsi
- d. Persalinan *premature*
- e. Bekas *sectio sesarea*
- f. Kehamilan ganda
- g. Kelainan letak janin
- h. *Fetal distress*
- i. Dugaan distosia karena panggul sempit
- j. Kehamilan dengan hidramnion
- k. Ketuban pecah dini
- l. Persalinan dengan induksi

5. Hal-hal yang diperhatikan

Hal – hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan pengisian partograf adalah sebagai berikut:

- a. Ketelitian dalam pengisian partograf
- b. Tindakan dilakukan sesuai dengan tahapan prosedur

6. Persiapan Alat

Menurut buku (Pusat, 2016), persiapan alat dan bahan yang dibutuhkan untuk melakukan pengisian partograf adalah sebagai berikut:

- a. Lembar partograf
- b. Alat tulis (pensil, penggaris, penghapus)

7. Prosedur Tindakan dan Rating scale Tindakan

Prosedur Tindakan

Menurut (Pusat, 2016),(Yulizawati *et al.*, 2019), prosedur tindakan dan rating scale pengisian partograf sebagai berikut:

- a. Siapkan peralatan yang dibutuhkan
- b. Mencatat informasi tentang ibu
 - 1) Mengisi nama ibu dan suami (dengan menuliskan inisial)
 - 2) Mengisi umur ibu dan suami
 - 3) Mengisi GPA (gravida, para, abortus)
 - 4) Mengisi nomor rekam medis
 - 5) Mengisi tanggal dan waktu mulai dirawat
 - 6) Mengisi waktu pecahnya ketuban (jika pada waktu masuk ibu belum mengalami pecah ketuban maka dituliskan tanda strip/-)
 - 7) Mengisi waktu kapan ibu mulai merasakan mules (kencengkenceng)
 - 8) Mengisi alamat rumah ibu
- c. Mencatat pembukaan serviks
 - 1) Pilih angka pada tepi kiri luar kolom pembukaan serviks yang sesuai dengan besarnya pembukaan serviks pada fase aktif persalinan yang diperoleh dari hasil VT
 - 2) Untuk pemeriksaan pertama pada fase aktif, temuan (pembukaan serviks) dari hasil VT harus dicantumkan pada garis WASPADA. Pilih angka yang sesuai dengan bukaan serviks dan cantumkan tanda “X” (Pada ordinat atau titik silang garis pembukaan serviks dan garis waspada)
- d. Mencatat waktu (jam)
 - 1) Perhatikan bagian bawah “pembukaan serviks dan penurunan” tertera kotak-kotak yang diberi angka 1-16. Setiap kotak menyatakan satu jam sejak dimulainya fase aktif persalinan

- 2) Setelah mencamtumkan pembukaan serviks di garis Waspada maka Tarik ke bawah kemudian tuliskan (catat) waktu aktual pemeriksaan dikotak waktu yang sesuai.
 - 3) Kemudian tuliskan waktu di kotak yang tersedia sampai dengan waktu pembukaan lengkap
- e. Melanjutkan pencatatan pembukaan serviks
- 1) Catat pembukaan serviks berikutnya dengan memberikan tanda "X" (sesuaikan dengan kolom waktu kapan dilakukan pemeriksaan dalam/ VT)
 - 2) Hubungkan tanda "X" dari setiap pemeriksaan dalam dengan garis utuh dan bersambung
- f. Mencatat Denyut Jantung Janin
- 1) Catat DJJ dengan memberi tanda titik (●) pada garis yang sesuai dengan angka yang menunjukkan DJJ dan waktu pemeriksaan DJJ
 - 2) Catat DJJ setiap 30 menit (sesuaikan dengan waktu pemeriksaan) sampai dengan pemeriksaan berakhir (pembukaan lengkap)
 - 3) Kemudian hubungkan titik yang satu dengan titik lainnya dengan garis tegas dan bersambung
- g. Mencatat warna dan adanya air ketuban
- 1) Catat temuan-temuan warna dan adanya air ketuban dalam kotak yang sesuai di bawah lajur DJJ (sesuaikan dengan kolom waktu kapan dilakukan pemeriksaan selaput ketuban)
 - 2) U= selaput ketuban masih utuh (belum pecah),
J= sudah pecah dan jernih
M= sudah pecah bercampur mekoneum
D= sudah pecah bercampur darah
K= sudah pecah dan kering
- h. Mencatat penyusupan (molase)
- 1) Catat temuan adanya penyusupan (molase) dalam kotak yang sesuai di bawah lajur "air ketuban" (sesuaikan dengan kolom waktu kapan dilakukan pemeriksaan dalam/ VT)
 - 2) 0= tulang kepala janin terpisah dan sutura dengan mudah dipalpsi
1= tulang kepala saling bersentuhan
2= tulang kepala janin saling tumpang tindih, masih dapat dipisahkan
3= tulang kepala saling tumpang tindih tidak dapat dipisahkan
- i. Mencatat penurunan bagian terbawah janin
- 1) Catat hasil pemeriksaan penurunan bagian terbawah janin (kepala)
 - 2) Berikan tanda "O" yang ditulis pada garis waktu yang sesuai

- 3) Hubungkan tanda “O” dari setiap pemeriksaan dengan garis utuh dan bersambung
- j. Mencatat kontraksi uterus
 - 1) Catat kontraksi uterus setiap 30 menit dan sesuaikan dengan kolom waktu kapan dilakukan pemeriksaan kontraksi
 - 2) Nyatakan jumlah kontraksi yang terjadi dalam waktu 10 menit dengan cara mengisi kotak kontraksi yang tersedia dan disesuaikan dengan angka yang menunjukkan temuan dari hasil pemeriksaan kontraksi
 - 3) Catat kontraksi uterus sampai dengan pembukaan lengkap
- k. Mencatat oksitosin dan jumlah tetes per menit
 - 1) Catat jumlah unit oksitosin yang diberikan per volume cairan IV dan dalam satuan tpm (tetes per menit) sesuaikan dengan kolom waktu
 - 2) Jika ibu tidak diberikan oksitosin drip (induksi) maka biarkan kolom ini kosong
- l. Mencatat obat dan cairan IV
 - 1) Catat semua pemberian obat-obatan tambahan dan/ atau cairan IV dalam kotak yang sesuai dengan kolom waktunya
 - 2) Jika ibu tidak diberikan obat-obatan tambahan dan cairan IV maka biarkan kolom ini kosong
- m. Mencatat nadi
 - 1) Catat nadi ibu setiap 30 menit selama fase aktif persalinan
 - 2) Beri tanda titik (●) pada kolom waktu yang sesuai
 - 3) Catat nadi ibu sampai dengan pembukaan lengkap (pemeriksaan berakhir)
 - 4) Hubungkan tanda titik tersebut dengan garis utuh dan bersambung
- n. Mencatat tekanan darah ibu
 - 1) Catat hasil pemeriksaan tekanan darah ibu sampai dengan pembukaan lengkap/ pemeriksaan berakhir
 - 2) Beri tanda panah sesuai hasil pemeriksaan pada kolom yang sesuai (↕)
- o. Mencatat suhu tubuh ibu
 - 1) Catat suhu tubuh ibu setiap 2 jam
 - 2) Catat pada kotak sesuai dengan waktu pemeriksaan
- p. Mencatat volume urine, protein dan aseton
 - 1) Catat volume urine ibu sedikitnya setiap 2 jam (setiap kali berkemih) pada kolom sesuai waktu pemeriksaan

- 2) Jika urine ibu tidak mengandung protein dan aseton maka berikan tanda strip sesuai waktu pemeriksaan
- q. Mencatat makan dan minum terakhir
Catat kapan ibu makan dan minum terakhir (jam, jenis, porsi)
- r. Memberikan tanda tangan dan nama terang pada kolom penolong
- s. Mencatat keterangan bayi lahir
Catat di keterangan bayi lahir pada sebelah kanan garis bertindak (contoh: Bayi lahir pada tanggal 9 April 2019 pukul 09.00 dengan JK perempuan BB = 3000 gr, PB = 48 cm, menangis kuat dan gerakan aktif)

D. Rating Scale Belajar Keterampilan

PARTOGRAF

Nilailah setiap langkah/kinerja yang diamati dengan menggunakan skala sbb:

- 0 = Bila Langkah atau tugas tidak dikerjakan
1 = Langkah dilakukan tetapi tidak sempurna
2 = Langkah dilakukan dengan sempurna

No	Komponen	Nilai			
		0	1	2	Score
A. Sikap					
1.	Menyapa klien dengan ramah dan sopan				10
2.	Memperkenalkan diri kepada klien				
3.	Teruji menjaga privacy klien				
4.	Percaya diri				
5.	Teruji menjelaskan maksud dan tujuan				
B. Isi					
	Menyiapkan peralatan yang dibutuhkan				36
1.	Mencatat informasi tentang ibu				
	a. Mengisi nama ibu dan suami (dengan menuliskan inisial)				
	b. Mengisi umur ibu dan suami				
	c. Mengisi GPA (gravida, para, abortus)				
	d. Mengisi nomor rekam medis				
	e. Mengisi tanggal dan waktu mulai dirawat				
	f. Mengisi waktu pecahnya ketuban (jika pada waktu masuk ibu belum mengalami pecah ketuban maka dituliskan tanda strip/-)				
	g. Mengisi waktu kapan ibu mulai merasakan mules (kencengkenceng)				
	h. Mengisi alamat rumah ibu				
2.	Mencatat pembukaan serviks				
	a. Pilih angka pada tepi kiri luar kolom pembukaan serviks yang sesuai dengan besarnya pembukaan				

No	Komponen	Nilai			
		0	1	2	Score
	serviks pada fase aktif persalinan yang diperoleh dari hasil VT b. Untuk pemeriksaan pertama pada fase aktif, temuan (pembukaan serviks) dari hasil VT harus dicantumkan pada garis WASPADA. Pilih angka yang sesuai dengan bukaan serviks dan cantumkan tanda "X" (Pada ordinat atau titik silang garis pembukaan serviks dan garis waspada)				
3.	Mencatat waktu (jam) a. Perhatikan bagian bawah "pembukaan serviks dan penurunan" tertera kotak-kotak yang diberi angka 1-16. Setiap kotak menyatakan satu jam sejak dimulainya fase aktif persalinan b. Setelah mencantumkan pembukaan serviks di garis Waspada maka Tarik ke bawah kemudian tuliskan (catat) waktu aktual pemeriksaan dikotak waktu yang sesuai. c. Kemudian tuliskan waktu di kotak yang tersedia sampai dengan waktu pembukaan lengkap				
4.	Melanjutkan pencatatan pembukaan serviks a. Catat pembukaan serviks berikutnya dengan memberikan tanda "X"(sesuaikan dengan kolom waktu kapan dilakukan pemeriksaan dalam/ VT) b. Hubungkan tanda "X" dari setiap pemeriksaan dalam dengan garis utuh dan bersambung				
5.	Mencatat Denyut Jantung Janin a. Catat DJJ dengan memberi tanda titik (●) pada garis yang sesuai dengan angka yang menunjukkan DJJ dan waktu pemeriksaan DJJ b. Catat DJJ setiap 30 menit (sesuaikan dengan waktu pemeriksaan) sampai dengan pemeriksaan berakhir (pembukaan lengkap) c. Kemudian hubungkan titik yang satu dengan titik lainnya dengan garis tegas dan bersambung				
6.	Mencatat warna dan adanya air ketuban a. Catat temuan-temuan warna dan adanya air ketuban dalam kotak yang sesuai di bawah lajur DJJ (sesuaikan dengan kolom waktu kapan dilakukan pemeriksaan selaput ketuban) b. U= selaput ketuban masih utuh (belum pecah), J= sudah pecah dan jernih M= sudah pecah bercampur mekoneum D= sudah pecah bercampur darah K= sudah pecah dan kering				
7.	Mencatat penyusupan (molase) a. Catat temuan adanya penyusupan (molase) dalam kotak yang sesuai di bawah lajur "air ketuban"				

No	Komponen	Nilai			
		0	1	2	Score
	(sesuaikan dengan kolom waktu kapan dilakukan pemeriksaan dalam/ VT) b. 0= tulang kepala janin terpisah dan sutura dengan mudah dipalpasi 1= tulang kepala saling bersentuhan 2= tulang kepala janin saling tumpang tindih, masih dapat dipisahkan 3= tulang kepala saling tumpang tindih tidak dapat dipisahkan				
8.	Mencatat penurunan bagian terbawah janin a. Catat hasil pemeriksaan penurunan bagian terbawah janin (kepala) b. Berikan tanda "O" yang ditulis pada garis waktu yang sesuai c. Hubungkan tanda "O" dari setiap pemeriksaan dengan garis utuh dan bersambung				
9.	Mencatat kontraksi uterus a. Catat kontraksi uterus setiap 30 menit dan sesuaikan dengan kolom waktu kapan dilakukan pemeriksaan kontraksi b. Nyatakan jumlah kontraksi yang terjadi dalam waktu 10 menit dengan cara mengisi kotak kontraksi yang tersedia dan disesuaikan dengan angka yang menunjukkan temuan dari hasil pemeriksaan kontraksi c. Catat kontraksi uterus sampai dengan pembukaan lengkap				
10.	Mencatat oksitosin dan jumlah tetes per menit a. Catat jumlah unit oksitosin yang diberikan per volume cairan IV dan dalam satuan tpm (tetes per menit) sesuaikan dengan kolom waktu b. Jika ibu tidak diberikan oksitosin drip (induksi) maka biarkan kolom ini kosong				
11.	Mencatat obat dan cairan IV a. Catat semua pemberian obat-obatan tambahan dan/ atau cairan IV dalam kotak yang sesuai dengan kolom waktunya b. Jika ibu tidak diberikan obat-obatan tambahan dan cairan IV maka biarkan kolom ini kosong				

No	Komponen	Nilai			
		0	1	2	Score
12.	Mencatat nadi a. Catat nadi ibu setiap 30 menit selama fase aktif persalinan b. Beri tanda titik (●) pada kolom waktu yang sesuai c. Catat nadi ibu sampai dengan pembukaan lengkap (pemeriksaan berakhir) d. Hubungkan tanda titik tersebut dengan garis utuh dan bersambung				
13.	Mencatat tekanan darah ibu a. Catat hasil pemeriksaan tekanan darah ibu sampai dengan pembukaan lengkap/ pemeriksaan berakhir b. Beri tanda panah sesuai hasil pemeriksaan pada kolom yang sesuai (↕)				
14.	Mencatat suhu tubuh ibu a. Catat suhu tubuh ibu setiap 2 jam b. Catat pada kotak sesuai dengan waktu pemeriksaan				
15.	Mencatat volume urine, protein dan aseton a. Catat volume urine ibu sedikitnya setiap 2 jam (setiap kali berkemih) pada kolom sesuai waktu pemeriksaan b. Jika urine ibu tidak mengandung protein dan aseton maka berikan tanda strip sesuai waktu pemeriksaan				
16.	Mencatat makan dan minum terakhir a. Catat kapan ibu makan dan minum terakhir (jam, jenis, porsi)				
17.	Memberikan tanda tangan dan nama terang pada kolom penolong				
18.	Mencatat keterangan bayi lahir a. Catat di keterangan bayi lahir pada sebelah kanan garis bertindak (contoh : Bayi lahir pada tanggal 9 April 2019 pukul 09.00 dengan JK perempuan BB = 3000 gr, PB = 48 cm, menangis kuat dan gerakan aktif)				
C. Terminasi					
1.	Melakukan evaluasi tindakan				14
2.	Berpamitan dengan pasien				
3.	Membereskan dan mengembalikan alat				
4.	Mencuci tangan				
5.	Melaksanakan secara sistematis				
6.	Menggunakan bahasa yang mudah dimengerti				
7.	Mendokumentasikan hasil tindakan				
Total Score					
Nilai Akhir = Jumlah score yang diperoleh: Total Score keseluruhan x 100					
Tanda Tangan Penguji					

No	Komponen	Nilai			
		0	1	2	Score
	Referensi : Pengurus IBI Pusat. 2016. Buku Acuan Midwifery Update. Jakarta: Pengurus IBI Pusat. Yulizawati, dkk. (2019). <i>Buku Ajar Asuhan Kebidanan Pada Persalinan</i> . Sidoarjo : Indomedia Pustaka.				

PARTOGRAF

No. Register Nama Ibu : _____ Umur : _____ G. _____ P. _____ A. _____
 No. Puskesmas Tanggal : _____ Jam : _____ Alamat : _____
 Ketuban pecah Sejak jam _____ mules sejak jam _____

Denyut Jantung Janin (/menit)	200 190 180 170 160 150 140 130 120 110 100 90 80	
Air ketuban Penyusupan 		
Pembukaan serviks (cm) beri tanda x Turunnya kepala beri tanda o	10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0	WASPADA BERTINDAK
Waktu (jam) 		
Kontraksi tiap 0 Menit	5 4 3 2 1 (dok)	
Oksitosin U/L tetes/menit 		
Obat dan Cairan IV • Nadi Tekanan darah Suhu °C	180 170 160 150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 °C	
Urin	Protein Aseton Volume	

Gambar 1.1 Partograf Lembar Depan

CATATAN PERSALINAN

1. Tanggal :
2. Nama bidan :
3. Tempat Persalinan :
☐ Rumah Ibu ☐ Puskesmas
☐ Polindes ☐ Rumah Sakit
☐ Klinik Swasta ☐ Lainnya :
4. Alamat tempat persalinan :
5. Catatan : ☐ rujuk, kala : I / II / III / IV
6. Alasan merujuk :
7. Tempat rujukan :
8. Pendamping pada saat merujuk :
☐ Bidan ☐ Teman
☐ Suami ☐ Dukun
☐ Keluarga ☐ Tidak ada

KALA I

9. Partogram melewati garis waspada : Y / T
10. Masalah lain, sebutkan :
11. Penatalaksanaan masalah Tsb :
12. Hasilnya :

KALA II

13. Episiotomi :
☐ Ya, Indikasi
☐ Tidak
14. Pendamping pada saat persalinan
☐ Suami ☐ Teman ☐ Tidak ada
☐ Keluarga ☐ Dukun
15. Gawat Janin :
☐ Ya, tindakan yang dilakukan
 a.
 b.
 c.
☐ Tidak
16. Distosia bahu :
☐ Ya, tindakan yang dilakukan
 a.
 b.
 c.
☐ Tidak
17. Masalah lain, sebutkan :
18. Penatalaksanaan masalah tersebut :
19. Hasilnya :

KALA III

20. Lama kala III :menit
21. Pemberian Oksitosin 10 U im ?
☐ Ya, waktu : menit sesudah persalinan
☐ Tidak, alasan :
22. Pemberian ulang Oksitosin (2x) ?
☐ Ya, alasan :
23. Penegangan tali pusat terkendali ?
☐ Ya,
☐ Tidak, alasan :

PEMANTAUAN PERSALINAN KALA IV

Jam Ke	Waktu	Tekanan darah	Nadi	Tinggi Fundus Uteri	Kontraksi Uterus	Kandung Kemih	Perdarahan
1							
2							

Masalah kala IV :

Penatalaksanaan masalah tersebut :

Hasilnya :

24. Masase fundus uteri ?
☐ Ya.
☐ Tidak, alasan :
25. Plasenta lahir lengkap (*intact*) Ya / Tidak
 Jika tidak lengkap, tindakan yang dilakukan :
 a.
 b.
26. Plasenta tidak lahir > 30 menit : Ya / Tidak
☐ Ya, tindakan :
 a.
 b.
 c.
27. Laserasi :
☐ Ya, dimana
☐ Tidak.
28. Jika laserasi perineum, derajat : 1 / 2 / 3 / 4
 Tindakan :
☐ Penjahitan, dengan / tanpa anestesi
☐ Tidak dijahit, alasan :
29. Atoni uteri :
☐ Ya, tindakan
 a.
 b.
 c.
☐ Tidak
30. Jumlah perdarahan : ml
31. Masalah lain, sebutkan :
32. Penatalaksanaan masalah tersebut :
33. Hasilnya :

BAYI BARU LAHIR :

34. Berat badangram
35. Panjang cm
36. Jenis kelamin : L / P
37. Penilaian bayi baru lahir : baik / ada penyulit
38. Bayi lahir :
☐ Normal, tindakan :
 ☐ mengeringkan
 ☐ menghangatkan
 ☐ rangsang taktil
 ☐ bungkus bayi dan tempatkan di sisi ibu
☐ Asfiksia ringan/pucat/biru/lemas, tindakan :
 ☐ mengeringkan ☐ bebaskan jalan napas
 ☐ rangsang taktil ☐ menghangatkan
 ☐ bungkus bayi dan tempatkan di sisi ibu
 ☐ lain - lain sebutkan :
39. Pemberian ASI
☐ Ya, waktu :jam setelah bayi lahir
☐ Tidak, alasan :
40. Masalah lain,sebutkan :
- Hasilnya :

Gambar 1.2. Partograf Lembar Belakang

E. Daftar Pustaka

- Afandi, B. (2017) *Asuhan Persalinan Normal*. Jakarta: JNKP-KR.
- Haeriah, M. (2021) *Efektifitas Aplikasi Asuhan Persalinan Normal Berbasis Web Sebagai Media Pembelajaran Mahasiswa Kebidanan*. Makassar. Available at: <http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/3141/>.
- Kusumastiwi, dkk (2022) *Buku Panduan Ketrampilan Medik Semester VI*. Yogyakarta.
- Pusat, P.I. (2016) *Buku Acuan Midwifery Update*. Jakarta: Pengurus IBI Pusat.
- RI, D. (2017) *Profil Kesehatan Tahun 2017*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- S.H., M. (2019) 'Normal Labor and Delivery', *medicine* [Preprint]. Available at: <https://emedicine.medscape.com/article/260036-overview#showall>.
- Selasih Putri Isnawati Hadi, Sri Kuswanti, Cipta Pramana, A. (2020) *Modul Praktikum Asuhan Kebidanan Persalinan dan Bayi Baru Lahir*. Yogyakarta.
- Thornton, J. M., Browne, B., & Ramphul, M. (2019) 'Mechanisms and management of normal labour', *Obstetrics, Gynaecology & Reproductive Medicine* [Preprint]. Available at: <https://doi.org/10.1016/j.ogrm.2019.12.002>.
- Yulizawati et al. (2019) *Buku Asuhan Kelahiran, Indomedika Pustaka*.

F. Glosarium

A

Aseton urin : pemeriksaan konsentrasi *aseton* dalam *urine*.

D

Distosia : gangguan melahirkan pada ibu hamil yang melakukan persalinan pervaginam.

DJJ (denyut jantung janin): sebuah indikator atau dalam sebuah pemeriksaan kandungan yang menandakan bahwa ada kehidupan di dalam kandungan seorang ibu.

DTT: Desinfektan Tingkat Tinggi adalah suatu langkah memproses alat habis pakai yang telah digunakan untuk suatu tindakan untuk menghilangkan mikroorganisme.

F

Fetal distress : hipoksia janin progresif akibat oksigenasi janin yang tidak memadai.

H

HIS: Kekuatan nyeri fisiologis yang muncul pada ibu bersalin.

K

Kontraksi : kondisi perut ibu hamil mengencang dan mengeras yang muncul apabila calon ibu siap untuk melahirkan

M

Molase: indikator penting tentang seberapa jauh kepala *bayi* dapat menyesuaikan diri dengan bagian keras

P

Partograf: Alat bantu untuk memantau kemajuan suatu persalinan, kesejahteraan janin dan ibu serta sebagai informasi untuk membuat keputusan klinik.

Perdarahan Antepartum : perdarahan melalui vagina yang terjadi pada usia kehamilan lebih dari 24 minggu

Persalinan premature: kelahiran yang terjadi sebelum minggu ke-37 atau lebih awal dari hari perkiraan lahir

S

Sectio caesarea : salah satu tindakan persalinan untuk mengeluarkan bayi melalui sayatan pada abdomen/ laparotomi dan uterus/ histerotomi.

Selaput ketuban : membran yang membungkus fetus (janin).

U

Uterus : organ otot berbentuk buah pir terbalik dari sistem reproduksi wanita yang terletak di antara kandung kemih dan rektum.

V

Vaginal Toucher: Pemeriksaan bagian genetalia dalam yang dimulai dari vagina sampai serviks dengan menggunakan 2 jari.

BAB II

PRAKTIKUM POSISI MENERAN

Irfana Tri Wijayanti, S.Si.T., M.Kes., M.Keb.



A. Deskripsi

Posisi persalinan merupakan suatu peristiwa fisiologis tanpa disadari dan terus berlangsung/ progresif. Penolong persalinan dapat membantu agar ibu tetap tenang dan rileks, maka penolong persalinan tidak boleh mengatur posisi meneran. Penolong persalinan harus memfasilitasi ibu dalam memilih sendiri posisi meneran dan menjelaskan alternatif posisi meneran bila posisi yang dipilih ibu tidak efektif. Pada bab ini mahasiswa mempelajari tentang konsep dan prosedur heating perineum

B. Tujuan Pembelajaran**1. Tujuan Pembelajaran Umum**

Setelah mempelajari praktikum ini mahasiswa mampu mempraktikkan prosedur posisi meneran

2. Tujuan Pembelajaran Khusus

Setelah mempelajari materi ini diharapkan:

- a. Mahasiswa mampu memahami menyebutkan macam-macam memahami tentang posisi meneran
- b. Mahasiswa mampu mempraktikkan prosedur posisi meneran

C. Uraian Materi**1. Definisi**

Posisi meneran merupakan posisi yang nyaman bagi ibu bersalin. Ibu bersalin dapat berganti posisi secara teratur selama persalinan kala II karena hal ini seringkali mempercepat kemajuan persalinan dan ibu mungkin dapat meneran secara efektif pada posisi tertentu yang dianggap nyaman bagi ibu (Yulizawati *et al.*, 2019).

2. Tujuan

Berdasarkan pada (Afandi, 2017), tujuan posisi meneran adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan kenyamanan dan aman dalam proses persalinan
- b. Mempermudah dan memperlancar proses persalinan
- c. Mempercepat kemajuan persalinan

3. Indikasi

Berdasarkan (Yulizawati *et al.*, 2019)) indikasi dilakukan posisi meneran adalah

- a. Ibu bersalin inpartu kala I-II
- b. Ibu bersalin pervaginam
- c. Ibu bersalin yang tidak ada komplikasi dan/atau kegawatdaruratan

4. Kontrak Indikasi

Menurut (S.H., 2019; Thornton, J. M., Browne, B., & Ramphul, 2019), Kontra indikasi sebagai berikut:

- a. Kontrak indikasi dari faktor ibu
 - 1) Cephalopelvic disproportion
Ukuran kepala janin tidak sesuai dengan ukuran panggul ibu, di mana kondisi ini merupakan kontraindikasi absolut untuk melahirkan normal melalui vagina.
 - 2) Plasenta abnormal
Plasenta previa baik komplit maupun parsial dan plasenta akreta, di mana kondisi ini adalah kontraindikasi relatif sehingga dengan beberapa pertimbangan dapat dilakukan persalinan pervaginam dengan risiko perdarahan postpartum.
 - 3) Prolapsus tali pusat
Pada kondisi ini hindari manipulasi pada tali pusat dan segera dilakukan persalinan secara *sectio caesarea*.
 - 4) Vaginal birth after cesaeran section
Dapat meningkatkan risiko ruptur uteri, kondisi ini masih menjadi perdebatan para ahli sehingga terdapat beberapa kriteria pasien untuk melakukan.
- b. Kontrak indikasi dari faktor janin
 - 1) Mal presentasi
Pada mal presesntasi pada janin meliputi seperti presentasi dahi, wajah, bokong /sungsang, atau lintang sebaiknya tidak dilahirkan pervaginam untuk menurunkan risiko mortalitas bayi dan komplikasi distosia.
 - 2) Makrosomia
Makrosomia atau bayi besar, yaitu bayi dengan berat lahir lebih dari 4000 gram biasanya disarankan untuk melakukan persalinan secara *sectio caesarea* untuk mencegah komplikasi distosia.
 - 3) Janin kembar
Untuk melakukan persalinan normal, di mana dapat dilahirkan pervaginam tergantung dari jumlah janin, presentasi janin, perkiraan berat badan janin, kondisi janin di dalam rahim, kondisi ibu, dan tenaga ahli saat melakukan pertolongan persalinan.

5. Hal-hal yang diperhatikan

Hal – hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan posisi meneran adalah sebagai berikut:

- a. Menyiapkan inform consent
- b. Menyiapkan inform choice
- c. Menjaga privasi pasien
- d. Tindakan dilakukan sesuai dengan tahapan prosedur

6. Persiapan Alat

Menurut buku (Yulizawati *et al.*, 2019), (Pusat, 2016), persiapan alat dan bahan yang dibutuhkan untuk melakukan posisi meneran adalah sebagai berikut:

- a. Lembar balik
- b. Leaflet

7. Prosedur Tindakan dan Rating scale Tindakan

Menurut (Yulizawati *et al.*, 2019), prosedur tindakan dan rating scale posisi meneran sebagai berikut:

- a. Menanyakan dan mendengarkan keluhan
- b. Menjelaskan macam-macam posisi meneran dalam persalinan
Menjelaskan posisi duduk/ setengah duduk, merangkak, jongkok, berdiri, berbaring miring, terlentang
- c. Menjelaskan keuntungan posisi duduk/ setengah duduk
 - 1) Memberikan rasa nyaman bagi ibu
 - 2) Memberikan kemudahan bagi ibu untuk beristirahat diantara kontraksi
 - 3) Dengan adanya gravitasi dapat membantu ibu melahirkan bayinya
- d. Menjelaskan keuntungan posisi merangkak
 - 1) Lebih nyaman dan efektif untuk meneran
 - 2) Membantu perbaikan posisi oksiput melintang menjadi posisi oksiput anterior
 - 3) Membantu penurunan kepala janin lebih dalam ke panggul
 - 4) Membantu mengurangi keluhan nyeri saat persalinan
 - 5) Meningkatkan oksigen ke janin
 - 6) Mengurangi peregangan perineum
- e. Menjelaskan keuntungan posisi jongkok atau berdiri
 - 1) Membantu mempercepat kemajuan kala II persalinan
 - 2) Mengurangi nyeri
 - 3) Membantu penurunan janin kedalam panggul dan terus turun ke dasar panggul dengan bantuan gaya gravitasi
 - 4) Posisi jongkok dapat memaksimalkan sudut dalam lengkung carus yang memungkinkan bahu besar dapat turun ke rongga panggul dan tidak terhalang (macet) diatas simphisis

- 5) Kedua posisi ini memudahkan ibu dalam mengosongkan kandung kemih
- f. Menjelaskan keuntungan posisi berbaring miring ke kiri
 - 1) Lebih nyaman dan efektif untuk meneran
 - 2) Membantu penurunan kepala janin lebih dalam ke panggul
 - 3) Memudahkan ibu untuk beristirahat diantara kontraksi
 - 4) Mengurangi resiko terjadinya robekan perineum
 - 5) Meningkatkan oksigenasi bayi
- g. Menjelaskan kerugian posisi terlentang
 - 1) Tidak dianjurkan
 - 2) Dapat menyebabkan gangguan pernafasan
 - 3) Mengurangi mobilisasi ibu
 - 4) Menyebabkan waktu persalinan menjadi lama

D. Rating Scale Belajar Keterampilan

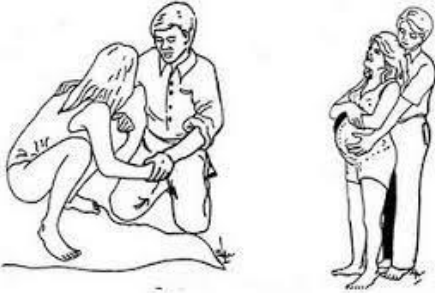
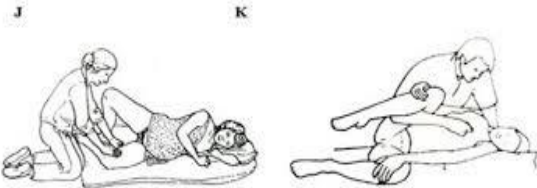
POSISI MENERAN

Nilailah setiap langkah/kinerja yang diamati dengan menggunakan skala sbb:

- 0 = Bila Langkah atau tugas tidak dikerjakan
 1 = Langkah dilakukan tetapi tidak sempurna
 2 = Langkah dilakukan dengan sempurna

No	Komponen	Nilai			
		0	1	2	Score
A. Sikap					
1.	Menyapa klien dengan ramah dan sopan				10
2.	Memperkenalkan diri kepada klien				
3.	Teruji menjaga privacy klien				
4.	Percaya diri				
5.	Teruji menjelaskan maksud dan tujuan				
B. Isi					
	Menanyakan dan mendengarkan keluhan				14
1.	Menjelaskan macam-macam posisi meneran Menjelaskan posisi duduk/ setengah duduk, merangkak, jongkok, berdiri, berbaring miring, terlentang				
2.	Menjelaskan keuntungan posisi duduk/ setengah duduk a. Memberikan rasa nyaman bagi ibu b. Memberikan kemudahan bagi ibu untuk beristirahat diantara kontraksi c. Dengan adanya gravitasi dapat membantu ibu melahirkan bayinya				

No	Komponen	Nilai			
		0	1	2	Score
	 Gambar 2.1 Posisi duduk/ setengah duduk				
3.	Menjelaskan keuntungan posisi merangkak a. Lebih nyaman dan efektif untuk meneran b. Membantu perbaikan posisi oksiput melintang menjadi posisi oksiput anterior c. Membantu penurunan kepala janin lebih dalam ke panggul d. Membantu mengurangi keluhan nyeri saat persalinan e. Meningkatkan oksigen ke janin f. Mengurangi peregangan perineum  Gambar 2.2 Posisi merangkak				
4.	Menjelaskan keuntungan posisi jongkok atau berdiri a. Membantu mempercepat kemajuan kala II persalinan b. Mengurangi nyeri c. Membantu penurunan janin ke dalam panggul dan terus turun ke dasar panggul dengan bantuan gaya gravitasi d. Posisi jongkok dapat memaksimalkan sudut dalam lengkung carus yang memungkinkan bahu besar dapat turun ke rongga panggul dan tidak terhalang (macet) diatas simphysis e. Kedua posisi ini memudahkan ibu dalam mengosongkan kandung kemih				

No	Komponen	Nilai			
		0	1	2	Score
	 Gambar 2.3 Posisi jongkok atau berdiri				
5.	Menjelaskan keuntungan posisi berbaring miring ke kiri - Lebih nyaman dan efektif untuk meneran - Membantu penurunan kepala janin lebih dalam ke panggul - Memudahkan ibu untuk beristirahat diantara kontraksi - Mengurangi resiko terjadinya robekan perineum - Meningkatkan oksigenasi bayi  Gambar 2.4 Posisi berbaring miring ke kiri				
6.	Menjelaskan kerugian posisi terlentang - Tidak dianjurkan - Dapat menyebabkan gangguan pernafasan - Mengurangi mobilisasi ibu - Menyebabkan waktu persalinan menjadi lama				
C. Terminasi					
1.	Melakukan evaluasi tindakan				14
2.	Berpamitan dengan pasien				
3.	Membereskan dan mengembalikan alat				
4.	Mencuci tangan				
5.	Melaksanakan secara sistematis				
6.	Menggunakan bahasa yang mudah dimengerti				
7.	Mendokumentasikan hasil tindakan				
Total Score					
Nilai Akhir = Jumlah score yang diperoleh: Total Score keseluruhan x 100					
Tanda Tangan Penguji					
Referensi : Yulizawati, dkk. 2019. Buku Ajar Asuhan Kebidanan Pada Persalinan. Sidoarjo: Pustaka Indomedika					

E. Daftar Pustaka

- Afandi, B. (2017) *Asuhan Persalinan Normal*. Jakarta: JNKP-KR.
- Haeriah, M. (2021) *Efektifitas Aplikasi Asuhan Persalinan Normal Berbasis Web Sebagai Media Pembelajaran Mahasiswa Kebidanan*. Makassar. Available at: <http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/3141/>.
- Kusumastiwi, dkk (2022) *Buku Panduan Ketrampilan Medik Semester VI*. Yogyakarta.
- Pusat, P.I. (2016) *Buku Acuan Midwifery Update*. Jakarta: Pengurus IBI Pusat.
- RI, D. (2017) *Profil Kesehatan Tahun 2017*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- S.H., M. (2019) 'Normal Labor and Delivery', *medicine* [Preprint]. Available at: <https://emedicine.medscape.com/article/260036-overview#showall>.
- Selasih Putri Isnawati Hadi, Sri Kuswanti, Cipta Pramana, A. (2020) *Modul Praktikum Asuhan Kebidanan Persalinan dan Bayi Baru Lahir*. Yogyakarta.
- Thornton, J. M., Browne, B., & Ramphul, M. (2019) 'Mechanisms and management of normal labour', *Obstetrics, Gynaecology & Reproductive Medicine* [Preprint]. Available at: <https://doi.org/10.1016/j.ogrm.2019.12.002>.
- Yulizawati et al. (2019) *Buku Asuhan Kelahiran, Indomedika Pustaka*.

F. Glosarium

C

Cephalopelvic disproportion Ukuran kepala janin tidak sesuai dengan ukuran panggul ibu, di mana kondisi ini merupakan kontraindikasi absolut untuk melahirkan normal melalui vagina

H

HIS: Kekuatan nyeri fisiologis yang muncul pada ibu bersalin.

I

inform consent : penyampaian informasi dari dokter, maupun tenaga medis lainnya, kepada pasien sebelum suatu tindakan medis dilakukan

inform choice : suatu keputusan yang dibuat setelah melalui pertimbangan matang terhadap bukti-bukti ilmiah yang relevan

M

Mal presentasi : kondisi di mana bagian anatomi janin yang masuk terlebih dahulu ke pelvic inlet adalah bagian lain selain vertex

Makrosomia : kondisi ketika bayi terlahir dengan ukuran yang besar, yakni sekitar 4 kg hingga 4,5 kg, atau bahkan lebih

S

Sectio caesarea : salah satu tindakan persalinan untuk mengeluarkan bayi melalui sayatan pada abdomen/ laparotomi dan uterus/ histerotomi

Simfisis : sendi penghubung 2 tulang pubis

BAB III

PRAKTIKUM ASUHAN PERSALINAN NORMAL

Irfana Tri Wijayanti, S.Si.T., M.Kes., M.Keb.



A. Deskripsi

Menurut ketua komite Ilmiah *International Conference on Indonesia Family Planning and Reproductive Health (ICIFPRH)*, Meiwita Budhiharsanam, hingga tahun 2019 AKI di Indonesia masih tinggi, yaitu 305 per 100.000 kelahiran hidup. Berbagai upaya untuk pengurangan AKI telah dilakukan, diantaranya adalah melakukan pertolongan dengan asuhan persalinan normal (APN).

Pada bab ini mahasiswa mempelajari tentang konsep dan prosedur tindakan pertolongan asuhan persalinan normal (APN) yang didasari pada pambaharuan kelimuan.

B. Tujuan Pembelajaran**1. Tujuan Pembelajaran Umum**

Setelah mempelajari praktikum ini mahasiswa mampu mempraktikkan asuhan persalinan normal (APN)

2. Tujuan Pembelajaran Khusus

Setelah mempelajari materi ini diharapkan:

- a. Mahasiswa mampu memahami tentang asuhan persalianan normal (APN)
- b. Mahasiswa mampu mempraktikan pertolongan asuhan persalinan normal (APN)
- c.

C. Uraian Materi**1. Definisi**

Asuhan persalinan normal merupakan asuhan yang bersih dan aman selama persalinan dan setelah bayi lahir, serta upaya pencegahan komplikasi, terutama perdarahan pasca persalinan, hipotermia, dan asfiksia bayi baru lahir.

Menurut (Yulizawati *et al.*, 2019) Asuhan persalinan normal adalah tindakan mengeluarkan janin dan plasenta yang cukup bulan kehamilan dan berlangsung secara spontan melalui jalan lahir tanpa intervensi alat. Selain itu APN dapat memberikan pertolongan normal yang bersih dan aman serta mencegah terjadinya komplikasi.

2. Tujuan

Tujuan asuhan persalinan normal adalah tercapainya kelangsungan hidup dan kesehatan yang tinggi bagi ibu serta bayinya, melalui upaya yang terintegrasi dan lengkap tanpa intervensi alat sehingga prinsip keamanan dan kualitas layanan dapat terjaga. Pendekatan seperti ini berarti bahwa: dalam

asuhan persalinan normal harus ada alasan yang kuat dan bukti manfaat apabila akan melakukan intervensi terhadap jalannya proses persalinan yang fisiologis/alamiah (Afandi, 2017).

Berdasarkan pada (Afandi, 2017), tujuan dari tindakan pertolongan asuhan persalinan normal yaitu :

- a. Menurunkan angka mortalitas ibu dan bayi
- b. Menurunkan angka kematian ibu
- c. Memberikan pertolongan persalinan yang bersih dan aman
- d. Memberikan pertolongan persalinan dengan baik dan benar

3. Indikasi

Berdasarkan Thornton, J. M., Browne, B., & Ramphul (2019) Indikasi dilakukan pertolongan asuhan persalinan normal pada ibu dan janin sebagai berikut:

- a. Ibu dalam masa inpartu
- b. Hasil pemeriksaan panggul normal
- c. Hasil pemeriksaan janin normal

4. Kontrak Indikasi

Menurut (Thornton, J. M., Browne, B., & Ramphul, 2019), (S.H., 2019), Kontra indikasi dilakukan pertolongan asuhan persalinan normal pada ibu dan janin sebagai berikut:

- a. Kontrak indikasi dari faktor ibu
 - 1) Cephalopelvic disproportion
Ukuran kepala janin tidak sesuai dengan ukuran panggul ibu, di mana kondisi ini merupakan kontraindikasi absolut untuk melahirkan normal melalui vagina
 - 2) Plasenta abnormal
Plasenta previa baik komplit maupun parsial dan plasenta akreta, di mana kondisi ini adalah kontraindikasi relatif sehingga dengan beberapa pertimbangan dapat dilakukan persalinan pervaginam dengan risiko perdarahan postpartum
 - 3) Prolapsus tali pusat
Pada kondisi ini hindari manipulasi pada tali pusat dan segera dilakukan persalinan secara sectio caesarea
 - 4) Vaginal birth after cesaeran section
Dapat meningkatkan risiko ruptur uteri, kondisi ini masih menjadi perdebatan para ahli sehingga terdapat beberapa kriteria pasien untuk melakukan
 - 5) Penyakit infeksi menular seksual

Penyakit menular yang dimaksud seperti herpes genital pada trimester akhir kehamilan, karena dapat terjadi transmisi infeksi ke bayi yang dilahirkan pervaginam

6) HIV

Ibu hamil dengan HIV memiliki risiko penularan pervaginam ke bayi jika *viral load* pasien >1000 kopi/mL, tetapi jika ibu hamil mendapat terapi *antiretroviral* dengan *viral load* <1000 kopi/mL maka dapat melahirkan pervaginam

7) Miopia Tinggi

Wanita hamil dengan miopia tinggi yang disertai kondisi makula dan retina yang abnormal sebaiknya menghindari persalinan normal, karena risiko komplikasi *ablatio retinal*.

b. Kontrak indikasi dari faktor janin

1) Mal presentasi

Pada mal presentasi pada janin meliputi seperti presentasi dahi, wajah, bokong /sungsang, atau lintang sebaiknya tidak dilahirkan pervaginam untuk menurunkan risiko mortalitas bayi dan komplikasi distosia

2) Makrosomia

Makrosomia atau bayi besar, yaitu bayi dengan berat lahir lebih dari 4000 gram biasanya disarankan untuk melakukan persalinan secara *sectio caesarea* untuk mencegah komplikasi distosia

3) Janin kembar

Untuk melakukan persalinan normal, di mana dapat dilahirkan pervaginam tergantung dari jumlah janin, presentasi janin, perkiraan berat badan janin, kondisi janin di dalam rahim, kondisi ibu, dan tenaga ahli saat melakukan pertolongan persalinan

5. Hal-hal yang diperhatikan

Hal – hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan pertolongan asuhan persalinan normal (APN) adalah sebagai berikut:

- a. Menyiapkan inform consent
- b. Menyiapkan inform choice
- c. Menjaga privasi pasien
- d. Menjaga Kesterilan alat
- e. Tindakan dilakukan sesuai dengan tahapan prosedur

6. Persiapan Alat

Menurut buku (Pusat, 2016), persiapan alat dan bahan yang dibutuhkan untuk melakukan pertolongan persalinan normal adalah sebagai berikut:

- Alat Pelindung diri
- Partus set di dalam bak instrumen steril yang berpenutup
- Metlin
- Set Hecting
- Alat pengukur tanda vital
- Spuit 3 cc 2 buah
- Vitamin K 0,5 cc
- Doppler atau monoaural
- Bengkok
- Ember tempat alat tenun kotor
- Tempat sampah
- Kantong plastik
- Duk steril
- Kapas detol dalam kom
- Betadine dalam kom
- Vaksin hepatitis B uniject
- Abocath no. 16-18
- Set resusitasi
- Jam yang mempunyai jarum detik
- Oksitosin 10 unit 4 ampul
- Ergometrin 2 ampul
- Benang Catgut
- Lidokain 1% atau 2%
- Aquades
- Salep mata bayi (tetrasiklin 1%, eritromisin 0,5%)
- Kasa steril
- Klorin 0,5%
- Larutan RL 3 kolf
- Partograf
- Formulir rujukan
- Alat tulis

Perlengkapan ibu dan bayi

- a. Kain bersih 3 lembar
- b. Pembalut pakaian ibu
- c. Pakaian bayi
- d. Popok
- e. Kain flanel 3 buah
- b. Handuk 2 buah
- c. Topi bayi

7. Prosedur Tindakan dan Rating scale Tindakan

Menurut (Pusat, 2016), prosedur tindakan dan rating scale pertolongan asuhan persalinan normal (APN) sebagai berikut:

Mengenali Gejala Dan Tanda Kala Dua

- 1) Mendengar dan melihat tanda kala dua persalinan
 - a) Ibu merasa ada dorongan kuat dan meneran
 - b) Ibu merasakan tekanan yang semakin meningkat pada rektum dan vagina
 - c) Perineum tampak menonjol
 - d) Vulva dan sfingter ani membuka

Menyiapkan Pertolongan Persalinan

- 2) Pastikan kelengkapan peralatan, bahan dan obat-obatan esensial untuk menolong persalinan dan menatalaksana komplikasi segera pada ibu dan bayi baru lahir. Untuk asuhan bayi baru lahir atau resusitasi siapkan:
 - a) Tempat datar, rata, bersih, kering, dan hangat
 - b) 3 handuk / kain bersih dan kering (termasuk ganjal bahu bayi)
 - c) Alat penghisap lender
 - d) Lampu sorot 60 watt dengan jarak 60 cm dari tubuh bayi

Untuk ibu:

- a) Menggelar kain di perut bawah ibu
 - b) Menyiapkan oksitosin 10 unit
 - c) Alat suntik steril sekali pakai di dalam partus set
- 3) Pakai celemek plastik atau dari bahan yang tidak tembus cairan
- 4) Melepaskan dan menyimpan semua perhiasan yang dipakai, cuci tangan dengan sabun dan air bersih mengalir kemudian keringkan tangan dengan tissue atau handuk pribadi yang bersih dan kering
- 5) Pakai sarung tangan DTT pada tangan yang akan digunakan untuk periksa dalam
- 6) Masukkan oksitosin ke dalam tabung suntik (gunakan tangan yang menggunakan sarung tangan DTT atau steril dan pastikan tidak terjadi kontaminasi pada alat suntik)

Memastikan Pembukaan Lengkap Dan Keadaan Janin

- 7) Membersihkan vulva dan perineum, menyekanya dengan hati-hati dari anterior (depan) ke posterior (belakang) menggunakan kapas atau kassa yang dibasahi air DTT
 - a) Jika introitus vagina, perineum atau anus terkontaminasi tinja, bersihkan dengan seksama dari arah depan ke belakang
 - b) Buang kapas atau kassa pembersih (terkontaminasi) dalam wadah yang tersedia
 - c) Jika terkontaminasi, lakukan dekontaminasi, lepaskan dan rendam sarung tangan tersebut dalam larutan klorin 0,5% Langkah # 9, pakai sarung tangan DTT / Steril untuk melaksanakan langkah lanjutan
- 8) Lakukan periksa dalam untuk memastikan pembukaan lengkap
 - a) Bila selaput ketuban masih utuh saat pembukaan sudah lengkap maka lakukan amniotomi
- 9) Dekontaminasi sarung tangan (celupkan tangan yang masih memakai sarung tangan kedalam larutan klorin 0,5%, lepaskan sarung tangan dalam keadaan terbalik, dan rendam dalam larutan klorin 0,5% selama

10 menit). Cuci kedua tangan setelah sarung tangan dilepaskan. Tutup kembali partus set

- 10) Periksa denyut jantung janin (DJJ) setelah kontraksi uterus mereda (relaksasi) untuk memastikan DJJ masih dalam batas normal (120-160x/menit)
 - a) Mengambil tindakan yang sesuai jika DJJ tidak normal
 - b) Mendokumentasikan hasil-hasil pemeriksaan dalam, DJJ, semua temuan pemeriksaan dan asuhan yang diberikan ke dalam partograf

Menyiapkan Ibu Dan Keluarga Untuk Membantu Proses Meneran

- 11) Beritahukan pada ibu bahwa pembukaan sudah lengkap dan keadaan janin cukup baik, kemudian bantu ibu menemukan posisi yang nyaman dan sesuai dengan keinginannya.
 - a) Tunggu hingga timbul kontraksi atau rasa ingin meneran, lanjutkan pemantauan kondisi dan kenyamanan ibu dan janin (ikuti pedoman penatalaksanaan fase aktif) dan dokumentasikan semua temuan yang ada.
 - b) Jelaskan pada anggota keluarga tentang peran mereka untuk mendukung dan memberi semangat pada ibu dan meneran secara benar
- 12) Minta keluarga membantu menyiapkan posisi meneran jika ada rasa ingin meneran atau kontraksi yang kuat. Pada kondisi itu, ibu diposisikan setengah duduk atau posisi lain yang diinginkan dan pastikan ibu merasa nyaman
- 13) Laksanakan bimbingan meneran pada saat ibu merasa ingin meneran atau timbul kontraksi yang kuat:
 - a) Bimbing ibu agar dapat meneran secara benar dan efektif
 - b) Dukung dan beri semangat pada saat meneran dan perbaiki cara meneran apabila caranya tidak sesuai
 - c) Bantu ibu mengambil posisi yang nyaman sesuai pilihannya (kecuali posisi berbaring terlentang dalam waktu yang lama)
 - d) Anjurkan ibu untuk beristirahat diantara kontraksi
 - e) Anjurkan keluarga memberi dukungan dan semangat untuk ibu
 - f) Berikan cukup asupan cairan per-oral (minum)
 - g) Menilai DJJ setiap kontraksi uterus selesai
 - h) Segera rujuk jika bayi belum atau tidak akan segera lahir setelah pembukaan lengkap dan dipimpin meneran ≥ 120 menit (2 jam) pada primigravida atau ≥ 60 menit (1 jam) pada multigravida

- 14) Anjurkan ibu untuk berjalan, berjongkok atau mengambil posisi yang nyaman, jika ibu belum merasa ada dorongan untuk meneran dalam selang waktu 60 menit

Persiapan Untuk Melahirkan Bayi

- 15) Letakkan handuk bersih (untuk mengeringkan bayi) di perut bawah ibu, jika kepala bayi telah membuka vulva dengan diameter 5-6cm
16) Letakkan kain bersih yang dilipat 1/3 bagian sebagai alas bokong ibu
17) Buka tutup partus set dan periksa kembali kelengkapan peralatan dan bahan
18) Pakai sarung tangan DTT/Steril pada kedua tangan

Pertolongan Untuk Melahirkan Bayi

Lahirnya Kepala

- 19) Setelah tampak kepala bayi dengan diameter 5-6 membuka vulva maka lindungi perineum dengan satu tangan yang dilapisi dengan kain bersih dan kering, tangan yang lain menahan belakang kepala untuk mempertahankan posisi fleksi dan membantu lahirnya kepala. Anjurkan ibu meneran secara efektif atau bernafas cepat dan dangkal.
20) Periksa kemungkinan adanya lilitan tali pusat (ambil tindakan yang sesuai jika hal itu terjadi), segera lanjutkan proses kelahiran bayi, perhatikan!
a) Jika tali pusat melilit leher secara longgar, lepaskan lilitan lewat bagian atas bayi
b) Jika tali pusat melilit leher secara kuat, klem tali pusat di dua tempat dan potong tali pusat diantara dua klem tersebut
21) Setelah kepala lahir, tunggu putaran paksi luar yang berlangsung secara spontan.

Lahirnya Bahu

- 22) Setelah putaran paksi luar selesai, pegang kepala secara biparietal. Anjurkan ibu untuk meneran saat kontraksi. Dengan lembut gerakkan kepala ke arah bawah dan distal hingga bahu depan muncul di bawah arkus pubis dan kemudian gerakan ke arah atas dan distal untuk melahirkan bahu belakang.

Lahirnya Badan dan Tungkai

- 23) Setelah kedua bahu lahir, satu tangan menyangga kepala dan bahu belakang, tangan yang lain menelusuri dan memegang lengan dan siku bayi sebelah atas.
24) Setelah tubuh dan lengan lahir, penelusuran tangan atas berlanjut ke punggung, bokong, tungkai dan kaki. Pegang kedua mata kaki (masukkan telunjuk diantara kedua kaki dan pegang kedua kaki dengan

melingkarkan ibu jari pada satu sisi dan jari-jari lainnya pada sisi yang lain agar bertemu dengan jari telunjuk).

Asuhan Bayi Baru Lahir

25) Lakukan penilaian (selintas) :

- a) Apakah bayi cukup bulan?
- b) Apakah bayi menangis kuat dan/atau bernapas tanpa kesulitan?
- c) Apakah bayi bergerak dengan aktif?

Bila salah satu jawaban adalah “TIDAK” lanjut ke langkah resusitasi pada bayi baru lahir dengan asfiksia. Bila semua jawaban adalah “YA”, lanjut ke-26.

26) Keringkan tubuh bayi

Keringkan tubuh bayi mulai dari muka, kepala dan bagian tubuh lainnya (kecuali kedua tangan) tanpa membersihkan verniks. Ganti handuk basah dengan handuk/kain yang kering. Pastikan bayi dalam posisi dan kondisi aman di perut ibu bagian bawah ibu.

27) Periksa kembali uterus untuk memastikan hanya satu bayi yang lahir (hamil tunggal) dan bukan kehamilan ganda (gemeli).

28) Beritahu ibu bahwa ia akan disuntik oksitosin agar uterus berkontraksi baik.

29) Dalam waktu 1 menit setelah bayi lahir, suntikan oksitosin 10 unit (intramuskular) di 1/3 distal lateral paha (lakukan aspirasi sebelum menyuntikkan oksitosin).

30) Dalam waktu 2 menit setelah bayi lahir, jepit tali pusat dengan klem kira-kira 2-3 cm dari pusat bayi. Gunakan jari telunjuk dan jari tengah tangan yang lain untuk mendorong isi tali pusat ke arah ibu dan klem tali pusat pada sekitar 2 cm distal dari klem pertama.

31) Pemotongan dan pengikatan tali pusat

- a) Dengan satu tangan, pegang tali pusat yang telah dijepit (lindungi perut bayi) dan lakukan pengguntingan tali pusat di antara 2 klem tersebut.
- b) Ikat tali pusat dengan benang DTT/Steril pada satu sisi kemudian lingkarkan lagi benang tersebut dan ikat tali pusat dengan simpul kunci pada sisi lainnya.
- c) Lepaskan klem dan masukkan dalam wadah yang telah disediakan.

32) Letakkan bayi tengkurap di dada ibu untuk kontak kulit ibu. Luruskan bahu bayi sehingga dada bayi menempel di dada ibunya. Usahan kepala bayi berada di antara payudara ibu dengan posisi lebih rendah dari putting susu atau areola mammae ibu.

- a) Selimuti ibu-bayi dengan kain kering dan hangat, pasang topi di kepala bayi.
- b) Biarkan bayi melakukan kontak kulit ke kulit di dada ibu paling sedikit 1 jam.
- c) Sebagian besar bayi akan berhasil melakukan inisiasi menyusui dini dalam waktu 30-60 menit. Menyusui untuk pertama kali akan berlangsung sekitar 10-15 menit. Bayi cukup menyusui dari satu payudara.
- d) Biarkan bayi berada di dada ibu selama 1 jam walaupun bayi sudah berhasil menyusui

Manajemen Aktif Kala Tiga Persalinan

- 33) Pindahkan klem tali pusat hingga berjarak 5-10 cm dari vulva.
- 34) Letakkan satu tangan di atas kain pada perut bawah ibu (di atas *simfisis*), untuk mendeteksi kontraksi. Tangan lain memegang klem untuk menegangkan tali pusat.
- 35) Setelah uterus berkontraksi, tegangkan tali pusat ke arah bawah sambil tangan yang lain mendorong uterus ke arah belakang atas (*dorso-kranial*) secara hati-hati (untuk mencegah *inversion uteri*). Jika plasenta tidak lahir setelah 30-40 detik, hentikan penegangan tali pusat dan tunggu hingga timbul kontraksi berikutnya dan ulangi kembali prosedur di atas.
 - a) Jika uterus tidak segera berkontraksi, minta ibu, suami atau anggota keluarga untuk melakukan stimulasi puting susu.

Mengeluarkan plasenta

- 36) Bila pada penekanan bagian bawah dinding depan uterus ke arah dorsal ternyata diikuti dengan pergeseran tali pusat ke arah distal maka lanjutkan dorongan ke arah kranial hingga plasenta dapat dilahirkan.
 - a) Ibu boleh meneran tetapi tali pusat hanya ditegangkan
 - b) (jangan ditarik secara kuat terutama jika uterus tidak berkontraksi) sesuai dengan sumbu jalan lahir (ke arah bawah-sejajar lantai-atas).
 - c) Jika tali pusat bertambah panjang, pindahkan klem hingga berjarak sekitar 5-10 cm dari vulva dan lahirkan plasenta.
 - d) Jika plasenta tidak lepas setelah 15 menit menegangkan tali pusat :
 - Ulangi pemberian oksitosin 10 unit IM.
 - Lakukan kateterisasi (gunakan teknik aseptik) jika kandung kemih penuh.
 - Minta keluarga untuk menyiapkan rujukan.

- Ulangi tekanan dorso-kranial dan penegangan tali pusat 15 menit berikutnya.
- Jika plasenta tidak lahir 30 menit sejak bayi lahir atau terjadi perdarahan maka segera lakukan tindakan plasenta manual.

37) Saat plasenta muncul di introitus vagina, lahirkan plasenta dengan kedua tangan. Pegang dan putar plasenta hingga selaput ketuban terpilin kemudian lahirkan dan tempatkan plasenta pada wadah yang telah disediakan.

- a) Jika selaput ketuban robek, pakai sarung tangan DTT atau steril untuk melakukan eksplorasi sisa selaput kemudian gunakan jari-jari tangan atau klem ovum DTT/Steril untuk mengeluarkan selaput yang tertinggal.

Rangsangan Taktil (Massase) uterus

38) Segera setelah plasenta dan selaput ketuban lahir, lakukan massase uterus, letakkan telapak tangan di fundus dan lakukan massase dengan gerakan melingkar dengan lembut hingga uterus berkontraksi (fundus teraba keras)

- a) Lakukan tindakan yang diperlukan (*Kompresi Bimanual Internal*, *Kompresi Aorta Abdominalis*, Tampon Kondom-Kateter) jika uterus tidak berkontraksi dalam 15 detik setelah rangsangan taktil/ massase

Menilai Perdarahan

39) Periksa kedua sisi plasenta (*maternal-fetal*) pastikan plasenta telah dilahirkan lengkap. Masukkan plasenta ke dalam kantung plastil atau tempat khusus.

40) Evaluasi kemungkinan laserasi pada vagina dan perineum. Lakukan penjahitan bila terjadi laserasi derajat 1 dan 2 yang menimbulkan perdarahan.

Bila ada robekan yang menimbulkan perdarah aktif, segera lakukan penjahitan.

Asuhan Pasca Persalinan

41) Pastikan uterus berkontraksi dengan baik dan tidak terjadi perdarahan pervaginam.

42) Pastikan kandung kemih kosong. Jika penuh lakukan kateterisasi.

Evaluasi

43) Celupkan tangan yang masih memakai sarung tangan kedalam larutan klorin 0,5%, bersihkan noda darah dan cairan tubuh dan bilas di air DTT tanpa melepas sarung tangan, kemudian keringkan dengan handuk

- 44) Ajarkan ibu/ keluarga cara melakukan masase uterus dan menilai kontraksi.
- 45) Memeriksa nadi ibu dan pastikan keadaan umum ibu baik.
- 46) Evaluasi dan estimasi jumlah kehilangan darah.
- 47) Pantau keadaan bayi dan pastikan bahwa bayi bernafas dengan baik (40-60 kali/menit)
 - a) Jika bayi sulit bernapas, merintih atau retraksi, diresusitasi dan segera merujuk ke rumah sakit.
 - b) Jika bayi napas terlalu cepat atau sesak napas, segera rujuk ke RS Rujukan
 - c) Jika kaki teraba dingin, pastikan ruangan hangat. lakukan kembali kontak kulit ibu-bayi dan hangatkan ibu-bayi dalam satu selimut.

Kebersihan dan Keamanan

- 48) Tempatkan semua peralatan bekas pakai dalam larutan klorin 0,5% untuk dekontaminasi (10 menit). Cuci dan bilas peralatan setelah didekontaminasi.
- 49) Buang bahan-bahan yang terkontaminasi ke tempat sampah yang sesuai.
- 50) Bersihkan ibu dari paparan darah dan cairan tubuh dengan menggunakan air DTT. Bersihkan cairan ketuban, lendir dan darah di ranjang atau sekitar ibu berbaring.

Bantu ibu memakai pakaian yang bersih dan kering.

- 51) Pastikan ibu merasa nyaman. Bantu ibu memberikan ASI. Anjurkan keluarga untuk memberi ibu makan dan minum yang diinginkannya.
- 52) Dekontaminasi tempat bersalin dengan larutan klorin 0,5%.
- 53) Celupkan tangan yang masih memakai sarung tangan ke dalam larutan klorin 0,5% lepas sarungkan sarung tangan dalam keadaan terbalik dan rendam dalam larutan klorin 0,5% selama 10 menit.
- 54) Cuci tangan dengan sabun dan air mengalir kemudian keringkan tangan dengan tissue atau handuk pribadi yang bersih dan kering.
- 55) Pakai sarung tangan bersih/ DTT untuk melakukan pemeriksaan fisik bayi.
- 56) Lakukan pemeriksaan fisik bayi baru lahir. Pastikan kondisi bayi baik. Pernafasan normal (40-60 kali/menit) dan temperatur tubuh normal (36,5-37,5°C) setiap 15 menit.
- 57) Setiap 1 jam pemberian vitamin K, berikan suntikan Hepatitis B di paha kanan bawah lateral. Letakkan bayi di dalam jangkauan ibu agar sewaktu-waktu dapat disusukan.

58) Lepaskan sarung tangan dalam keadaan terbalik dan rendam didalam larutan klorin 0,5% selama 10 menit.

59) Cuci tangan dengan sabun dan air mengalir kemudian keringkan dengan tissue atau handuk pribadi yang bersih dan kering.

Dokumentasi

60) Lengkapi partograf (halaman depan dan belakang) periksa tanda vital dan asuhan kala IV persalinan.

D. Rating Scale Belajar Keterampilan

ASUHAN PERSALINAN NORMAL (APN)

Nilailah setiap langkah/kinerja yang diamati dengan menggunakan skala sbb:

- 0** = Bila Langkah atau tugas tidak dikerjakan
- 1** = Langkah dilakukan tetapi tidak sempurna
- 2** = Langkah dilakukan dengan sempurna

No	Komponen	Nilai			
		0	1	2	Score
A. Sikap					
1.	Menyapa klien dengan ramah dan sopan				10
2.	Memperkenalkan diri kepada klien				
3.	Teruji menjaga privacy klien				
4.	Percaya diri				
5.	Teruji menjelaskan maksud dan tujuan				
B. Isi					
	Tanda Gejala dan Kala II				120
1.	Mendengar dan melihat tanda kala dua persalinan a. Ibu merasa ada dorongan kuat dan meneran b. Ibu merasakan tekanan yang semakin meningkat pada rektum dan vagina c. Perineum tampak menonjol d. Vulva dan sfingter ani membuka				
	Menyiapkan Pertolongan Persalinan				
2.	Pastikan kelengkapan peralatan, bahan dan obat-obatan esensial untuk menolong persalinan dan menatalaksana komplikasi segera pada ibu dan bayi baru lahir. Untuk asuhan bayi baru lahir atau resusitasi siapkan: a. Tempat datar, rata, bersih, kering, dan hangat b. 3 handuk / kain bersih dan kering (termasuk ganjal bahu bayi) c. Alat penghisap lender d. Lampu sorot 60 watt dengan jarak 60 cm dari tubuh bayi Untuk ibu: a. Menggelar kain di perut bawah ibu b. Menyiapkan oksitosin 10 unit c. Alat suntik steril sekali pakai di dalam partus set				

No	Komponen	Nilai			
		0	1	2	Score
3.	Pakai celemek plastik atau dari bahan yang tidak tembus cairan				
4.	Melepaskan dan menyimpan semua perhiasan yang dipakai, cuci tangan dengan sabun dan air bersih mengalir kemudian keringkan tangan dengan tissue atau handuk pribadi yang bersih dan kering				
5.	Pakai sarung tangan DTT pada tangan yang akan digunakan untuk periksa dalam				
6.	Masukkan oksitosin ke dalam tabung suntik (gunakan tangan yang menggunakan sarung tangan DTT atau steril dan pastikan tidak terjadi kontaminasi pada alat suntik)				
	Memastikan Pembukaan Lengkap Dan Keadaan Janin				
7.	Membersihkan vulva dan perineum, menyekanya dengan hati-hati dari anterior (depan) ke posterior (belakang) menggunakan kapas atau kassa yang dibasahi air DTT a. Jika introitus vagina, perineum atau anus terkontaminasi tinja, bersihkan dengan seksama dari arah depan ke belakang b. Buang kapas atau kassa pembersih (terkontaminasi) dalam wadah yang tersedia c. Jika terkontaminasi, lakukan dekontaminasi, lepaskan dan rendam sarung tangan tersebut dalam larutan klorin 0,5% Langkah # 9, pakai sarung tangan DTT / Steril untuk melaksanakan langkah lanjutan				
8.	Lakukan periksa dalam untuk memastikan pembukaan lengkap a. Bila selaput ketuban masih utuh saat pembukaan sudah lengkap maka lakukan amniotomi				
9.	Dekontaminasi sarung tangan (celupkan tangan yang masih memakai sarung tangan kedalam larutan klorin 0,5%, lepaskan sarung tangan dalam keadaan terbalik, dan rendam dalam larutan klorin 0,5% selama 10 menit). Cuci kedua tangan setelah sarung tangan dilepaskan. Tutup kembali partus set				
10.	Periksa denyut jantung janin (DJJ) setelah kontraksi uterus mereda (relaksasi) untuk memastikan DJJ masih dalam batas normal (120-160x/ menit) a. Mengambil tindakan yang sesuai jika DJJ tidak normal b. Mendokumentasikan hasil-hasil periksa dalam, DJJ, semua temuan pemeriksaan dan asuhan yang diberikan ke dalam partograf				
	Menyiapkan Ibu Dan Keluarga Untuk Membantu Proses Meneran				
11.	Beritahukan pada ibu bahwa pembukaan sudah lengkap dan keadaan janin cukup baik, kemudian bantu ibu				

No	Komponen	Nilai			
		0	1	2	Score
	menemukan posisi yang nyaman dan sesuai dengan keinginannya. a. Tunggu hingga timbul kontraksi atau rasa ingin meneran, lanjutkan pemantauan kondisi dan kenyamanan ibu dan janin (ikuti pedoman penatalaksanaan fase aktif) dan dokumentasikan semua temuan yang ada. b. Jelaskan pada anggota keluarga tentang peran mereka untuk mendukung dan memberi semangat pada ibu dan meneran secara benar				
12.	Minta keluarga membantu menyiapkan posisi meneran jika ada rasa ingin meneran atau kontraksi yang kuat. Pada kondisi itu, ibu diposisikan setengah duduk atau posisi lain yang diinginkan dan pastikan ibu merasa nyaman				
13.	Laksanakan bimbingan meneran pada saat ibu merasa ingin meneran atau timbul kontraksi yang kuat: a. Bimbing ibu agar dapat meneran secara benar dan efektif b. Dukung dan beri semangat pada saat meneran dan perbaiki cara meneran apabila caranya tidak sesuai c. Bantu ibu mengambil posisi yang nyaman sesuai pilihannya (kecuali posisi berbaring terlentang dalam waktu yang lama) d. Anjurkan ibu untuk beristirahat diantara kontraksi e. Anjurkan keluarga memberi dukungan dan semangat untuk ibu f. Berikan cukup asupan cairan per-oral (minum) g. Menilai DJJ setiap kontraksi uterus selesai h. Segera rujuk jika bayi belum atau tidak akan segera lahir setelah pembukaan lengkap dan dipimpin meneran ≥ 120 menit (2 jam) pada primigravida atau ≥ 60 menit (1 jam) pada multigravida				
14.	Anjurkan ibu untuk berjalan, berjongkok atau mengambil posisi yang nyaman, jika ibu belum merasa ada dorongan untuk meneran dalam selang waktu 60 menit				
	Persiapan Untuk Melahirkan Bayi				
15.	Letakkan handuk bersih (untuk mengeringkan bayi) di perut bawah ibu, jika kepala bayi telah membuka vulva dengan diameter 5-6cm				
16.	Letakkan kain bersih yang dilipat 1/3 bagian sebagai alas bokong ibu				
17.	Buka tutup partus set dan periksa kembali kelengkapan peralatan dan bahan				
18.	Pakai sarung tangan DTT/Steril pada kedua tangan				
	Pertolongan Untuk Melahirkan Bayi Lahirnya Kepala				

No	Komponen	Nilai			
		0	1	2	Score
19.	Setelah tampak kepala bayi dengan diameter 5-6 membuka vulva maka lindungi perineum dengan satu tangan yang dilapisi dengan kain bersih dan kering, tangan yang lain menahan belakang kepala untuk mempertahankan posisi fleksi dan membantu lahirnya kepala. Anjurkan ibu meneran secara efektif atau bernafas cepat dan dangkal.				
20.	Periksa kemungkinan adanya lilitan tali pusat (ambil tindakan yang sesuai jika hal itu terjadi), segera lanjutkan proses kelahiran bayi, perhatikan! a. Jika tali pusat melilit leher secara longgar, lepaskan lilitan lewat bagian atas bayi b. Jika tali pusat melilit leher secara kuat, klem tali pusat di dua tempat dan potong tali pusat diantara dua klem tersebut				
21.	Setelah kepala lahir, tunggu putaran paksi luar yang berlangsung secara spontan.				
	Lahirnya Bahu				
22.	Setelah putaran paksi luar selesai, pegang kepala secara biparietal. Anjurkan ibu untuk meneran saat kontraksi. Dengan lembut gerakkan kepala ke arah bawah dan distal hingga bahu depan muncul di bawah arkus pubis dan kemudian gerakan ke arah atas dan distal untuk melahirkan bahu belakang.				
	Lahirnya Badan dan Tungkai				
23.	Setelah kedua bahu lahir, satu tangan menyangga kepala dan bahu belakang, tangan yang lain menelusuri dan memegang lengan dan siku bayi sebelah atas.				
24.	Setelah tubuh dan lengan lahir, penelusuran tangan atas berlanjut ke punggung, bokong, tungkai dan kaki. Pegang kedua mata kaki (masukkan telunjuk diantara kedua kaki dan pegang kedua kaki dengan melingkarkan ibu jari pada satu sisi dan jari-jari lainnya pada sisi yang lain agar bertemu dengan jari telunjuk).				
	Asuhan Bayi Baru Lahir				
25.	Lakukan penilaian (selintas) : a. Apakah bayi cukup bulan? b. Apakah bayi menangis kuat dan/atau bernapas tanpa kesulitan? c. Apakah bayi bergerak dengan aktif? Bila salah satu jawaban adalah "TIDAK" lanjut ke langkah resusitasi pada bayi baru lahir dengan asfiksia. Bila semua jawaban adalah "YA", lanjut ke-26.				
26.	Keringkan tubuh bayi Keringkan tubuh bayi mulai dari muka, kepala dan bagian tubuh lainnya (kecuali kedua tangan) tanpa membersihkan verniks. Ganti handuk basah dengan				

No	Komponen	Nilai			
		0	1	2	Score
	handuk/kain yang kering. Pastikan bayi dalam posisi dan kondisi aman di perut ibu bagian bawah ibu.				
27.	Periksa kembali uterus untuk memastikan hanya satu bayi yang lahir (hamil tunggal) dan bukan kehamilan ganda (gemeli).				
28.	Beritahu ibu bahwa ia akan disuntik oksitosin agar uterus berkontraksi baik.				
29.	Dalam waktu 1 menit setelah bayi lahir, suntikan oksitosin 10 unit (intramuskular) di 1/3 distal lateral paha (lakukan aspirasi sebelum menyuntikkan oksitosin).				
30.	Dalam waktu 2 menit setelah bayi lahir, jepit tali pusat dengan klem kira-kira 2-3 cm dari pusat bayi. Gunakan jari telunjuk dan jari tengah tangan yang lain untuk mendorong isi tali pusat ke arah ibu dan klem tali pusat pada sekitar 2 cm distal dari klem pertama.				
31.	Pemotongan dan pengikatan tali pusat a. Dengan satu tangan, pegang tali pusat yang telah dijepit (lindungi perut bayi) dan lakukan pengguntingan tali pusat di antara 2 klem tersebut. b. Ikat tali pusat dengan benang DTT/Steril pada satu sisi kemudian lingkarkan lagi benang tersebut dan ikat tali pusat dengan simpul kunci pada sisi lainnya. c. Lepaskan klem dan masukkan dalam wadah yang telah disediakan.				
32.	Letakkan bayi tengkurap di dada ibu untuk kontak kulit ibu. Luruskan bahu bayi sehingga dada bayi menempel di dada ibunya. Usahan kepala bayi berada di antara payudara ibu dengan posisi lebih rendah dari puting susu atau areola mammae ibu. a. Selimuti ibu-bayi dengan kain kering dan hangat, pasang topi di kepala bayi. b. Biarkan bayi melakukan kontak kulit ke kulit di dada ibu paling sedikit 1 jam. c. Sebagian besar bayi akan berhasil melakukan inisiasi menyusui dini dalam waktu 30-60 menit. Menyus untuk pertama kali akan berlangsung sekitar 10-15 menit. Bayi cukup menyusui dari satu payudara. d. Biarkan bayi berada di dada ibu selama 1 jam walaupun bayi sudah berhasil menyusui				
	Manajemen Aktif Kala Tiga Persalinan				
33.	Pindahkan klem tali pusat hingga berjarak 5-10 cm dari vulva.				
34.	Letakkan satu tangan di atas kain pada perut bawah ibu (di atas <i>simfisis</i>), untuk mendeteksi kontraksi. Tangan lain memegang klem untuk menegangkan tali pusat.				

No	Komponen	Nilai			
		0	1	2	Score
35.	Setelah uterus berkontraksi, tegangkan tali pusat kearah bawah sambil tangan yang lain mendorong uterus kearah belakang atas (<i>dorso-kraniel</i>) secara hati-hati (untuk mencegah <i>inversion uteri</i>). Jika plasenta tidak lahir setelah 30-40 detik, hentikan penegangan tali pusat dan tunggu hingga timbul kontraksi berikutnya dan ulangi kembali prosedur di atas. a. Jika uterus tidak segera berkontraksi, minta ibu, suami atau anggota keluarga untuk melakukan stimulasi puting susu				
	Mengeluarkan Plasenta				
36.	Bila pada penekanan bagian bawah dinding depan uterus kearah dorsal ternyata diikuti dengan pergeseran tali pusat kea rah distal maka lanjutkan dorongan kearah kranial hingga plasenta dapat dilahirkan. a. Ibu boleh meneran tetapi tali pusat hanya ditegangkan b. (jangan ditarik secara kuat terutama jika uterus tidak berkontraksi) sesuai dengan sumbu jalan lahir (kearah bawah-sejajar lantai-atas). c. ika tali pusat bertambah panjang, pindahkan klem hingga berjarak sekitar 5-10 cm dari vulva dan lahirkan plasenta. d. Jika plasenta tidak lepas setelah 15 menit menegangkan tali pusat : 1) Ulangi pemberian oksitosin 10 unit IM. 2) Lakukan kateterisasi (gunakan teknik aseptik) jika kandung kemih penuh. 3) Minta keluarga untuk menyiapkan rujukan. 4) Ulangi tekanan dorso-kraniel dan penegangan tali pusat 15 menit berikutnya. 5) Jika plasenta tidak lahir 30 menit sejak bayi lahir atau terjadi perdarahan maka segera lakukan tindakan plasenta manual.				
37.	Saat plasenta muncul di introitus vagina, lahirkan plasenta dengan kedua tangan. Pegang dan putar plasenta hingga selaput ketuban terpinl kemudian lahirkan dan tempatkan plasenta pada wadah yang telah disediakan. a. Jika selaput ketuban robek, pakai sarung tangan DTT atau steril untuk melakukan eksplorasi sisa selaput kemudian gunakan jari-jari tangan atau klem ovum DTT/Steril untuk mengeluarkan selaput yang tertinggal.				
	Rangsangan Taktil (Massase) uterus				
38.	Segera setelah plasenta dan selaput ketuban lahir, lakukan massase uterus, letakkan telapak tanga di fundus dan lakukan massase dengan gerakan melingkar dengan lembut hingga uterus berkontraksi (fundus teraba keras)				

No	Komponen	Nilai			
		0	1	2	Score
	a. Lakukan tindakan yang diperlukan (<i>Kompresi Bimanual Internal, Kompresi Aorta Abdominalis, Tampon Kondom-Kateter</i>) jika uterus tidak berkontraksi dalam 15 detik setelah rangsangan taktil/ massase				
	Menilai Perdarahan				
39.	Periksa kedua sisi plasenta (<i>maternal-fetal</i>) pastikan plasenta telah dilahirkan lengkap. Masukkan plasenta ke dalam kantung plastil atau tempat khusus.				
40.	Evaluasi kemungkinan laserasi pada vagina dan perineum. Lakukan penjahitan bila terjadi laserasi derajat 1 dan 2 yang menimbulkan perdarahan. Bila ada robekan yang menimbulkan perdarah aktif, segera lakukan penjahitan.				
	Asuhan Pasca Persalinan				
41.	Pastikan uterus berkontraksi dengan baik dan tidak terjadi perdarahan pervaginam.				
42.	Pastikan kandung kemih kosong. Jika penuh lakukan kateterisasi.				
	Evaluasi				
43.	Celupkan tangan yang masih memakai sarung tangan kedalam larutan klorin 0,5%, bersihkan noda darah dan cairan tubuh dan bilas di air DTT tanpa melepas sarung tangan, kemudian keringkan dengan handuk				
44.	Ajarkan ibu/ keluarga cara melakukan masase uterus dan menilai kontraksi.				
45.	Memeriksa nadi ibu dan pastikan keadaan umum ibu baik.				
46.	Evaluasi dan estimasi jumlah kehilangan darah.				
47.	Pantau keadaan bayi dan pastikan bahwa bayi bernafas dengan baik (40-60 kali/menit) a. Jika bayi sulit bernapas, merintih atau retraksi, diresusitasi dan segera merujuk ke rumah sakit. b. Jika bayi napas terlalu cepat atau sesak napas, segera rujuk ke RS Rujukan c. Jika kaki teraba dingin, pastikan ruangan hangat. lakukan kembali kontak kulit ibu-bayi dan hangatkan ibu-bayi dalam satu selimut.				
	Kebersihan dan Keamanan				
48.	Tempatkan semua peralatan bekas pakai dalam larutan klorin 0,5% untuk dekontaminasi (10 menit). Cuci dan bilas peralatan setelah didekontaminasi.				
49.	Buang bahan-bahan yang terkontaminasi ke tempat sampah yang sesuai.				
50.	Bersihkan ibu dari paparan darah dan cairan tubuh dengan menggunakan air DTT. Bersihkan cairan ketuban, lendir dan darah di ranjang atau sekitar ibu berbaring.				

No	Komponen	Nilai			
		0	1	2	Score
	Bantu ibu memakai pakaian yang bersih dan kering				
51.	Pastikan ibu merasa nyaman. Bantu ibu memberikan ASI. Anjurkan keluarga untuk memberi ibu makan dan minum yang diinginkannya.				
52.	Dekontaminasi tempat bersalin dengan larutan klorin 0,5%.				
53.	Celupkan tangan yang masih memakai sarung tangan ke dalam larutan klorin 0,5% lepas sarungkan sarung tangan dalam keadaan terbalik dan rendam dalam larutan klorin 0,5% selama 10 menit.				
54.	Cuci tangan dengan sabun dan air mengalir kemudian keringkan tangan dengan tissue atau handuk pribadi yang bersih dan kering.				
55.	Pakai sarung tangan bersih/ DTT untuk melakukan pemeriksaan fisik bayi.				
56.	Lakukan pemeriksaan fisik bayi baru lahir. Pastikan kondisi bayi baik. Pernafasan normal (40-60 kali/menit) dan temperatur tubuh normal (36,5-37,5°C) setiap 15 menit.				
57.	Setiap 1 jam pemberian vitamin K, berikan suntikan Hepatitis B di paha kanan bawah lateral. Letakkan bayi di dalam jangkauan ibu agar sewaktu-waktu dapat disusukan.				
58.	Lepaskan sarung tangan dalam keadaan terbalik dan rendam didalam larutan klorin 0,5% selama 10 menit.				
59.	Cuci tangan dengan sabun dan air mengalir kemudian keringkan dengan tissue atau handuk pribadi yang bersih dan kering.				
	Dokumentasi				
60.	Lengkapi partograf (halaman depan dan belakang) periksa tanda vital dan asuhan kala IV persalinan.				
C. Terminasi					14
1.	Melakukan evaluasi tindakan				
2.	Berpamitan dengan pasien				
3.	Membereskan dan mengembalikan alat				
4.	Mencuci tangan				
5.	Melaksanakan secara sistematis				
6.	Menggunakan bahasa yang mudah dimengerti				
7.	Mendokumentasikan hasil tindakan				
Total Score					
Nilai Akhir = Jumlah score yang diperoleh: Total Score keseluruhan x 100					
Tanda Tangan Penguji					
Referensi : Pengurus IBI Pusat.2016. Buku Panduan Midwifery Update. Jakarta: Pengurus IBI Pusat					

E. Daftar Pustaka

- Afandi, B. (2017) *Asuhan Persalinan Normal*. Jakarta: JNKP-KR.
- Haeriah, M. (2021) *Efektifitas Aplikasi Asuhan Persalinan Normal Berbasis Web Sebagai Media Pembelajaran Mahasiswa Kebidanan*. Makassar. Available at: <http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/3141/>.
- Kusumastiwi, dkk (2022) *Buku Panduan Ketrampilan Medik Semester VI*. Yogyakarta.
- Pusat, P.I. (2016) *Buku Acuan Midwifery Update*. Jakarta: Pengurus IBI Pusat.
- RI, D. (2017) *Profil Kesehatan Tahun 2017*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- S.H., M. (2019) 'Normal Labor and Delivery', *medicine* [Preprint]. Available at: <https://emedicine.medscape.com/article/260036-overview#showall>.
- Selasih Putri Isnawati Hadi, Sri Kuswanti, Cipta Pramana, A. (2020) *Modul Praktikum Asuhan Kebidanan Persalinan dan Bayi Baru Lahir*. Yogyakarta.
- Thornton, J. M., Browne, B., & Ramphul, M. (2019) 'Mechanisms and management of normal labour', *Obstetrics, Gynaecology & Reproductive Medicine* [Preprint]. Available at: <https://doi.org/10.1016/j.ogrm.2019.12.002>.
- Yulizawati et al. (2019) *Buku Asuhan Kelahiran, Indomedika Pustaka*.

F. Glosarium

A

Ablatio retinal : keluhan fotopsia dan floaters yang mendadak, disertai penurunan tajam penglihatan, penyempitan lapangan pandang, tanpa disertai rasa nyeri.

Antiretroviral : bagian dari pengobatan HIV dan AIDS untuk mengurangi risiko penularan HIV

C

Cephalopelvic disproportion Ukuran kepala janin tidak sesuai dengan ukuran panggul ibu, di mana kondisi ini merupakan kontraindikasi absolut untuk melahirkan normal melalui vagina

D

Distosia : gangguan melahirkan pada ibu hamil yang melakukan persalinan pervaginam

DTT: Desinfektan Tingkat Tinggi adalah suatu langkah memproses alat habis pakai yang telah digunakan untuk suatu tindakan untuk menghilangkan mikroorganisme.

H

HIS: Kekuatan nyeri fisiologis yang muncul pada ibu bersalin.

I

inform consent : penyampaian informasi dari dokter, maupun tenaga medis lainnya, kepada pasien sebelum suatu tindakan medis dilakukan

inform choice : suatu keputusan yang dibuat setelah melalui pertimbangan matang terhadap bukti-bukti ilmiah yang relevan

inversion uteri : keadaan uterus pada posisi terbalik dengan fundus uteri (bagian atas dan terdalam rahim) masuk sebagian atau seluruhnya ke dalam rongga uterus, vagina, atau keluar dari vulva

M

Mal presentasi : kondisi di mana bagian anatomi janin yang masuk terlebih dahulu ke pelvic inlet adalah bagian lain selain vertex

Makrosomia : kondisi ketika bayi terlahir dengan ukuran yang besar, yakni sekitar 4 kg hingga 4,5 kg, atau bahkan lebih

P

Partograf: Alat bantu untuk memantau kemajuan suatu persalinan, kesejahteraan janin dan ibu serta sebagai informasi untuk membuat keputusan klinik.

S

Sectio caesarea : salah satu tindakan persalinan untuk mengeluarkan bayi melalui sayatan pada abdomen/ laparotomi dan uterus/ histerotomi

Simfisis : sendi penghubung 2 tulang pubis

BAB IV

PRAKTIKUM HEATING PERINEUM

Irfana Tri Wijayanti, S.Si.T., M.Kes., M.Keb.



A. Deskripsi

Di Indonesia laserasi perineum dialami oleh 75% ibu melahirkan pervaginam. Pada tahun 2017 menemukan bahwa dari total 1951 kelahiran spontan pervaginam, 57% ibu mendapat jahitan perineum (28% karena episiotomi dan 29% karena robekan spontan (RI, 2017). Robekan perineum merupakan perlukaan jalan lahir yang terjadi pada saat kelahiran bayi dengan menggunakan alat misalnya episiotomi atau tidak menggunakan alat. Robekan perineum dapat diatasi dengan melakukan heating pada area luka. Pada bab ini mahasiswa mempelajari tentang konsep dan prosedur heating perineum.

B. Tujuan Pembelajaran**1. Tujuan Pembelajaran Umum**

Setelah mempelajari praktikum ini mahasiswa mampu mempraktikkan prosedur heating perineum

2. Tujuan Pembelajaran Khusus

Setelah mempelajari materi ini diharapkan:

- Mahasiswa mampu memahami tentang heating perineum
- Mahasiswa mampu mempraktikkan prosedur heating perineum

C. Uraian Materi**1. Definisi**

Menurut (Pusat, 2016), kewenangan bidan dalam penjahitan luka ruptur perineum hanya pada derajat satu dan dua, sedangkan untuk derajat tiga dan empat sebaiknya bidan melakukan kolaborasi atau rujukan ke rumah sakit, karena ruptur ini memerlukan teknik dan prosedur khusus.



Gambar 4.1

2. Tujuan

Berdasarkan pada (Afandi, 2017), (Pusat, 2016), tujuan heating perineum adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mendekatkan jaringan-jaringan perlukaan sehingga proses penyembuhan bias terjadi, proses penyembuhan itu sendiri bukanlah hasil dari penjahitan tersebut tetapi hasil dari pertumbuhan jaringan.
- b. Untuk menghentikan perdarahan yang terjadi akibat perlukaan yang menyebabkan pembuluh darah terbuka

3. Indikasi

Berdasarkan (Pusat, 2016) indikasi dilakukan heating perineum adalah laserasi perineum

4. Kontra Indikasi

Menurut (Pusat, 2016) Kontra indikasi heating perineum adalah laserasi derajat III dan IV

5. Hal-hal yang diperhatikan

Hal – hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan heating perineum adalah sebagai berikut:

- a. Menyiapkan inform consent
- b. Menyiapkan inform choice
- c. Menjaga privasi pasien
- d. Menjaga Kesterilan alat
- e. Tindakan dilakukan sesuai dengan tahapan prosedur

6. Persiapan Alat

Menurut buku (Selasih Putri Isnawati Hadi, Sri Kuswanti, Cipta Pramana, 2020), (Pusat, 2016), persiapan alat dan bahan yang dibutuhkan untuk melakukan heating perineum adalah sebagai berikut:

- a. APD
- b. Lampu sorot
- c. Kassa
- d. Sarung tangan panjang DTT
- e. Bak instrument
- f. Benang chrom catgut
- g. Jarum
- h. Pinset chirurgis
- i. Bengkok
- j. Kom kecil
- k. Betadine
- l. Nald holder
- m. Larutan klorin 0,5%
- n. Sabun dan air mengalir

7. Prosedur Tindakan dan Rating scale Tindakan

Menurut (Pusat, 2016), (Selasih Putri Isnawati Hadi, Sri Kuswanti, Cipta Pramana, 2020), prosedur tindakan dan rating scale heating perineum sebagai berikut:

- 1) Memakai APD
- 2) Menyiapkan peralatan untuk penjahitan dan memakai handscoon
- 3) Membantu ibu dalam posisi litotomi
- 4) Memasang kain bersih dibawah bokong ibu
- 5) Mengatur lampu sorot kearah vulva atau perineum ibu
- 6) Memakai satu sarung tangan kanan
- 7) Mengisi spuit dengan lidocain 1%
- 8) Memakai sarung tangan kiri
- 9) Membersihkan daerah luka dari darah dan menilai luas dan dalamnya robekan pada daerah perineum dengan menggunakan kassa
- 10) Memberitahu ibu bahwa akan disuntik
- 11) Memasukkan jarum suntik pada ujung luka atau robekan perineum, memasukkan jarum suntik secara subkutan sepanjang tepi luka
- 12) Melakukan aspirasi
- 13) Memberikan anestesi lidocain 1% sambil menarik jarum suntik pada tepi luka daerah perineum
- 14) Tanpa menarik jarum suntik keluar dari luka, mengarahkan jarum suntik sepanjang tepi luka pada mukosa vagina, melakukan aspirasi kemudian menyuntikkan lidokain 1% sambil menarik jarum suntik
- 15) Mengulangi langkah tersebut untuk kedua tepi robekan
- 16) Menunggu 1-2 menit sebelum melakukan penjahitan untuk mendapatkan hasil optimal dari anestesi
- 17) Melakukan inspeksi vagina dan perineum untuk melihat robekan
- 18) Memasang tampon atau kassa ke dalam vagina jika perdarahan menutupi luka episiotomy
- 19) Menempatkan jarum jahit pada pemegang jarum kemudian kunci pemegang jarum
- 20) Memasang benang jahit (chromic 2-0) pada mata jarum
- 21) Melihat dengan jelas batas luka episiotomy
- 22) Melakukan penjahitan pertama kurang lebih 1cm diatas puncak luka robekan di dalam vagina, mengikat jahitan pertama dengan simpul mati. Memotong ujung benang yang bebas hingga tersisa kurang lebih 1cm
- 23) Menjahit muksa vagina dengan menggunakan jahitan jelujur hingga tepat di belakang lingkaran hymen
- 24) Menusukkan jarum pada mukosa vagina dari belakang lingkaran hymen hingga menembus luka robekan bagian perineum

- 25) Meneruskan jahitan jelujur pada luka robekan perineum sampai ke bagian bawah luka robekan
- 26) Menjahit jaringan subkutis kanan kiri ke arah atas hingga tepat di muka lingkaran hymen
- 27) Menusukkan jarum dari depan lingkaran hymen ke mukosa vagina di belakang lingkaran hymen
- 28) Membuat simpul mati dibelakang lingkaran hymen dan potong benang hingga tersisa 1cm
- 29) Mengeluarkan tampon/kassa bila menggunakan tampon/kassa
- 30) Memasukkan jari telunjuk ke dalam rectum dan meraba dinding atas rectum, jika teraba jahitan segera ganti sarung tangan dan lakukan penjahitan ulang (JNPK-KR, 2017).

D. Rating Scale Belajar Keterampilan

HEATING PERINEUM

Nilailah setiap langkah/kinerja yang diamati dengan menggunakan skala sbb:

- 0** = Bila Langkah atau tugas tidak dikerjakan
- 1** = Langkah dilakukan tetapi tidak sempurna
- 2** = Langkah dilakukan dengan sempurna

No	Komponen	Nilai			
		0	1	2	Score
A. Sikap					
1.	Menyapa klien dengan ramah dan sopan				10
2.	Memperkenalkan diri kepada klien				
3.	Teruji menjaga privacy klien				
4.	Percaya diri				
5.	Teruji menjelaskan maksud dan tujuan				
B. Isi					
1.	Memakai APD				60
2.	Menyiapkan peralatan untuk penjahitan dan memakai handscoon				
3.	Membantu ibu dalam posisi litotomi				
4.	Memasang kain bersih dibawah bokong ibu				
5.	Mengatur lampu sorot kearah vulva atau perineum ibu				
6.	Memakai satu sarung tangan kanan				
7.	Mengisi spuit dengan lidocain 1%				
8.	Memakai sarung tangan kiri				
9.	Membersihkan daerah luka dari darah dan menilai luas dan dalamnya robekan pada daerah perineum dengan menggunakan kassa				
10.	Memberitahu ibu bahwa akan disuntik				

No	Komponen	Nilai			
		0	1	2	Score
11.	Memasukkan jarum suntik pada ujung luka atau robekan perineum, memasukkan jarum suntik secara subkutan sepanjang tepi luka				
12.	Melakukan aspirasi				
13.	Memberikan anestesi lidocain 1% sambil menarik jarum suntik pada tepi luka daerah perineum				
14.	Tanpa menarik jarum suntik keluar dari luka, mengarahkan jarum suntik sepanjang tepi luka pada mukosa vagina, melakukan aspirasi kemudian menyuntikkan lidokain 1% sambil menarik jarum suntik				
15.	Mengulangi langkah tersebut untuk kedua tepi robekan				
16.	Menunggu 1-2 menit sebelum melakukan penjahitan untuk mendapatkan hasil optimal dari anestesi				
17.	Melakukan inspeksi vagina dan perineum untuk melihat robekan				
18.	Memasang tampon atau kassa ke dalam vagina jika perdarahan menutupi luka episiotomy				
19.	Menempatkan jarum jahit pada pemegang jarum kemudian kunci pemegang jarum				
20.	Memasang benang jahit (chromic 2-0) pada mata jarum				
21.	Melihat dengan jelas batas luka episiotomy				
22.	Melakukan penjahitan pertama kurang lebih 1cm diatas puncak luka robekan di dalam vagina, mengikat jahitan pertama dengan simpul mati. Memotong ujung benang yang bebas hingga tersisa kurang lebih 1cm				
23.	Menjahit muksa vagina dengan menggunakan jahitan jelujur hingga tepat di belakang lingkaran hymen				
24.	Menusukkan jarum pada mukosa vagina dari belakang lingkaran hymen hingga menembus luka robekan bagian perineum				
25.	Meneruskan jahitan jelujur pada luka robekan perineum sampai ke bagian bawah luka robekan				
26.	Menjahit jaringan subkutis kanan kiri kearah atas hingga tepat di muka lingkaran hymen				
27.	Menusukkan jarum dari depan lingkaran hymen ke mukosa vagina di belakang lingkaran hymen				
28.	Membuat simpul mati dibelakang lingkaran hymen dan potong benang hingga tersisa 1cm				
29.	Mengeluarkan tampon/kassa bila menggunakan tampon/kassa				
30.	Memasukkan jari telunjuk ke dalam rectum dan meraba dinding atas rectum, jika teraba jahitan				

No	Komponen	Nilai			
		0	1	2	Score
	segera ganti sarung tangan dan lakukan penjahitan ulang				
C. Terminasi					
1.	Melakukan evaluasi tindakan				14
2.	Berpamitan dengan pasien				
3.	Membereskan dan mengembalikan alat				
4.	Mencuci tangan				
5.	Melaksanakan secara sistematis				
6.	Menggunakan bahasa yang mudah dimengerti				
7.	Mendokumentasikan hasil tindakan				
Total Score					
Nilai Akhir = Jumlah score yang diperoleh: Total Score keseluruhan x 100					
Tanda Tangan Penguji					
Referensi : Pengurus IBI Pusat. 2016. Buku Acuan Midwifery Update. Jakarta: Pengurus IBI Pusat Sulikah, dkk. 2019. Modul Praktikum Asuhan Kebidanan Persalinan dan Bayi Baru Lahir. Surabaya : Poltekkes KemenKes Surabaya					

E. Daftar Pustaka

- Afandi, B. (2017) *Asuhan Persalinan Normal*. Jakarta: JNKP-KR.
- Haeriah, M. (2021) *Efektifitas Aplikasi Asuhan Persalinan Normal Berbasis Web Sebagai Media Pembelajaran Mahasiswa Kebidanan*. Makassar. Available at: <http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/3141/>.
- Kusumastiwi, dkk (2022) *Buku Panduan Ketrampilan Medik Semester VI*. Yogyakarta.
- Pusat, P.I. (2016) *Buku Acuan Midwifery Update*. Jakarta: Pengurus IBI Pusat.
- RI, D. (2017) *Profil Kesehatan Tahun 2017*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- S.H., M. (2019) 'Normal Labor and Delivery', *medicine* [Preprint]. Available at: <https://emedicine.medscape.com/article/260036-overview#showall>.
- Selasih Putri Isnawati Hadi, Sri Kuswanti, Cipta Pramana, A. (2020) *Modul Praktikum Asuhan Kebidanan Persalinan dan Bayi Baru Lahir*. Yogyakarta.
- Thornton, J. M., Browne, B., & Ramphul, M. (2019) 'Mechanisms and management of normal labour', *Obstetrics, Gynaecology & Reproductive Medicine* [Preprint]. Available at: <https://doi.org/10.1016/j.ogrm.2019.12.002>.
- Yulizawati et al. (2019) *Buku Asuhan Kelahiran, Indomedika Pustaka*.

F. Glosarium

C

Chromic 2-0 : merupakan jenis benang yang dapat terserap dengan sempurna oleh jaringan sehingga tidak perlu dibuka/dibuang jika lukanya telah sembuh.

D

DTT: Desinfektan Tingkat Tinggi adalah suatu langkah memproses alat habis pakai yang telah digunakan untuk suatu tindakan untuk menghilangkan mikroorganisme.

H

Heating : Penjahitan

Hymen : Selaput dara

I

inform consent : penyampaian informasi dari dokter, maupun tenaga medis lainnya, kepada pasien sebelum suatu tindakan medis dilakukan.

inform choice : suatu keputusan yang dibuat setelah melalui pertimbangan matang terhadap bukti-bukti ilmiah yang relevan.

K

Kontraksi : kondisi perut ibu hamil mengencang dan mengeras yang muncul apabila calon ibu siap untuk melahirkan.

P

Partograf: Alat bantu untuk memantau kemajuan suatu persalinan, kesejahteraan janin dan ibu serta sebagai informasi untuk membuat keputusan klinik.

S

Sub kutan : teknik suntikan diantara kulit dan otot.

BAB V

PRAKTIKUM VAGINAL TOUCHER (VT)

Putu Ayu Ratna Darmayanti, S.Tr.Keb.,M.Kes



BAB V

PRAKTIKUM VAGINAL TOUCHER (VT)

Putu Ayu Ratna Darmayanti, S.Tr.Keb.,M.Kes

A. Deskripsi

BAB ini mengenalkan pada mahasiswa tentang konsep teori Vaginal Toucher (VT) dan prosedur penatalaksanaannya pada ibu bersalin yang didasari dengan konsep-konsep terkini dan hasil penelitian.

B. Tujuan Pembelajaran

1. Tujuan Pembelajaran Umum

Setelah mengikuti penuntun belajar praktik ini, mahasiswa mampu melakukan praktik Vaginal Toucher (VT) pada ibu bersalin.

2. Tujuan Pembelajaran Khusus

Setelah mempelajari materi ini diharapkan dapat:

- a. Mahasiswa mampu memahami tentang konsep Vaginal Toucher (VT) pada ibu bersalin
- b. Mahasiswa mampu melakukan pemeriksaan Vaginal Toucher (VT) pada ibu bersalin

C. Uraian Materi

1. Definisi

Pemeriksaan Vaginal Toucher (VT) pada ibu bersalin merupakan tindakan pada pasien yang dilakukan dengan memasukkan kedua jari tangan (jari tengah dan telunjuk) pemeriksa/bidan ke dalam vagina (Triyana, 2013).

Vaginal Toucher (VT) adalah pemeriksaan dalam menggunakan dua jari yaitu jari telunjuk dan jari tengah yang dimasukkan kedalam vagina untuk mengetahui pembukaan dan menentukan waktu awal persalinan (Mutmainnah et al., 2017).



Gambar 5.1. Vaginal Toucher

2. Tujuan

Menurut Oktarina (2015), VT bertujuan untuk mengetahui pasien telah memasuki proses inpartu atau belum melalui pembukaan serviks, untuk mengetahui penurunan bagian terendah janin dan bagian terbawah janin serta keadaan abnormal selama persalinan. Tujuan dari Vaginal Toucher (VT) pada ibu bersalin yaitu menilai keadaan vagina, menilai adanya tumor atau benjolan pada vagina, menilai adanya dilatasi serviks atau pembukaan persalinan dan menentukan jalannya persalinan (Indrayani & Djami, 2016).

3. Indikasi

Menurut Rukiyah and Yulianti (2019), Indikasi dilakukan Vaginal Toucher (VT) pada ibu bersalin yaitu saat ketuban pecah sebelum waktunya, untuk evaluasi pembukaan serviks uteri, untuk menyelesaikan persalinan atau melakukan rujukan, dan petunjuk partograf WHO setiap 4 jam.

4. Kontrak Indikasi

Kontra indikasi Vaginal Toucher (VT) yaitu adanya infeksi daerah genetalia dan pasien hamil dengan perdarahan pervaginam berwarna merah segar (Indrayani & Djami, 2016).

5. Hal-hal yang diperhatikan

Menurut Indrayani and Djami (2016), hal-hal yang diperhatikan saat melakukan VT adalah pencegahan infeksi, sebagai berikut:

- a. Pada diri sendiri yaitu dengan memakai sarung tangan steril dan APD untuk menghindari terpapar infeksi menular seksual
- b. Pada pasien dan janin
 - 1) Melakukan vulva hygiene dengan benar secara searah
 - 2) Membuka labia mayora kanan dan kiri dengan tangan kiri agar ibu bersalin tidak merasa kesakitan
 - 3) Memasukkan jari tengah dan jari telunjuk ke dalam vagina secara obstetrik, dan tidak boleh dikeluarkan sebelum seluruh pemeriksaan selesai dilakukan.
 - 4) VT selalu dilakukan ketika jeda HIS atau Kontraksi. Jika ibu mengalami kontraksi pada saat jari tangan pemeriksa di dalam vagina maka pertahankan jari di dalam vagina dan tunggu sampai kontraksi hilang. Jangan mengeluarkan dan memasukkan jari kembali

6. Persiapan Alat

Menurut Fatimah (2022), persiapan alat yang dibutuhkan selama melakukan Vaginal Toucher (VT), yaitu sebagai berikut:

- a. Handscoon steril atau DTT 1 buah pada bak instrumen
- b. Kapas DTT pada kom kecil
- c. Korentang
- d. Tissue

- e. Perlak pengalas bokong 1 buah
- f. Air DTT dalam kom kecil 1 buah
- g. APD (sesuai kondisi pasien)
- h. Bengkok 1 buah
- i. Selimut
- j. Larutan klorin 0,5%
- k. Tempat sampah medis
- l. Sampiran jika diperlukan

7. Prosedur Tindakan dan Rating scale Tindakan

Menurut Fatimah (2022), prosedur tindakan Vaginal Toucher (VT), yaitu seperti dibawah ini.

- a. Meletakkan alat secara ergonomis didekat pasien
- b. Menjelaskan maksud dan tujuan VT
- c. Mencuci tangan dengan prinsip 6 langkah yang benar
- d. Memasang sampiran
- e. Petugas menggunakan APD (sesuai kondisi pasien)
- f. melepaskan pakaian dalam pasien secukupnya
- g. Mengatur posisi pasien secara dorsal recumbent
- h. Letakkan perlak kecil atau pengalas di bawah bokong pasien
- i. Melakukan vulva hygiene dengan kapas dan air DTT (dari labia mayora kiri, labia mayora kanan, labia minora kiri, labia minora kanan, klitoris, vestibulum sampai anus) lalu keringkan dengan tissue
- j. Melakukan pemeriksaan inspeksi pada vulva dan vagina pasien mulai dari pengeluaran cairan atau fluor albus, warna cairan, jumlah cairan, bau cairan dan tanda infeksi
- k. VT dilakukan saat kontraksi melemah dengan cara Masukkan jari tengah tangan kanan ke dalam vagina secara perlahan searah sumbu panggul, diikuti jari telunjuk secara perlahan. Sedangkan tangan kiri diletakkan pada fundus perut pasien
- l. Melakukan penilaian dengan meraba dan merasakan, meliputi:
 - 1) Dinding vagina ada tumor / odema
 - 2) Dinding vagina elastis/tidak
 - 3) Serviks / portio konsistensi elastis/tidak
 - 4) Effacement atau penipisan portio
 - 5) Pembukaan, posisi uteri
 - 6) Kulit Ketuban
 - 7) Masuk ke dalam portio kemudian raba presentasi terbawah janin
 - 8) Denominator (UUK/UUB)
 - 9) Molage atau sutura tulang kepala bayi
 - 10) Bidang hodge atau penurunan kepala

- 11) Teraba atau tidak bagian terkecil janin dan tali pusat
- m. Melakukan pemeriksaan kesan panggul:
 - 1) Promotorium teraba / tidak
 - 2) Linea inominata teraba berapa bagian (N=2/3)
 - 3) Spina isciadica menonjol / tidak
 - 4) Sacrum cekung bikonkaf / tidak
 - 5) Arcus pubis lebih besar / $< 90^\circ$
 - 6) Distantia tuberosum $> / < 1$ kepal
- n. Mengeluarkan kedua jari dengan memperhatikan cairan yang keluar yaitu darah, lendir dan ketuban
- o. Melepas handscoon dan masukkan kedalam larutan klorin 0,5%, merendam dalam posisi terbalik
- p. Kembalikan klien pada posisi semula dengan cara mengangkat bokong dan tarik perlak/pengalas bokong
- q. Bantu pasien mengatur posisi yang nyaman
- r. Kembalikan peralatan pada tempatnya, buka sampiran
- s. Melepas APD
- t. Mencuci tangan dengan prinsip enam langkah yang benar
- u. Dokumentasikan prosedur dan hasil observasi

D. Rating Scale Belajar Keterampilan

VAGINAL TOUCHER (VT)

Nilailah setiap langkah/kinerja yang diamati dengan menggunakan skala sbb :

- 0** = Bila Langkah atau tugas tidak dikerjakan
1 = Langkah dilakukan tetapi tidak sempurna
2 = Langkah dilakukan dengan sempurna

No	Komponen	Nilai			
		0	1	2	Score
A. Sikap					
1.	Menyapa klien dengan ramah dan sopan				10
2.	Memperkenalkan diri kepada klien				
3.	Teruji menjaga privacy klien				
4.	Percaya diri				
5.	Teruji menjelaskan maksud dan tujuan				
B. Isi					
1.	Meletakkan alat secara ergonomis didekat pasien				36
2.	Menjelaskan maksud dan tujuan VT				

3.	Mencuci tangan dengan prinsip 6 langkah yang benar				
4.	Memasang sampiran				
5.	Petugas menggunakan APD (sesuai kondisi pasien)				
6.	Melepaskan pakaian dalam pasien secukupnya				
7.	Mengatur posisi pasien secara dorsal recumbent				
8.	Letakkan perlak kecil atau pengalas di bawah bokong pasien				
9.	Melakukan vulva hygiene dengan kapas dan air DTT (dari labia mayora kiri, labia mayora kanan, labia minora kiri, labia minora kanan, klitoris, vestibulum sampai anus) lalu keringkan dengan tissue				
10.	Melakukan pemeriksaan inspeksi pada vulva dan vagina pasien mulai dari pengeluaran cairan atau fluor albus, warna cairan, jumlah cairan, bau cairan dan tanda infeksi				
11.	VT dilakukan saat kontraksi melemah dengan cara Masukkan jari tengah tangan kanan ke dalam vagina secara perlahan searah sumbu panggul, diikuti jari telunjuk secara perlahan. Sedangkan tangan kiri diletakkan pada fundus perut pasien				
12.	Melakukan penilaian dengan meraba dan merasakan, meliputi: a. Dinding vagina ada tumor / odema b. Dinding vagina elastis/tidak c. Serviks / portio konsistensi elastis/tidak d. Effacement atau penipisan portio e. Pembukaan, posisi uteri f. Kulit Ketuban g. Masuk ke dalam portio kemudian raba presentasi terbawah janin h. Denominator (UUK/UUB) i. Molage atau sutura tulang kepala bayi j. Bidang hodge atau penurunan kepala k. Teraba atau tidak bagian terkecil janin dan tali pusat				

13.	Melakukan pemeriksaan kesan panggul: a. Promotorium teraba / tidak b. Linea inominata teraba berapa bagian (N=2/3) c. Spina isciadica menonjol / tidak d. Sacrum cekung bikonkaf / tidak e. Arcus pubis lebih besar / < 90° f. Distantia tuberosum > /< 1 kepal				
14.	Mengeluarkan kedua jari dengan memperhatikan cairan yang keluar yaitu darah, lendir dan ketuban				
15.	Melepas handscoon dan masukkan kedalam larutan klorin 0,5%, merendam dalam posisi terbalik				
16.	Kembalikan klien pada posisi semula dengan cara mengangkat bokong dan tarik perlak/pengalas bokong				
17.	Bantu pasien mengatur posisi yang nyaman				
18.	Melepas APD				
C. Terminasi					
1.	Melakukan evaluasi tindakan				14
2.	Berpamitan dengan pasien				
3.	Membereskan dan mengembalikan alat				
4.	Mencuci tangan				
5.	Melaksanakan secara sistematis				
6.	Menggunakan bahasa yang mudah dimengerti				
7.	Mendokumentasikan hasil tindakan				
Total Score					60
Nilai Akhir = Jumlah score yang diperoleh: Total Score keseluruhan x 100/total score					
Tanda Tangan Penguji					
Referensi : Fatimah, F. (2022). Modul Praktikum Asuhan Kebidanan Persalinan Dan BBL.					

E. Daftar Pustaka

- Fatimah, F. (2022). Modul Praktikum Asuhan Kebidanan Persalinan Dan BBL.
- Indrayani, & Djami, M. (2016). Update asuhan persalinan dan bayi baru lahir. *Jakarta: CV Trans Info Media*.
- Mutmainnah, A. U., SiT, S., Herni Johan, S., SKM, M. S., Llyod, S. S., SiT, S., & Mahakam, A. K. M. (2017). *Asuhan Persalinan Normal dan Bayi Baru Lahir*: Penerbit Andi.
- Oktarina, M. (2015). *Buku ajar asuhan kebidanan persalinan dan bayi baru lahir*: Deepublish.
- Rukiyah, A. Y., & Yulianti, L. (2019). Asuhan Kebidanan Kegawatdaruratan Maternal dan Neonatal. *Jakarta: CV. Trans Info Media*.
- Triyana, Y. F. (2013). Panduan klinis kehamilan dan persalinan.

F. Glosarium

A

Anus: Lubang akhir dari sistem pencernaan sebagai tempat keluarnya feses

APD: Alat Pelindung Diri yang digunakan saat bekerja seperti penutup kepala, masker, kacamata google, celemek dan sepatu boat

Arcus Pubis: Pinggir bawah simfisis berbentuk lengkung ke bawah dan merupakan sudut 90⁰ atau lebih sedikit.

B

Bidang Hodge: bidang khayal untuk menentukan seberapa jauh bagian depan anak turun ke dalam rongga panggul.

D

Dilatasi Serviks: Kondisi leher rahim yang terbuka, melebar dan membesar ketika menjelang proses persalinan.

Denominator: titik jelas pada bagian presentasi janin yang berhubungan dengan titik yang ditetapkan pada panggul ibu, digunakan untuk menunjukkan posisi janin.

DTT: Desinfektan Tingkat Tinggi adalah suatu langkah memproses alat habis pakai yang telah digunakan untuk suatu tindakan untuk menghilangkan mikroorganisme.

Dorsal Recumbent: Posisi menekuk lutut dan melebarkan kedua kaki, memakai bantal di kepala, kedua telapak kaki tetap menapak di tempat tidur dan kedua tangan di letakkan diatas kepala pada ibu bersalin.

Distantia Tuberosum: Jarak antara tuber iskii kanan dan kiri. Nilai normalnya $\pm 10,5$ cm.

E

Ergonomis: Cara kerja atau meletakkan Barang atau alat yang digunakan dalam posisi minimal atau terdekat, secara berurutan, sistematis sesuai dengan kebutuhan awal dan mudah dilihat dan dijangkau.

F

Fundus: bagian puncak dari rahim ibu saat sedang berada dalam masa kehamilan.

Flour Albus: adalah sekresi vaginal abnormal pada wanita yang disertai dengan rasa gatal di dalam vagina dan disekitar bibir vagina bagian luar.

G

Genetalia: Semua bagian anatomis tubuh makhluk hidup yang terlibat dalam reproduksi seksual dan menjadi bagian dari sistem reproduksi pada suatu organisme kompleks.

H

HIS: Kekuatan nyeri fisiologis yang utama selama kala II. His yang terjadi pada responden bersifat normal, yaitu kontraksi uterus terjadi 3 – 4 kali dalam 10 menit selama 40 – 60 menit dengan interval 2 – 3 menit.

I

Inspeksi: Proses pemeriksaan dengan metode pengamatan atau observasi menggunakan panca indra untuk mendeteksi masalah kesehatan pasien yang sedang sakit.

K

Klitoris: Tonjolan kecil di bagian atas labia minora, yang sangat sensitif dan merupakan sumber utama kenikmatan seksual wanita.

Korentang: Suatu alat atau instrumen untuk keperluan medis yang biasa digunakan oleh paramedis untuk memegang atau mengambil alat dan bahan medis steril supaya tetap terjaga dalam kondisi steril, jika diambil dengan tangan kemungkinan menjadi tidak steril.

Kontraksi Rahim: Proses pengerutan dan penegangan otot rahim terjadi saat tubuh melepaskan hormon oksitosin yang ditunjukkan dengan tanda perut ibu bersalin dibagian atas rahim mengencang, sehingga bayi terdorong ke bawah untuk masuk ke jalan lahir.

L

Labia Mayora: Bibir vagina besar yang terletak di bagian luar. Berbentuk seperti pembungkus besar, organ ini berfungsi untuk melindungi organ reproduksi wanita bagian luar lainnya.

Labia Minora: Bibir kecil vagina yang bertugas melindungi organ di dalam vulva seperti klitoris, uretra, dan vagina.

Larutan Klorin 0,5%: Suatu larutan yang berfungsi sebagai desinfektan yang terbuat dari campuran 0,095 liter Bayclin 5,25% dan air sampai didapatkan volume 1 liter.

Linea Inominata: Pada os ilium terdapat jalur, yaitu Linea Innominata (Linea Terminalis) yang menjadi batas antara panggul besar dan panggul kecil.

M

Molage Kepala Bayi: Bagian sutura tulang tengkorak yang menumpuk. Suatu kondisi kompensasi tulang tengkorak kepala bayi terhadap tekanan untuk dapat melewati jalan

lahir.

O

Odema: Suatu kondisi dimana terjadi pembengkakan pada anggota tubuh yang disebabkan kelebihan cairan dan garam dalam jaringan.

P

Partograf: Alat bantu untuk memantau kemajuan suatu persalinan, kesejahteraan janin dan ibu serta sebagai informasi untuk membuat keputusan klinik.

Promotorium: Bagian depan paling atas dari tulang sacrum dinamakan promontorium, dimana bagian ini bila dapat teraba pada waktu pemeriksaan dalam, berarti ada kesempitan panggul.

S

Sacrum: Tulang kelangkang berbentuk segitiga, melebar di atas dan meruncing ke bawah. Terletak di sebelah belakang antara kedua pangkal paha.

Spina Isciadica: tulang yang ada disebelah bawah tulang usus dengan pinggir belakang menonjol.

Serviks Uteri: Bagian dari rahim yang menonjol kedalam vagina pada kondisi normal berwarna pink dan permukaannya licin.

U

UUB: Ubun-Ubun Besar. Ubun-ubun yang terletak di puncak kepala bayi.

UUK: Ubun-Ubun Kecil. Ubun-ubun yang terletak di kepala bayi bagian belakang

V

Vaginal Toucher: Pemeriksaan genetalia bagian dalam mulai dari vagina sampai serviks menggunakan 2 jari.

Vestibulum: Rongga kemaluan yang terletak di labia minora dan merupakan muara dari saluran uretra dan lubang vagina.

Vulva Hygiene: Membersihkan vulva dan daerah sekitarnya pada pasien wanita yang tidak dapat melakukannya sendiri.

BAB VI

PRAKTIKUM DISTOSIA BAHU

Putu Ayu Ratna Darmayanti, S.Tr.Keb.,M.Kes



A. Deskripsi

BAB ini mengenalkan pada mahasiswa tentang konsep teori distosia bahu dan prosedur penatalaksanaannya pada ibu bersalin yang didasari dengan konsep-konsep terkini dan hasil penelitian.

B. Tujuan Pembelajaran**1. Tujuan Pembelajaran Umum**

Setelah mengikuti penuntun belajar praktik ini, mahasiswa mampu melakukan praktik distosia bahu pada ibu bersalin.

2. Tujuan Pembelajaran Khusus

Setelah mempelajari materi ini diharapkan dapat:

- a. Mahasiswa mampu memahami tentang konsep distosia bahu pada ibu bersalin
- b. Mahasiswa mampu melakukan tindakan distosia bahu pada ibu bersalin

C. Uraian Materi**1. Definisi**

Distosia bahu adalah suatu keadaan sulitnya melahirkan bahu depan janin setelah kepala lahir dengan tanda tidak adanya putaran paksi luar dan tertahannya kepala karena tarikan pada bahu posterior dengan kepala atau turtle sign (Hill & Cohen, 2016). Distosia bahu pada janin adalah keadaan gawatdarurat maternal dan neonatal selama persalinan normal dikarenakan setelah lahirnya kepala janin, gagal diikuti oleh lahirnya bahu janin secara spontan yang memerlukan tambahan maneuver obstetrik. Hal ini karena terjadi impaksi pada promontorium sacral ibu atau simfisis pubis. Kondisi distosia bahu dapat disebabkan karena obesitas pada ibu, panggul ibu sempit, janin besar, anasarca atau dada janin sangat besar, bahu bayi terperangkap di ramus pubis (Huntley & Smith, 2017).

Pada kondisi normal, saat kepala dilahirkan, bahu masuk ke dalam panggul dengan posisi oblik. Bahu posterior masuk ke panggul lebih dahulu sebelum bahu anterior. Ketika kepala melakukan paksi luar, bahu posterior berada di cekungan tulang sacrum atau di sekitar spina iskhidika, dan memberikan ruang yang cukup bagi bahu anterior untuk memasuki panggul melalui belakang tulang pubis atau berotasi dari foramen obturator. Sedangkan pada kasus distosia bahu, bahu berada dalam posisi antero-

posterior ketika hendak memasuki pintu atas panggul, maka bahu posterior dapat tertahan promotorium dan bahu anterior tertahan tulang pubis. Dalam keadaan demikian, dapat terjadi distosia bahu (Hill & Cohen, 2016).

Komplikasi yang dapat terjadi pada persalinan normal dengan distosia bahu yaitu pada bayi dapat mengalami fraktur humerus, fraktur klavikula, asfiksia, lumpuh pleksus brachialis hingga kematian. Sedangkan pada ibu, dapat terjadi rupture uteri, laserasi grade III-IV, fistula vaginal-rekto, pemisahan simfisis karena tindakan simfisiotomi dan perdarahan post partum. Sebagian besar kasus pada distosia bahu tidak dapat diprediksi. Sehingga, tenaga kesehatan diharapkan selalu antisipasi dan melakukan persiapan yang tepat (Simanjuntak, 2021).

2. Tujuan

Tujuan dari pertolongan penanganan distosia bahu dengan teknik ALARMER pada ibu bersalin yaitu sebagai acuan dalam menerapkan langkah-langkah pertolongan persalinan dengan distosia bahu sehingga bahu bayi dapat dilahirkan dan meminimalisir angka kematian neonatus (Akbar, Yudho Prabowo, & Rodiani, 2017).

3. Indikasi

Menurut Rukiyah and Yulianti (2019), Indikasi dilakukan penanganan distosia bahu dengan menerapkan “ALARMER” pada ibu bersalin yaitu, sebagai berikut:

- a. Turtle sign yaitu kepala bayi tertarik kembali ke perineum ibu setelah keluar dari vagina. Pipi bayi menonjol keluar, seperti kura-kura yang menarik kepala kembali ke cangkangnya. Penarikan kepala bayi ini terjadi akibat bahu depan bayi terperangkap di simfisis pubis ibu sehingga mencegah lahirnya tubuh bayi.
- b. Tubuh bayi tidak muncul setelah ibu meneran dengan baik dan traksi yang cukup untuk melahirkan tubuh setelah kepala bayi lahir.

4. Kontrak Indikasi

Kontra indikasi penanganan distosia bahu dengan melakukan “ALARMER” yaitu ibu bersalin dengan riwayat asma dan penyakit jantung (Akbar et al., 2017).

5. Hal-hal yang diperhatikan

Menurut Simanjuntak (2021), hal-hal yang diperhatikan saat melakukan penanganan pada distosia bahu adalah sebagai berikut:

- a. Pada diri sendiri dengan menghindari 4P yaitu *panic*, *pushing* (tidak mendorong pada fundus), *pulling* (tidak menarik kepala), *pivoting* (tidak angulasi atau memutar secara berlebih kepala bayi).
- b. Pada pasien dan janin

- 1) Setiap tindakan pada kasus distosia bahu, wajib memanggil bantuan 2 orang asisten membantu dalam persalinan dan 1 orang perawat bayi karena risiko distosia bahu dapat menyebabkan hipoksia dan asidosis akut yang memicu kematian perinatal.
- 2) Jika telah dilakukan tindakan episiotomi sebelumnya maka, tidak boleh melakukan penekanan fundus.
- 3) Pasca menolong bayi dengan distosia bahu sangat penting memperhatikan, hal berikut ini.
 - Perdarahan pasca salin dan robekan jalan lahir. Sehingga, segera melakukan manajemen aktif kala III dan *heacting perineum*.
 - Memeriksa kondisi bayi baru lahir seperti adanya trauma
 - Mempersiapkan dan melakukan resusitasi dengan benar
 - Mengecek trauma persalinan pada bayi
 - Menginformasikan pasien, suami dan keluarga mengenai kondisi dan tindakan yang telah dikerjakan
 - Mendokumentasikan analisis dan semua penatalaksanaan atau manuver yang dilakukan pada persalinan dengan distosia bahu.

6. Persiapan Alat

Menurut Simanjuntak (2021), persiapan alat dan obat yang dibutuhkan selama melakukan pertolongan persalinan dengan distosia bahu menggunakan “ALARMER”, yaitu sebagai berikut:

- a. Partus set
- b. Heacting set
- c. Alat Pelindung Diri (APD) seperti penutup kepala, masker, kacamata google, gown, sepatu boot
- d. Sduit 3 cc 2 buah
- e. Sduit 5 cc 1 buah
- f. Handscoon steril
- g. Kassa steril pada kom kecil
- h. Korentang
- i. Oksitosin 1 ampul
- j. Methergin 1 ampul
- k. Lidocain 2 ampul
- l. Perlak pengalas bokong 1 buah
- m. Air DTT dalam kom kecil 1 buah
- n. Bengkok 1 buah
- o. Larutan klorin 0,5%

- p. Kain
- q. Sampiran jika diperlukan

7. Prosedur Tindakan dan Rating scale Tindakan

Menurut Simanjuntak (2021), penanganan definitif distosia bahu dilakukan dengan menerapkan “ALARMER” seperti dibawah ini.

A: *Ask for help.*

L: *Lifting the legs and buttocks.*

A: *Anterior shoulder disimpaction.*

R: *Rotation of posterior shoulder.*

M: *Manual removal posterior arm*

E: *Episiotomi*

R: *Roll over onto “all fours”*

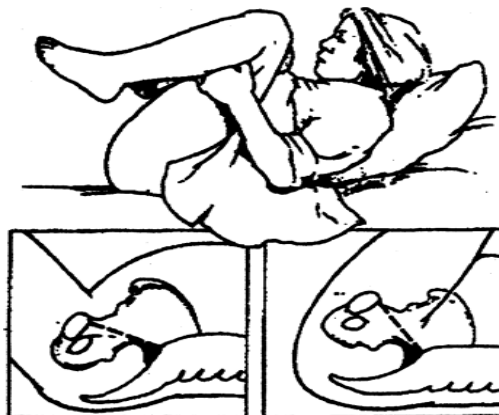
Jika disesuaikan dengan prosedur tindakan, maka, dapat dilakukan langkah-langkah berikut ini.

- a. Meletakkan alat secara ergonomis didekat pasien
- b. Menjelaskan tujuan tindakan “ALARMER”
- c. Mencuci tangan dengan prinsip enam langkah yang benar
- d. Memasang sampiran
- e. Petugas menggunakan APD (sesuai kondisi pasien)
- f. A: *Ask for help.*

Meminta bantuan dua orang sebagai asisten persalinan dan 1 orang bersiap sebagai perawat bayi.

- g. L: *Lifting the legs and buttocks.* Dilakukan dengan cara, yaitu:

Manuver Mcroberts: mengfleksikan paha ke arah abdomen, dimana maneuver ini membutuhkan asisten untuk menarik paha ibu bersalin kearah perut ibu. Tindakan ini bertujuan untuk meluruskan sacrum terhadap vertebra lumbalis yang akan diikuti rotasi kepala bayi di dalam panggul sehingga membebaskan bahu anterior bayi yang terjepit.



Gambar 6.1. Manuver Mcroberts

h. A: *Anterior shoulder disimpaction*. Dilakukan dengan dua cara, yaitu:

a. Pendekatan perabdominal

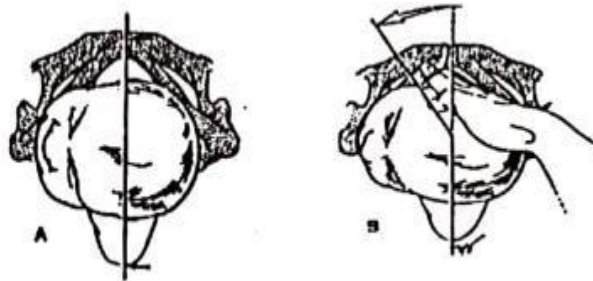
Manuver Mazzanti: melakukan penekanan suprapubik dengan ujung genggaman tangan pada bagian belakang bahu depan bayi untuk membebaskannya.



Gambar 6.2. Manuver Mazzanti

b. Pendekatan pervaginam

Manuver Rubin: melakukan adduksi bahu depan bayi dengan menekan bagian belakang bahu bayi (bahu didorong ke arah dada). Ingat, jika telah dilakukan tindakan episiotomi sebelumnya maka, tidak boleh melakukan penekanan fundus.

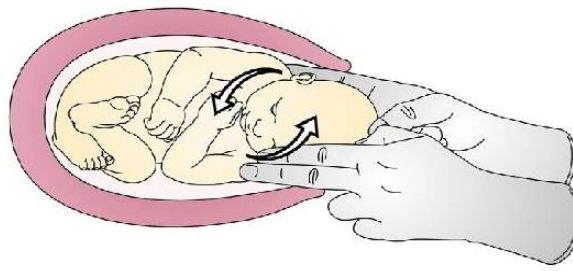


Gambar 6.3. Manuver Rubin

i. R: *Rotation of posterior shoulder*. Dilakukan dengan dua cara pemutaran bahu belakang atau posterior 180°, yaitu:

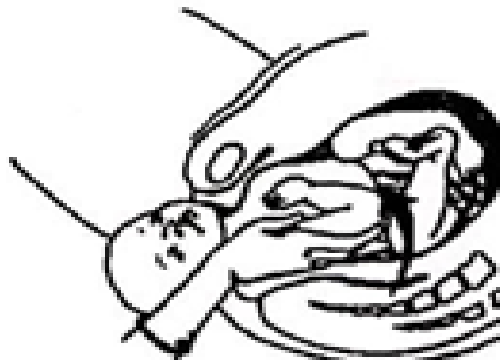
Manuver Woods Cockscrew:

- penekanan pada bagian depan bahu belakang
- Simultan dengan *anterior disimpaction manuver*
- Tidak boleh melakukan penekanan fundus



Gambar 6.4. Manuver Woods Cockscrew

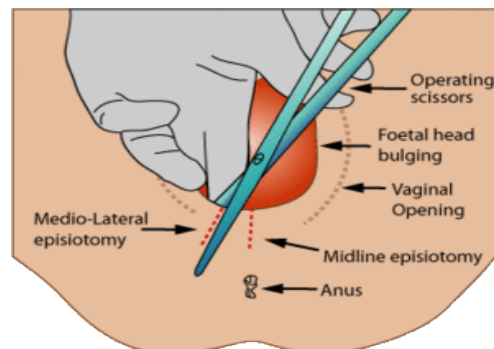
- j. M: *Manual removal posterior arm*. Dilakukan dengan cara mengeluarkan bahu belakang secara manual, yaitu:
- Fleksikan tangan pada siku (menekan fossa antecubiti untuk memfleksikan tangan bayi)
 - Usapkan tangan bayi sepanjang dada
 - Raih lengan depan bayi atau jari-jari tangan bayi
 - Keluarkan tangan bayi



Gambar 6.5. Manual Removal Posterior Arm

- k. E: Episiotomi

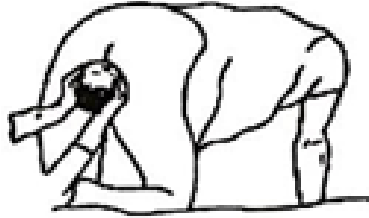
Episiotomi dapat dilakukan secara cukup luas untuk mengurangi obstruksi jaringan lunak dan memberi ruangan yang cukup untuk melakukan tindakan.



Gambar 6.6. Episiotomi

l. R: Roll over onto "all fours"

Tujuannya untuk memudahkan menggapai bahu belakang bayi atau Gaskin Manuver.



Gambar 6.7. Manuver Gaskin

- m. Jika cara-cara atau seluruh manuver tersebut juga tidak berhasil atau gagal melahirkan bayi maka bersiap untuk melakukan hal berikut ini.
 - a. Mematahkan klavikula atau humerus
 - b. Simfisiotomi
 - c. Zavanelli maneuver (*cephalic replacement*) yaitu membalikkan gerakan perputaran dalam persalinan. Pada kepala bantu fleksi dan memasukkan kembali kepala dan mendorong ke atas, putar menjadi lintang, *disengaged* dan kolaborasi dengan dokter untuk melakukan tindakan operasi SC.
- n. Jika Bayi sudah Lahir. Lakukan perawatan bayi baru lahir dan IMD bila memungkinkan
- o. Setelah tindakan dilakukan, evaluasi untuk antisipasi HPP dan atonia uteri dengan manajemen aktif kala III dan infus oksitosin 20 IU dalam RL 500 cc
- p. Robekan Luas jalan lahir diantisipasi dengan episiotomi mediolateral
- q. Lakukan personal hygiene ibu setelah tindakan pertolongan persalinan selesai
- r. Lakukan pemeriksaan bayi untuk melihat adanya cedera pada bayi berupa Erb's paralysis, dan fraktur humerus.
- s. Kembalikan klien pada posisi semula dengan cara mengangkat bokong dan tarik pelak/pengalas bokong
- t. Melepas handscoon dan masukkan kedalam larutan klorin 0,5%, merendam dalam posisi terbalik
- u. Bantu pasien mengatur posisi yang nyaman
- v. Kembalikan peralatan pada tempatnya, buka sampiran
- w. Bersihkan dan rapikan lingkungan
- x. Melepas APD
- y. Mencuci tangan dengan prinsip enam langkah yang benar
- z. Dokumentasikan prosedur dan hasil observasi

D. Rating Scale Belajar Keterampilan

DISTOSIA BAHU

Nilailah setiap langkah/kinerja yang diamati dengan menggunakan skala sbb:

- 0 = Bila Langkah atau tugas tidak dikerjakan
- 1 = Langkah dilakukan tetapi tidak sempurna
- 2 = Langkah dilakukan dengan sempurna

No	Komponen	Nilai			
		0	1	2	Score
A. Sikap					
1.	Menyapa klien dengan ramah dan sopan				10
2.	Memperkenalkan diri kepada klien				
3.	Teruji menjaga privacy klien				
4.	Percaya diri				
5.	Teruji menjelaskan maksud dan tujuan				
B. Isi					
1.	Meletakkan alat secara ergonomis didekat pasien				36
2.	Memasang sampiran				
3.	Petugas menggunakan APD (sesuai kondisi pasien)				
4.	A: <i>Ask for help.</i> Meminta bantuan dua orang sebagai asisten persalinan dan 1 orang bersiap sebagai perawat bayi.				
5.	L: <i>Lifting the legs and buttocks.</i> Dilakukan dengan cara, yaitu: Manuver Mcroberts: Mengfleksikan paha ke arah abdomen, dimana maneuver ini membutuhkan asisten untuk menarik paha ibu bersalin kearah perut ibu.				
6.	A: <i>Anterior shoulder disimpaction.</i> Dilakukan dengan dua cara, yaitu: a. Pendekatan perabdominal: Manuver Mazzanti: Melakukan penekanan suprapubik dengan ujung genggaman tangan pada bagian belakang bahu depan bayi untuk membebaskannya. b. Pendekatan pervaginam Manuver Rubin: Melakukan adduksi bahu depan bayi dengan				

	menekan bagian belakang bahu bayi (bahu didorong ke arah dada. Tidak boleh menekan fundus uteri.				
7.	R: <i>Rotation of posterior shoulder</i> . Dilakukan dengan dua cara pemuturan bahu belakang atau posterior 180°, yaitu: Manuver Woods Cockscrew: a. penekanan pada bagian depan bahu belakang b. Simultan dengan <i>anterior disimpaction manuver</i> c. Tidak boleh melakukan penekanan fundus				
8.	M: <i>Manual removal posterior arm</i> . Dilakukan dengan cara mengeluarkan bahu belakang secara manual, yaitu: a. Fleksikan tangan pada siku (menekan fossa antecubiti untuk memfleksikan tangan bayi) b. Usapkan tangan bayi sepanjang dada c. Raih lengan depan bayi atau jari jari tangan bayi d. Keluarkan tangan bayi				
9.	E: Episiotomi Episiotomi dapat dilakukan secara cukup luas untuk mengurangi obstruksi jaringan lunak dan memberi ruangan yang cukup untuk melakukan tindakan.				
10.	R: <i>Roll over onto "all fours"</i> Tujuannya untuk memudahkan menggapai bahu belakang bayi atau Gaskin Manuver.				
11.	Jika cara-cara atau seluruh manuver tersebut juga tidak berhasil atau gagal melahirkan bayi maka bersiap untuk melakukan hal berikut ini. a. Mematahkan klavikula atau humerus b. Simfisiotomi c. Zavanelli maneuver (<i>cephalic replacement</i>) yaitu membalikkan gerakan perputaran dalam persalinan. Pada kepala bantu fleksi				

	dan memasukkan kembali kepala dan mendorong ke atas, putar menjadi lintang, <i>disengaged</i> dan kolaborasi dengan dokter untuk melakukan tindakan operasi SC.				
12.	Jika Bayi sudah Lahir. Lakukan perawatan bayi baru lahir dan IMD bila memungkinkan				
13.	Setelah tindakan dilakukan, evaluasi untuk antisipasi HPP dan atonia uteri dengan manajemen aktif kala III dan infus oksitosin 20 IU dalam RL 500 cc				
14.	Jika terjadi robekan jalan lahir, lakukan penjahitan perinerum. Robekan Luas jalan lahir diantisipasi dengan episotomi mediolateral				
15.	Lakukan personal hygiene ibu setelah tindakan pertolongan persalinan selesai				
16.	Lakukan pemeriksaan bayi untuk melihat adanya cedera pada bayi berupa Erb's paralysis, dan fraktur humerus				
17.	Kembalikan klien pada posisi semula dengan cara mengangkat bokong dan tarik perlek/pengalas bokong				
18.	Melepas handscoon dan masukkan kedalam larutan klorin 0,5%, merendam dalam posisi terbalik				
C. Terminasi					
1.	Melakukan evaluasi tindakan				14
2.	Berpamitan dengan pasien				
3.	Membereskan dan mengembalikan alat				
4.	Mencuci tangan				
5.	Melaksanakan secara sistematis				
6.	Menggunakan bahasa yang mudah dimengerti				
7.	Mendokumentasikan hasil tindakan				
Total Score					60
Nilai Akhir = Jumlah score yang diperoleh: Total Score keseluruhan x 100/total score					
Tanda Tangan Penguji					
Referensi : Simanjuntak, L. (2021). Obstetrik Emergensi. In: Fakultas Kedokteran UHN.					

E. Daftar Pustaka

- Akbar, H., Yudho Prabowo, A., & Rodiani, R. (2017). Kehamilan Aterm Dengan Distosia Bahu. *Medula, medicalprofession journal of lampung university*, 7(4), 1-7.
- Hill, M. G., & Cohen, W. R. (2016). Shoulder dystocia: prediction and management. *Women's Health*, 12(2), 251-261.
- Huntley, M., & Smith, J. D. (2017). Management of shoulder dystocia using the HELPERR mnemonic. *British Journal of Midwifery*, 25(4), 240-244.
- Rukiyah, A. Y., & Yulianti, L. (2019). Asuhan Kebidanan Kegawatdaruratan Maternal dan Neonatal. *Jakarta: CV. Trans Info Media*.
- Simanjuntak, L. (2021). Obstetrik Emergensi. In: Fakultas Kedokteran UHN.

F. Glosarium

A

Adduksi: Gerak badan atau tangan ke arah atau melintasi garis tengah tubuh, atau menyatukan jari tangan atau kaki.

Anasarca: Kondisi pembengkakan yang terjadi di seluruh tubuh seperti di tangan, kaki, wajah dan bagian tubuh lainnya akibat retensi garam, air dan adanya kerusakan organ yang cukup parah.

Anterior: Depan atau semakin dekat ke depan.

APD: Alat Pelindung Diri yang digunakan saat bekerja seperti penutup kepala, masker, kacamata google, celemek dan sepatu boot.

Atonia Uteri: Kegagalan otot rahim untuk berkontraksi setelah melahirkan bayi sehingga tidak dapat menekan pembuluh darah yang berada di tempat menempelnya plasenta dalam 15 detik setelah dilakukan rangsangan taktil.

Asidosis Akut: Kondisi yang terjadi ketika kadar asam di dalam tubuh sangat tinggi.

Antero posterior: Berjalan horisontal dari depan kebelakang dan tegak lurus pada bidang frontal. Gerak tubuh mengarah dari depan ke belakang badan.

Asfiksia: Suatu kondisi tubuh kekurangan kadar oksigen.

D

Distosia Bahu: Suatu keadaan sulitnya melahirkan bahu depan janin setelah kepala lahir dengan tanda tidak adanya putaran paksi luar dan tertariknya kepala hingga dagu tertahan pada perineum.

DTT: Desinfektan Tingkat Tinggi adalah suatu langkah memproses alat habis pakai yang telah digunakan untuk suatu tindakan untuk menghilangkan mikroorganisme.

E

Episiotomi: Tindakan insisi pada perineum yang dilakukan saat persalinan bertujuan untuk memperbesar jalan lahir.

Ergonomis: Cara kerja atau meletakkan Barang atau alat yang digunakan dalam posisi minimal atau terdekat, secara berurutan, sistematis sesuai dengan kebutuhan awal dan mudah dilihat dan dijangkau.

F

Fundus: Bagian puncak dari rahim ibu saat sedang berada dalam masa kehamilan.

Fleksi: Gerak otot tubuh mengurangi sudut antara dua tulang seperti saat menekuk lengan, kaki, saat kepala menunduk, dan saat pinggang menekuk untuk membungkuk.

Fistula: Saluran abnormal yang berkembang antara dua bagian tubuh yang terpisah dari satu sama lain.

Fraktur klavikula: Klavikula atau tulang kolar adalah patah tulang klavikula selama proses persalinan.

Fraktur humerus: Patahnya tulang lengan atau humerus yang diakibatkan oleh karena rusak atau terputusnya jaringan tulang humerus.

Fossa Antecubiti: Otot-otot yang mengelilingi lubang di area siku atau merupakan sebuah lekukan yang terletak di depan siku dan berbentuk segitiga.

Foramen Obturator: Celah yang terletak di antara ishium dan pubis; pada wanita celah ini lebih kecil daripada pada pria, serta lebih berbentuk segitiga.

H

Hipoksia: Kondisi ketika tubuh kekurangan pasokan oksigen di sel dan jaringan, untuk menjalankan fungsi normalnya.

HPP: Hemorrhagic Post Partum. Keluarnya darah dari jalan lahir lebih dari 500 ml segera setelah persalinan.

I

IMD: Inisiasi Menyusu Dini. Proses bayi menyusu segera setelah dilahirkan, di mana bayi dibiarkan mencari puting susu ibunya sendiri.

Impaksi: Kondisi terjebak atau tidak keluar sepenuhnya.

L

Laserasi: Robekan atau luka terbuka pada kulit yang menyebabkan robeknya jaringan atau disintegritas jaringan.

M

Manuver obstetrik: Teknik atau tindakan yang dilakukan petugas kesehatan selama pertolongan persalinan.

Maternal: Sesuatu yang berhubungan dengan ibu.

N

Neonatal: sesuatu yang berhubungan dengan bayi baru lahir.

O

Obesitas: Suatu kondisi saat lemak yang menumpuk di dalam tubuh berlebihan akibat kalori masuk lebih banyak dibandingkan yang dibakar.

Oblik: Posisi bayi dalam keadaan diagonal atau miring melintasi rahim.

Obstruksi: Suatu kondisi adanya sumbatan atau penyumbatan.

P

Putaran Paksi Luar: Gerakan kembali ke posisi sebelum putaran paksi dalam terjadi, untuk menyesuaikan kedudukan kepala dengan punggung anak.

Pleksus Brachialis: Anyaman saraf yang keluar dari saraf tulang belakang leher dan mensarafi anggota gerak atas mulai dari bahu hingga jari tangan.

Posterior: Belakang atau semakin dekat ke belakangan.

Promotorium Sakral: Bagian depan paling atas dari tulang sacrum dinamakan promontorium, dimana bagian ini bila dapat teraba pada waktu pemeriksaan dalam, berarti ada kesempitan panggul.

R

Ramus Pubis: Tulang bagian bawah pembentuk bagian posterior bawah tulang panggul dan pubis.

Rupture Uteri: Kondisi robeknya dinding rahim selama kehamilan dan persalinan.

S

Sacrum: Tulang kelangkang berbentuk segitiga, melebar di atas dan meruncing ke bawah. Terletak di sebelah belakang antara kedua pangkal paha.

Spina Isciadica: tulang yang ada disebelah bawah tulang usus dengan pinggir belakang menonjol.

Simfisiotomi: Tindakan operasi memperbesar pelvis dengan memotong jaringan ikat tulang pubis di bagian depan pelvis.

Simfisis Pubis: Bagian sendi penghubung dua tulang pubis.

T

Traksi: Tarikan pada bagian distal anggota badan.

Turtle Sign: Kepala bayi tertarik kembali ke perineum ibu setelah keluar dari vagina seperti kura-kura.

V

Vertebra Lumbalis: Tulang pinggang. Bagian dari kolumna vertebralis yang terdiri dari lima ruas tulang dengan ukuran ruas lebih besar dibandingkan dengan ruas tulang leher maupun tulang punggung.

BAB VII

PRAKTIKUM MANUAL PLASENTA

Putu Ayu Ratna Darmayanti, S.Tr.Keb.,M.Kes



A. Deskripsi

Bab ini mengenalkan pada mahasiswa tentang konsep teori manual plasenta dan prosedur penatalaksanaannya pada ibu bersalin yang didasari dengan konsep-konsep terkini dan hasil penelitian.

B. Tujuan Pembelajaran**1. Tujuan Pembelajaran Umum**

Setelah mengikuti penuntun belajar praktik ini, mahasiswa mampu melakukan praktik manual plasenta pada ibu bersalin.

2. Tujuan Pembelajaran Khusus

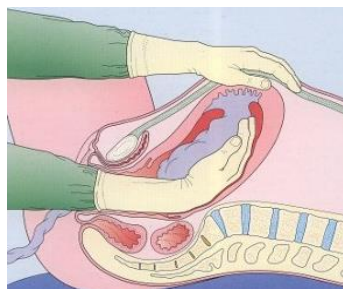
Setelah mempelajari materi ini diharapkan dapat:

- a. Mahasiswa mampu memahami tentang konsep manual plasenta pada ibu bersalin
- b. Mahasiswa mampu melakukan tindakan manual plasenta pada ibu bersalin

C. Uraian Materi**1. Definisi**

Manual plasenta merupakan suatu prosedur tindakan manual menggunakan tangan yang bertujuan untuk melahirkan plasenta dari tempat implantasinya di dinding uterus keluar sampai vagina. Tangan penolong persalinan masuk ke dalam kavum uteri dengan menggunakan sarung tangan panjang sampai siku (Kurniarum, 2016).

Manual plasenta merupakan tindakan yang dapat dilakukan apabila ibu bersalin mengalami retensio plasenta yang artinya plasenta tidak lahir setelah 30 menit sejak bayi lahir (Darmayanti, 2014). Tindakan manual plasenta akibat dari terjadinya retensio plasenta dapat terjadi karena berbagai faktor risiko yaitu ibu bersalin umur lebih dari 35 tahun, grandemultipara dan kontraksi uterus atau HIS kurang adekuat (Sianturi, 2015)



Gambar 7.1. Manual Plasenta

2. Tujuan

Tujuan dari manual plasenta pada ibu bersalin yaitu membantu melahirkan plasenta secara manual dan mencegah terjadinya perdarahan pasca persalinan (Rohani, 2014).

3. Indikasi

Indikasi dilakukan prosedur manual plasenta pada ibu bersalin yaitu karena kontraksi uterus lembek dan plasenta sulit terlepas dari tempat implantasinya seperti plasenta akreta. Hal ini bisa terjadi karena, plasenta menempel terlalu dalam pada dinding uterus, bentuk plasenta seperti plasenta anularis dan membranasea dan ukuran plasenta terlalu kecil (Rukiyah & Yulianti, 2019).

4. Kontra Indikasi

Kontra indikasi manual plasenta yaitu ibu bersalin dengan diagnosa plasenta inkreta, plasenta perkreta dan plasenta adhesive (Rukiyah & Yulianti, 2019).

5. Hal-hal yang diperhatikan

Menurut Kurniarum (2016), hal-hal yang diperhatikan saat melakukan manual plasenta yaitu sebagai berikut:

- a. Petugas menggunakan APD dan sarung tangan steril ukuran panjang sampai siku untuk mencegah tertular infeksi
- b. Memperhatikan teknik dan posisi tangan penolong saat melepaskan plasenta agar tidak menyebabkan plasenta robek dan komplikasi seperti inversio uteri, perforasi dinding uteri dan infeksi.
- c. Melakukan pengosongan kandung kemih sebelum tindakan manual plasenta
- d. Melakukan pemeriksaan umum keadaan ibu, tanda vital seperti tekanan darah, pernafasan, nadi dan suhu. Kemudian, memasang infus dan menilai perdarahan pervaginam.

6. Persiapan Alat

Menurut Rohani (2014), persiapan yang dibutuhkan selama tindakan manual plasenta adalah persiapan alat dan bahan, sebagai berikut:

- a. Infus Set
- b. Larutan infus RL atau NaCL 0.9% 500 ml
- c. Oksitosin 20 unit
- d. Lampu Sorot
- e. Kateter Nelaton
- f. Tensimeter dan Stetoskop
- g. Bengkok
- h. Korentang
- i. Spuit

- j. Kassa Steril pada kom kecil
- k. Kapas DTT pada kom kecil
- l. Sarung tangan panjang steril dan DTT 1 buah pada bak instrumen
- m. APD (celemek, masker, kacamata pelindung, penutup kepala dan sepatu boot)
- n. Pengalas bokong dan penutup perut bawah
- o. Larutan klorin 0,5%
- p. Kendi atau wadah plasenta
- q. Tempat sampah medis
- r. Sampiran jika diperlukan

7. Prosedur Tindakan dan Rating scale Tindakan

Menurut Rukiyah and Yulianti (2019), prosedur tindakan dalam manual plasenta, yaitu sebagai berikut:

- 1) Menyiapkan dan meletakkan alat dan bahan secara ergonomis didekat pasien
- 2) Menjelaskan maksud, tujuan, prosedur dan *informed consent* tindakan manual plasenta
- 3) Memasang sampiran
- 4) Petugas menggunakan APD (sesuai kondisi pasien)
- 5) Mengatur pasien pada bed ginekologi dengan posisi litotomi
- 6) Memasang infus NaCl 0,9% atau RL dengan 40 tetes per menit
- 7) Mencuci tangan sampai siku dengan prinsip enam langkah yang benar
- 8) Menggunakan sarung tangan pendek DTT/Steril pada kedua tangan
- 9) Memakai sarung tangan steril panjang sampai siku pada tangan kanan
- 10) Melakukan vulva hygiene dan mengosongkan kandung kemih menggunakan kateter nelaton
- 11) Tangan kiri memegang tali pusat menggunakan klem sambal ditegangkan perlahan sejajar lantai
- 12) Tangan kanan masuk ke dalam vagina secara obstetrik dengan menyatukan jari-jari tangan sambil menyusuri sisi bawah tali pusat dan punggung tangan petugas menghadap ke arah bawah.
- 13) Setelah mencapai serviks, minta bantuan asisten untuk menegangkan klem tali pusat.
- 14) Petugas memindahkan tangan kiri diatas fundus uteri dari luar untuk menahan uterus tetap diam
- 15) Tangan kanan petugas masuk kembali sampai ke dalam kavum uteri dan mencari insersi pinggir implantasi plasenta
- 16) Secara perlahan membentangkan tangan obstetrik menjadi datar yaitu jari-jari saling merapat seperti memberikan salam

- 17) Memperluas pelepasan plasenta dengan menggerakkan tangan menyisir plasenta dengan gerakan ke kanan dan ke kiri (dengan sisi ulna) yang sangat lembut sambil digeserkan ke atas sampai seluruh plasenta terlepas dari dinding rahim. Curigai adanya plasenta akreta jika plasenta sulit dilepaskan dan siapkan tindakan bedah
- 18) Sementara tangan kanan masih di dalam kavum menggenggam seluruh plasenta yang telah lepas
- 19) Menginstruksikan asisten untuk menarik tali pusat, sambil tangan kanan membawa plasenta keluar
- 20) Memindahkan tangan kiri dari fundus ke supra simpisis dengan posisi tangan dorso kranial untuk menahan segmen bawah uterus agar tidak terjadi prolapse uteri pada saat plasenta dikeluarkan.
- 21) Jika seluruh plasenta sudah lepas dan berada di luar, tangan kiri petugas melakukan masase uterus
- 22) Memeriksa kelengkapan plasenta setelah dilahirkan
- 23) Memeriksa ibu dan melakukan penjahitan bila ada robekan serviks atau vagina juga episiotomi
- 24) Memberitahukan hasil tindakan kepada klien
- 25) Membersihkan alat-alat dan memasukkan dalam larutan clorin 0,5%, membuang sampah dan membersihkan tempat tidur
- 26) Membersihkan dan memposisikan ibu dengan meluruskan kaki, menutup bagian genital dengan kain bersih
- 27) Melepas handscoon dan masukkan kedalam larutan klorin 0,5%, merendam dalam posisi terbalik
- 28) Melepas APD
- 29) Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir
- 30) Mengobservasi kontraksi uterus, perdarahan pervaginam dan tanda vital
 - a. Setiap 15 menit pada jam pertama
 - b. Setiap 30 menit pada jam kedua
- 31) Dokumentasikan prosedur dan hasil observasi

D. Rating Scale Belajar Keterampilan

MANUAL PLASENTA

Nilailah setiap langkah/kinerja yang diamati dengan menggunakan skala sbb:

- 0 = Bila Langkah atau tugas tidak dikerjakan
- 1 = Langkah dilakukan tetapi tidak sempurna
- 2 = Langkah dilakukan dengan sempurna

No	Komponen	Nilai			Score
		0	1	2	
A. Sikap					
1.	Menyapa klien dengan ramah dan sopan				10
2.	Memperkenalkan diri kepada klien				
3.	Teruji menjaga privacy klien				
4.	Percaya diri				
5.	Teruji menjelaskan maksud dan tujuan				
B. Isi					50
1.	Menyiapkan dan meletakkan alat dan bahan secara ergonomis didekat pasien				
2.	Memasang sampiran				
3.	Petugas menggunakan APD (sesuai kondisi pasien)				
4.	Mengatur pasien pada bed ginekologi dengan posisi litotomi				
5.	Memasang infus Nacl 0,9% atau RL dengan 40 tetes per menit				
6.	Mencuci tangan sampai siku dengan prinsip enam langkah yang benar				
7.	Menggunakan sarung tangan pendek DTT/Steril pada kedua tangan dan sarung tangan steril panjang sampai siku pada tangan kanan				
8.	Melakukan vulva hygiene dan mengosongkan kandung kemih menggunakan kateter nelaton				
9.	Tangan kiri memegang tali pusat menggunakan klem sambal ditegangkan perlahan sejajar lantai				
10.	Tangan kanan masuk ke dalam vagina secara obstetrik dengan menyatukan jari-jari tangan sambil menyusuri sisi bawah tali pusat dan punggung tangan petugas menghadap ke arah bawah.				

11.	Setelah mencapai serviks, minta bantuan asisten untuk menegangkan klem tali pusat.				
12.	Petugas memindahkan tangan kiri diatas fundus uteri dari luar untuk menahan uterus tetap diam				
13.	Tangan kanan petugas masuk kembali sampai ke dalam kavum uteri dan mencari insersi pinggir implantasi plasenta				
14.	Secara perlahan membentangkan tangan obstetrik menjadi datar yaitu jari-jari saling merapat seperti memberikan salam				
15.	Memperluas pelepasan plasenta dengan menggerakkan tangan menyisir plasenta dengan gerakan ke kanan dan ke kiri (dengan sisi ulna) yang sangat lembut sambil digeserkan ke atas sampai seluruh plasenta terlepas dari dinding rahim. Curigai adanya plasenta akreta jika plasenta sulit dilepaskan dan siapkan tindakan bedah				
16.	Sementara tangan kanan masih di dalam kavum sambil menggenggam seluruh plasenta yang telah lepas				
17.	Menginstruksikan asisten untuk menarik tali pusat, sambil tangan kanan membawa plasenta keluar				
18.	Memindahkan tangan kiri dari fundus ke supra simpisis dengan posisi tangan dorso kranial untuk menahan segmen bawah uterus agar tidak terjadi prolapse uteri pada saat plasenta dikeluarkan				
19.	Jika seluruh plasenta sudah lepas dan berada di luar, tangan kiri petugas melakukan masase uterus				
20.	Memeriksa kelengkapan plasenta setelah dilahirkan				
21.	Memeriksa ibu dan melakukan penjahitan bila ada robekan serviks atau vagina juga episiotomi				
22.	Membereskan alat-alat dan memasukkan dalam larutan clorin 0,5%, membuang sampah dan membersihkan tempat tidur				

23	Membersihkan dan memposisikan ibu dengan meluruskan kaki, menutup bagian genital dengan kain bersih				
24	Melepas handscoon dan masukkan kedalam larutan klorin 0,5%, merendam dalam posisi terbalik				
25	Mengobservasi kontraksi uterus, perdarahan pervaginam dan tanda vital: a. Setiap 15 menit pada jam pertama b. Setiap 30 menit pada jam kedua				
C. Terminasi					
1.	Melakukan evaluasi tindakan				14
2.	Berpamitan dengan pasien				
3.	Membereskan dan mengembalikan alat				
4.	Mencuci tangan				
5.	Melaksanakan secara sistematis				
6.	Menggunakan bahasa yang mudah dimengerti				
7.	Mendokumentasikan hasil tindakan				
Total Score					
Nilai Akhir = Jumlah score yang diperoleh: Total Score keseluruhan x 100/total score					
Tanda Tangan Penguji					
Referensi : Rukiyah, A. Y., & Yulianti, L. (2019). Asuhan Kebidanan Kegawatdaruratan Maternal dan Neonatal. <i>Jakarta: CV. Trans Info Media.</i>					

E. Daftar Pustaka

- Darmayanti, D. (2014). Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Retensio Plasenta Di Rsud Dr. H. Moch. Ansari Saleh Banjarmasin. *An-Nadaa: Jurnal Kesehatan Masyarakat (e-Journal)*, 1(2), 77-81.
- Kurniarum, A. (2016). Praktikum Asuhan Kebidanan Kegawatdaruratan Maternal Neonatal. In: Pusdik SDM Kesehatan, Kementrian Kesehatan Republik Indonesia.
- Rohani, D. (2014). Asuhan kebidanan pada masa persalinan. *Salemba Medika: Jakarta*.
- Rukiyah, A. Y., & Yulianti, L. (2019). Asuhan Kebidanan Kegawatdaruratan Maternal dan Neonatal. *Jakarta: CV. Trans Info Media*.
- Sianturi, E. (2015). Hubungan Pengetahuan Dan Sikap Bidan Tentang Retensio Dengan Penatalaksanaan Manual Plasenta Di Wilayah Kerja Puskesmas Huta Rakyat Sidikalang. *Jurnal Ilmiah PANNMED (Pharmacist, Analyst, Nurse, Nutrition, Midwivery, Environment, Dentist)*, 10(2), 139-146.

F. Glosarium

A

APD: Alat Pelindung Diri yang digunakan saat bekerja seperti penutup kepala, masker, kacamata google, celemek dan sepatu boot.

D

DTT: Desinfektan Tingkat Tinggi adalah suatu langkah memproses alat habis pakai yang telah digunakan untuk suatu tindakan untuk menghilangkan mikroorganisme.

Dorso Kranial: Posisi menekuk lutut dan melebarkan kedua kaki, memakai bantal di kepala, kedua telapak kaki tetap menapak di tempat tidur dan kedua tangan di letakkan diatas kepala pada ibu bersalin.

E

Episiotomi: Tindakan Insisi pada daerah vagina atau perineum saat proses persalinan.

Ergonomis: Cara kerja atau meletakkan Barang atau alat yang digunakan dalam posisi minimal atau terdekat, secara berurutan, sistematis sesuai dengan kebutuhan awal dan mudah dilihat dan dijangkau.

F

Fundus Uteri: bagian puncak dari rahim ibu saat sedang berada dalam masa kehamilan.

G

Grandemultipara: Kehamilan dan melahirkan bayi hidup atau mati lebih dari 5 kali.

H

HIS: Kekuatan nyeri fisiologis yang utama selama kala II. His yang terjadi pada responden bersifat normal, yaitu kontraksi uterus terjadi 3 – 4 kali dalam 10 menit selama 40 – 60 menit dengan interval 2 – 3 menit.

I

Implantasi: Proses menempelnya embrio atau plasenta di dalam dinding uterus.

Infeksi: Kondisi tubuh saat ada mikroorganisme atau virus masuk ke dalam tubuh dan menimbulkan penyakit tertentu.

Inversio Uteri: Kondisi uterus pada posisi terbalik dengan fundus uteri masuk sebagian atau seluruhnya ke dalam rongga uterus, vagina, bahkan keluar dari vulva.

Informed Consent: Persetujuan tindakan atau prosedur medik yang diberikan oleh pasien atau keluarga kepada petugas kesehatan.

K

Kavum Uteri: Ruang dalam rahim yang berukuran 7-10 cm.

Kateter Nelaton: Pipa atau selang atau tabung fleksibel yang digunakan untuk drainase urine jangka pendek.

Kontraksi Uterus: Proses pengerutan dan penegangan otot rahim terjadi saat tubuh melepaskan hormon oksitosin yang ditunjukkan dengan tanda perut ibu bersalin dibagian atas rahim mengencang, sehingga bayi terdorong ke bawah untuk masuk ke jalan lahir.

L

Litotomi: Posisi pasien terlentang dengan pinggul, lutut tertekuk dan paha membuka.

Larutan Klorin 0,5%: Suatu larutan yang berfungsi sebagai desinfektan yang terbuat dari campuran 0,095 liter Bayclin 5,25% dan air sampai didapatkan volume 1 liter.

M

Massage Uterus: Tindakan pemijatan ringan dengan arah pijatan memutar searah jarum jam yang dilakukan untuk mempertahankan uterus berkontraksi dengan baik.

N

NaCL: Cairan infus Natrium Chlorida.

O

Obstetrik: Posisi jari-jari tangan disatukan menguncup dengan arah punggung tangan menghadap kebawah.

P

Plasenta Akreta: Kondisi implantasi plasenta menginvasi lapisan superfisial dari miometrium.

Plasenta Adhesiva: Kondisi lapisan jaringan ikat Nitabush tipis sampai hilang sebagian atau seluruhnya yang menyebabkan plasenta susah terlepas.

Plasenta Inkreta: Kondisi implantasi plasenta hingga lapisan miometrium yang lebih dalam.

Plasenta Perkreta: Perlekatan plasenta menembus miometrium hingga lapisan serosa dari uterus.

Perforasi: Kondisi terjadinya luka atau lubang pada organ tubuh.

R

Retensio Plasenta: Kondisi plasenta belum lahir selama 30 menit setelah bayi lahir.

RL: Cairan Infus Ringer Lactat

S

Supra simpisis: Bagian tubuh perut bawah.

V

Vulva Hygiene: Membersihkan vulva dan daerah sekitarnya pada pasien wanita yang tidak dapat melakukannya sendiri.

BAB VIII

PRAKTIKUM KOMPRESI AORTA ABDOMINALIS

Putu Ayu Ratna Darmayanti, S.Tr.Keb.,M.Kes



**Nuansa
Fajar
Cemerlang**

A. Deskripsi

BAB ini mengenalkan pada mahasiswa tentang konsep teori kompresi aorta abdominalis dan prosedur penatalaksanaannya pada ibu bersalin yang didasari dengan konsep-konsep terkini dan hasil penelitian.

B. Tujuan Pembelajaran**1. Tujuan Pembelajaran Umum**

Setelah mengikuti penuntun belajar praktik ini, mahasiswa mampu melakukan praktik kompresi aorta abdominalis pada ibu bersalin.

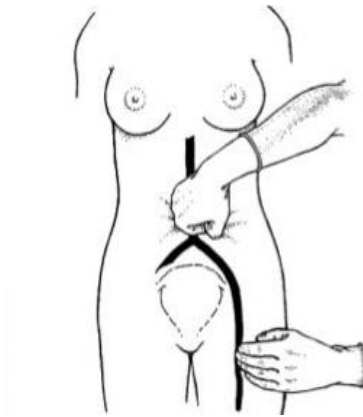
2. Tujuan Pembelajaran Khusus

Setelah mempelajari materi ini diharapkan dapat:

- a. Mahasiswa mampu memahami tentang konsep kompresi aorta abdominalis pada ibu bersalin
- b. Mahasiswa mampu melakukan tindakan kompresi aorta abdominalis pada ibu bersalin

C. Uraian Materi**1. Definisi**

Kompresi aorta abdominalis merupakan suatu tindakan atau intervensi sederhana yang dilakukan dengan cara memusatkan dan menyalurkan seluruh berat badan pada kepalan tangan petugas untuk menekan perut disebelah kiri dari umbilikus tengah pasien dan menghentikan arteri femoralis terbuka (Andreatta, Perosky, & Johnson, 2012). Sebelum tindakan kompresi aorta abdominalis dilakukan, sebaiknya terlebih dahulu melakukan penilaian penyebab perdarahan pasca persalinan sambil melakukan massage uterus dan memberikan intervensi Kompresi Bimanual Internal (KBI) dan Kompresi Bimanual Eksternal (KBE) (Mousa, Blum, Abou El Senoun, Shakur, & Alfiric, 2014).



Gambar 8.1. Kompresi Aorta Abdominalis

2. Tujuan

Tujuan dilakukannya intervensi kompresi aorta abdominalis yaitu untuk menghentikan perdarahan pervaginam melalui berkurangnya aliran darah di daerah distal dan aliran darah pada arteri uterina. Kompresi aorta abdominalis dapat dijadikan alternatif intervensi yang bisa diterapkan sambil menyiapkan intervensi definitif dan selama mempersiapkan dan melakukan rujukan ke fasilitas kesehatan (Evenson & Anderson, 2013).

3. Indikasi

Menurut Sarim (2020), indikasi dilakukan tindakan kompresi aorta abdominalis pada ibu bersalin yaitu saat terjadi atonia uteri dan overdistensi uterus.

4. Kontrak Indikasi

Kontra indikasi tindakan kompresi aorta abdominalis pada ibu bersalin yaitu saat terjadi inversio uteri (Sarim, 2020).

5. Hal-hal yang diperhatikan

Menurut Lalonde (2012), hal-hal yang diperhatikan saat melakukan tindakan kompresi aorta abdominalis, yaitu sebagai berikut:

- a. Pada diri sendiri yaitu dengan menggunakan APD dan sarung tangan steril
- b. Pada pasien bersalin
 - 1) Mencegah terjadinya infeksi
 - 2) Melakukan pengosongan kandung kemih sebelum tindakan kompresi aorta abdominalis
 - 3) Memastikan perdarahan disebabkan karena atonia uteri
 - 4) Memastikan plasenta telah lahir lengkap
 - 5) Segera melakukan kompresi bimanual internal dan eksternal selama 5 menit sebelum melakukan kompresi aorta abdominal.

- 6) Melepaskan penekanan atau kompresi setiap 30 menit dan mengulang kembali secara berulang yang bertujuan agar secara intermiten ekstremitas inferior terus mendapatkan aliran darah (Sarim, 2020).

6. Persiapan Alat

Menurut Adil (2020), alat dan bahan yang diperlukan saat tindakan kompresi aorta abdominalis, yaitu sebagai berikut:

- a. Infus Set
- b. Larutan infus RL atau NaCl 0.9% 500 ml
- c. Oksitosin 20 unit
- d. Lampu Sorot
- e. Kateter Nelaton
- f. Tensimeter dan Stetoskop
- g. Bengkok
- h. Korentang
- i. Spuit
- j. Kassa Steril pada kom kecil
- k. Sarung tangan DTT 1 buah pada bak instrumen
- l. APD (celemek, masker, kaca mata pelindung, penutup kepala dan sepatu boot)
- m. Pengalas bokong
- n. Larutan klorin 0,5%
- o. Tempat sampah medis
- p. Sampiran jika diperlukan

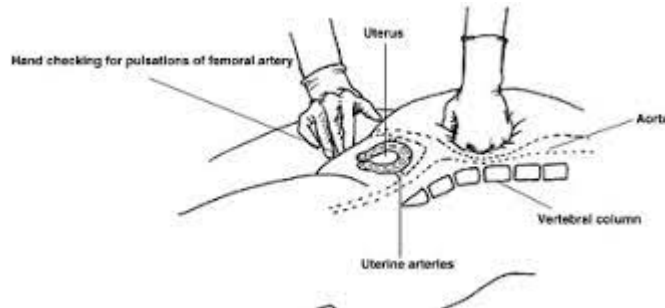
7. Prosedur Tindakan dan Rating scale Tindakan

Menurut Adil (2020), prosedur tindakan kompresi aorta abdominalis, yaitu sebagai berikut:

- a. Meletakkan alat secara ergonomis didekat pasien
- b. Menjelaskan maksud, tujuan dan *informed consent* tindakan kompresi aorta abdominalis
- c. Memasang sampiran
- d. Petugas menggunakan APD (sesuai kondisi pasien)
- e. Pasang infus NaCl 0,9% atau RL yang berisi oksitosin 20 IU
- f. Mencuci tangan dengan prinsip 6 langkah yang benar
- g. Meletakkan pelak kecil atau pengalas di bawah bokong pasien dan mengatur posisi pasien terlentang dengan ketinggian pasien sama dengan penolong yang berada di sisi kanan.
- h. Kedua kaki pasien diletakkan pada dasar yang rata tanpa memakai penopang kaki dengan sedikit fleksi pada articulatio coxae

- i. Meraba pulsasi arteri femoralis pada lipat paha, yaitu pada perpotongan garis lipat paha dengan garis horisontal yang melalui titik 1 cm diatas dan sejajar dengan tepi atas simfisis pubis. Pastikan pulsasi arteri teraba dengan baik
- j. Setelah teraba pulsasi, jangan memindahkan kedua ujung jari dari titik pulsasi
- k. Mengepalkan tangan kiri dan tekankan bagian punggung jari telunjuk hingga kelingking pada umbilikus kearah kolumna vertebralis dengan arah tangan tegak lurus
- l. Pusatkan dan salurkan berat badan penolong pada tangan kiri secara perlahan karena jika hanya menggunakan kekuatan otot tangan maka penolong mudah kelelahan
- m. Tangan kanan meraba pulsasi arteri femoralis untuk mengetahui cukup atau tidaknya kompresi yang dilakukan
 - a. Jika pulsasi masih teraba artinya tekanan kompresi atau kepalan tangan belum cukup baik
 - b. Jika pulsasi berkurang atau berhenti, artinya kompresi atau kepalan tangan telah mencapai aorta abdominalis
- n. Jika perdarahan pervaginam masih berlanjut:
 - 1) Jika kontraksi uterus baik tetapi perdarahan masih berlangsung, maka lakukan KBE dan pertahankan posisi demikian hingga sampai di fasilitas rujukan
 - 2) Jika kompresi sulit untuk dilakukan secara terus-menerus, maka lakukan pemasangan tampon padat uterovaginal, memasang gurita ibu dengan kencang dan lakukan rujukan
 - 3) Kompresi baru dilepaskan bila perdarahan berhenti dan uterus berkontraksi dengan baik. Teruskan pemberian uterotonika
- o. Jika perdarahan pervaginam berhenti:
 - 1) Jika perdarahan berhenti tapi uterus tidak berkontraksi dengan baik, usahakan pemberian prostaglandin. Jika tidak ada atau uterus tetap tidak berkontraksi dengan baik sesudah diberikan prostaglandin, maka pertahankan posisi kompresi aorta abdominalis sampai di fasilitas rujukan
 - 2) Jika perdarahan berhenti dan uterus berkontraksi baik, maka pertahankan posisi kompresi aorta abdominalis dan memanggil asisten persalinan untuk membantu melakukan massage uterus
- p. Mengobservasi kontraksi uterus, perdarahan pervaginam dan tanda vital setiap 10 menit selama 2 jam
- q. Melepas handscoon dan masukkan kedalam larutan klorin 0,5%, merendam dalam posisi terbalik

- r. Bantu pasien mengatur posisi yang nyaman.
- s. Kembalikan peralatan pada tempatnya, buka sampiran
- t. Melepas APD
- u. Mencuci tangan dengan prinsip enam langkah yang benar
- v. Dokumentasikan prosedur dan hasil observasi.



Gambar 8.2. Aorta Abdominalis

D. Rating Scale Belajar Keterampilan

KOMPRESI AORTA ABDOMINALIS

Nilailah setiap langkah/kinerja yang diamati dengan menggunakan skala sbb:

- 0** = Bila Langkah atau tugas tidak dikerjakan
- 1** = Langkah dilakukan tetapi tidak sempurna
- 2** = Langkah dilakukan dengan sempurna

No	Komponen	Nilai			Score
		0	1	2	
A. Sikap					
1.	Menyapa klien dengan ramah dan sopan				10
2.	Memperkenalkan diri kepada klien				
3.	Teruji menjaga privacy klien				
4.	Percaya diri				
5.	Teruji menjelaskan maksud dan tujuan				
B. Isi					
1.	Menyiapkan dan meletakkan alat dan bahan secara ergonomis didekat pasien				46
2.	Memasang sampiran				
3.	Petugas menggunakan APD (sesuai kondisi pasien)				
4.	Memasang infus Nacl 0,9% atau RL yang berisi oksitosin 20 IU				
5.	Mencuci tangan dengan prinsip 6 langkah yang benar				
6.	Meletakkan pernak kecil atau pengalas di bawah bokong pasien dan mengatur posisi pasien terlentang dengan				

	ketinggian pasien sama dengan penolong yang berada di sisi kanan.				
7.	Kedua kaki pasien diletakkan pada dasar yang rata tanpa memakai penopang kaki dengan sedikit fleksi pada articulatio coxae				
8.	Meraba pulsasi arteri femoralis pada lipatan paha, yaitu pada perpotongan garis lipatan paha dengan garis horizontal yang melalui titik 1 cm di atas dan sejajar dengan tepi atas simfisis pubis. Pastikan pulsasi arteri teraba dengan baik				
9.	Setelah teraba pulsasi, jangan memindahkan kedua ujung jari dari titik pulsasi				
10.	Mengepalkan tangan kiri dan tekan bagian punggung jari telunjuk hingga keliling pada umbilicus ke arah kolumna vertebralis dengan arah tangan tegak lurus				
11.	Memusatkan dan salurkan berat badan penolong pada tangan kiri secara perlahan karena jika hanya menggunakan kekuatan otot tangan maka penolong mudah kelelahan				
12.	Tangan kanan meraba pulsasi arteri femoralis untuk mengetahui cukup atau tidaknya kompresi yang dilakukan a. Jika pulsasi masih teraba artinya tekanan kompresi atau kepalan tangan belum cukup baik b. Jika pulsasi berkurang atau berhenti, artinya kompresi atau kepalan tangan telah mencapai aorta abdominalis				
13.	Jika perdarahan pervaginam masih berlanjut: a. Jika kontraksi uterus baik tetapi perdarahan masih berlangsung, maka lakukan KBE dan pertahankan posisi demikian hingga sampai di fasilitas rujukan b. Jika kompresi sulit untuk dilakukan secara terus-menerus, maka lakukan pemasangan tampon padat uterovaginal, memasang gurita ibu dengan kencang dan lakukan rujukan c. Kompresi baru dilepaskan bila perdarahan berhenti dan uterus				

	berkontraksi dengan baik. Teruskan pemberian uterotonika				
14.	Jika perdarahan pervaginam berhenti: a. Jika perdarahan berhenti tapi uterus tidak berkontraksi dengan baik, usahakan pemberian prostaglandin. Jika tidak ada atau uterus tetap tidak berkontraksi dengan baik sesudah diberikan prostaglandin, maka pertahankan posisi kompresi aorta abdominalis sampai di fasilitas rujukan b. Jika perdarahan berhenti dan uterus berkontraksi baik, maka pertahankan posisi kompresi aorta abdominalis dan memanggil asisten persalinan untuk membantu melakukan massage uterus				
15.	Mengobservasi kontraksi uterus, perdarahan pervaginam dan tanda vital setiap 10 menit selama 2 jam				
22	Melepas handscoon dan masukkan kedalam larutan klorin 0,5%, merendam dalam posisi terbalik				
23	Membantu pasien mengatur posisi yang nyaman				
C. Terminasi					
1.	Melakukan evaluasi tindakan				14
2.	Berpamitan dengan pasien				
3.	Membereskan dan mengembalikan alat				
4.	Mencuci tangan				
5.	Melaksanakan secara sistematis				
6.	Menggunakan bahasa yang mudah dimengerti				
7.	Mendokumentasikan hasil tindakan				
Total Score					
Nilai Akhir = Jumlah score yang diperoleh: Total Score keseluruhan x 100/total score					
Tanda Tangan Penguji					
Referensi : Adil, A. U. T. G. (2020). Pencegahan dan Tatalaksana Perdarahan Pasca Salin di Pelayanan Kesehatan Primer. <i>Jurnal Kedokteran Nanggroe Medika</i> , 3(2), 34-41.					

E. Daftar Pustaka

- Adil, A. U. T. G. (2020). Pencegahan dan Tatalaksana Perdarahan Pasca Salin di Pelayanan Kesehatan Primer. *Jurnal Kedokteran Nanggroe Medika*, 3(2), 34-41.
- Andreatta, P., Perosky, J., & Johnson, T. R. (2012). Two-Provider Technique for Bimanual Uterine Compression to Control Postpartum Hemorrhage. *Journal of Midwifery & Women's Health*, 57(4), 371-375.
- Evenson, A., & Anderson, J. (2013). Postpartum hemorrhage. *Third Stage Pregnancy. American Academy of Family Physicians*.
- Lalonde, A. (2012). International Federation of Gynecology and obstetrics. *Prevention and treatment of postpartum hemorrhage in low-resource settings. Int J Gynaecol Obstet*, 117(2), 108-118.
- Mousa, H. A., Blum, J., Abou El Senoun, G., Shakur, H., & Alfirevic, Z. (2014). Treatment for primary postpartum haemorrhage. *Cochrane database of systematic reviews*(2).
- Sarim, B. Y. (2020). Manajemen Perioperatif pada Perdarahan akibat Atonia Uteri. *Jurnal Anestesi Obstetri Indonesia*, 3(1), 47-58.

F. Glosarium

A

Arteri Femoralis: Pembuluh darah besar dibagian paha.

Articulatio Coxae: Sendi peluru dari sambungan antara bagian cembung tulang femur dan bagian cekung acetabulum pada pelvis.

Atonia Uteri: Uterus tidak berkontraksi dengan baik setelah 15 detik lahirnya plasenta

APD: Alat Pelindung Diri yang digunakan saat bekerja seperti penutup kepala, masker, kacamata google, celemek dan sepatu boot.

D

Distal: Terletak jauh dari titik awal pusat atau poros struktur tubuh.

Definitif: Sudah pasti.

DTT: Desinfektan Tingkat Tinggi adalah suatu langkah memproses alat habis pakai yang telah digunakan untuk suatu tindakan untuk menghilangkan mikroorganisme.

E

Ergonomis: Cara kerja atau meletakkan Barang atau alat yang digunakan dalam posisi minimal atau terdekat, secara berurutan, sistematis sesuai dengan kebutuhan awal dan mudah dilihat dan dijangkau.

Ekstremitas Inferior: Tubuh anggota gerak bagian bawah.

F

Fleksi: Gerakan mengurangi sudut antara dua tulang.

H

Horizontal: Terletak pada garis atau bidang yang sejajar, garis datar atau mendatar.

I

Infeksi: Kondisi tubuh saat ada mikroorganisme atau virus masuk ke dalam tubuh dan menimbulkan penyakit tertentu.

Intermiten: Terputus-putus atau yang terjadi sebentar-sebentar berulang

Inversio Uteri: Kondisi uterus pada posisi terbalik dengan fundus uteri masuk sebagian atau seluruhnya ke dalam rongga uterus, vagina, bahkan keluar dari vulva.

Informed Consent: Persetujuan tindakan atau prosedur medik yang diberikan oleh pasien atau keluarga kepada petugas kesehatan.

K

KBI: Kompresi Bimanual Internal.

KBE: Kompresi Bimanual Eksternal.

Kompresi: Penekanan.

Kateter Nelaton: Pipa atau selang atau tabung fleksibel yang digunakan untuk drainase urine jangka pendek.

Kontraksi Uterus: Proses pengerutan dan penegangan otot rahim terjadi saat tubuh melepaskan hormon oksitosin yang ditunjukkan dengan tanda perut ibu bersalin dibagian atas rahim mengencang, sehingga bayi terdorong ke bawah untuk masuk ke jalan lahir.

Kolumna Vertebralis: Tulang belakang.

L

Larutan Klorin 0,5%: Suatu larutan yang berfungsi sebagai desinfektan yang terbuat dari campuran 0,095 liter Bayclin 5,25% dan air sampai didapatkan volume 1 liter.

M

Massage Uterus: Tindakan pemijatan ringan dengan arah pijatan memutar searah jarum jam yang dilakukan untuk mempertahankan uterus berkontraksi dengan baik.

N

NaCL: Cairan infus Natrium Chlorida.

O

Overdistensi Uterus: Peningkatan massa secara berlebihan pada uterus.

P

Plasenta: Ari-ari.

Pulsasi Arteri: Kondisi terjadinya luka atau lubang pada organ tubuh.

Preparat Prostaglandin: Senyawa yang berfungsi dalam merangsang kontraksi uterus.

R

RL: Cairan Infus Ringer Lactat

S

Simfisis Pubis: Bagian sendi penghubung dua tulang pubis.

U

Umbilikus: Pesar.

Uterovaginal: Uterus dan vagina.

Uterotonika: Obat yang bermanfaat untuk merangsang kontraksi uterus.

BAB IX

PRAKTIKUM AMNIOTOMI

Putu Ayu Ratna Darmayanti, S.Tr.Keb.,M.Kes



BAB IX

PRAKTIKUM AMNIOTOMI

Putu Ayu Ratna Darmayanti, S.Tr.Keb.,M.Kes

A. Deskripsi

Bab ini mengenalkan pada mahasiswa untuk memberikan asuhan kebidanan pada ibu dalam persalinan dan bayi segera setelah lahir dengan pendekatan manajemen kebidanan didasari konsep - konsep, sikap dan keterampilan serta hasil *evidence based*.

B. Tujuan Pembelajaran

1. Tujuan pembelajaran Umum

Setelah mengikuti penuntun belajar praktik ini, mahasiswa mampu melakukan praktik amniotomi pada ibu bersalin dengan baik dan benar.

2. Tujuan Pembelajaran Khusus

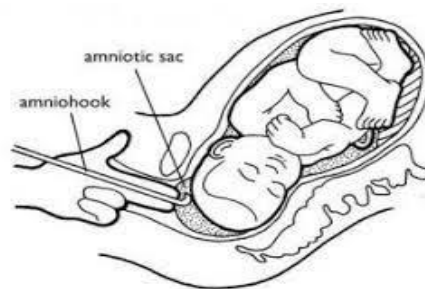
Setelah mempelajari materi ini diharapkan mahasiswa mampu :

- Memahami tentang konsep amniotomi pada ibu bersalin
- Melakukan tindakan amniotomi pada ibu bersalin dengan baik dan benar

C. Uraian Materi

1. Definisi

Amniotomi adalah suatu tindakan untuk memecahkan atau membuka selaput amnion dengan jalan membuat robekan kecil yang kemudian akan dilebarkan secara spontan oleh gaya berat cairan dan adanya tekanan di dalam rongga amnion (Sukmanawati, Hermansyah, & Nurmalasari, 2021).



Gambar 9.1. Amniotomi

2. Tujuan

Tujuan dari amniotomi pada ibu bersalin yaitu untuk mempercepat atau akselerasi persalinan. Sebelum melakukan amniotomi sebaiknya dilakukan penilaian serviks, penurunan bagian terbawah dan luas panggul, untuk

menentukan keberhasilan proses akselerasi persalinan (Sukmanawati et al., 2021).

3. Indikasi

Indikasi amniotomi yaitu dilakukan pada ibu bersalin dengan hasil pemantauan internal frekuensi denyut jantung janin terdapat indikasi gangguan pada janin, induksi persalinan, kontraksi uterus lemah, persalinan dengan tindakan atau instrumen dan dilakukan jika ketuban belum juga pecah saat serviks telah membuka sepenuhnya dan pembukaan lengkap (Kurniawati, 2017).

4. Kontra Indikasi

Kontra indikasi amniotomi pada ibu bersalin yaitu masih pada fase laten, bagian terendah janin masih tinggi, pembukaan servik belum lengkap, persalinan preterm, vasa previa, polihidramnion, plasenta previa, presentasi muka, adanya infeksi vagina, letak lintang (Kurniawati, 2017).

5. Hal-hal yang diperhatikan

Menurut Lusa and Rista (2021), hal-hal yang diperhatikan saat melakukan amniotomi adalah kondisi ibu pada saat pembukaan 10 cm atau lengkap dan dilakukan saat kontraksi uterus atau HIS melemah.

6. Persiapan Alat

Menurut Fatimah (2022), Alat dan bahan yang diperlukan selama melakukan amniotomi, yaitu sebagai berikut:

- a. Phantom panggul lengkap dengan bayi
- b. Selimut 1 buah
- c. Perlak dan alas nya
- d. Korentang 1 buah
- e. APD (Kaca mata, sepatu tertutup, tutup kepala, masker, skort)
- f. Fetoskop/Doppler
- g. Handuk kecil 1 buah
- h. Bak instrumen berisi : handschoen pendek 1 pasang, ½ koher
- i. Kom berisi kapas DTT
- j. Bengkok 1 buah
- k. Larutan klorin
- l. Lembar dokumentasi, pulpen

7. Prosedur Tindakan dan Rating scale Tindakan

Menurut Fatimah (2022), prosedur amniotomi, yaitu sebagai berikut:

- a. Menjelaskan maksud, tujuan dan *informed consent*
- b. Memasang sampiran
- c. Mencuci tangan dengan 6 langkah menggunakan sabun dan keringkan dengan handuk bersih
- d. Dekatkan bengkok pada vulva

- e. Memakai sarung tangan dengan prinsip steril/DTT
- f. Memastikan kepala sudah masuk, tidak teraba bagian kecil janin atau tali pusat
- g. Melindungi kepala bayi pada PAP dengan satu tangan
- h. Memasukkan ½ koher diantara jari telunjuk dan jari tengah dengan gigi ½ koher menghadap diantara kedua jari tersebut hingga menyentuh selaput ketuban
- i. Saat selaput ketuban menegang (kontraksi), gerakan kedua ujung jari tangan dalam untuk menorehkan gigi ½ koher hingga merobekkan selaput amnion
- j. Tekankan ujung jari pada tempat robekan sehingga cairan amnion keluar perlahan- lahan (perhatikan warna, kejernihan, pewarnaan mekoneum, jumlah dan ferniks kaseosa pada cairan amion
- k. Setelah cairan mengalir perlahan, keluarkan ½ koher dari vagina, dan masukkan ke dalam ember berisi larutan klorin 0,5 %
- l. Pertahankan kedua jari tangan kanan dalam vagina sehingga yakin bahwa terjadi penurunan kepala serta pastikan tidak teraba bagian kecil janin atau tali pusat yang menumbung
- m. Keluarkan jari tangan dari dalam vagina
- n. Celupkan tangan dalam larutan clorin 0,5 % lalu lepaskan secara terbalik
- o. Monitor denyut jantung janin setelah ketuban pecah
- p. Bereskan alat- alat
- q. Mencuci tangan dengan 6 langkah menggunakan sabun dan keringkan dengan handuk bersih
- r. Dokumentasikan prosedur dan hasil observasi.

D. Rating Scale Belajar Keterampilan

AMNIOTOMI

Nilailah setiap langkah/kinerja yang diamati dengan menggunakan skala sbb:

- 0** = Bila Langkah atau tugas tidak dikerjakan
- 1** = Langkah dilakukan tetapi tidak sempurna
- 2** = Langkah dilakukan dengan sempurna

No	Komponen	Nilai			
		0	1	2	Score
A. Sikap					
1.	Menyapa klien dengan ramah dan sopan				10
2.	Memperkenalkan diri kepada klien				
3.	Teruji menjaga privacy klien				
4.	Percaya diri				
5.	Teruji menjelaskan maksud, tujuan dan <i>informed consent</i>				
B. Isi					
1.	Memasang sampiran				34
2.	Mencuci tangan dengan 6 langkah menggunakan sabun dan keringkan dengan handuk bersih				
3.	Dekatkan bengkok pada vulva				
4.	Memakai sarung tangan dengan prinsip steril/DTT				
5.	Memastikan kepala sudah masuk, tidak teraba bagian kecil janin atau tali pusat				
6.	Melindungi kepala bayi pada PAP dengan satu tangan				
7.	Memasukkan ½ koher diantara jari telunjuk dan jari tengah dengan gigi ½ koher menghadap diantara kedua jari tersebut hingga menyentuh selaput ketuban				
8.	Saat selaput ketuban menegang (kontraksi), gerakkan kedua ujung jari tangan dalam untuk menorehkan gigi ½ koher hingga merobekkan selaput amnion				
9.	Tekankan ujung jari pada tempat robekan sehingga cairan amnion keluar perlahan-lahan (perhatikan warna, kejernihan, pewarnaan mekoneum, jumlah dan ferniks kaseosa pada cairan amion				
10.	Setelah cairan mengalir perlahan, keluarkan ½ koher dari vagina, dan masukkan ke dalam ember berisi larutan klorin 0,5%				
11.	Pertahankan kedua jari tangan kanan dalam vagina sehingga yakin bahwa terjadi penurunan kepala serta pastikan tidak teraba bagian kecil janin atau tali pusat yang menumbung				
12.	Keluarkan jari tangan dari dalam vagina				
13.	Celupkan tangan dalam larutan clorin 0,5 % lalu lepaskan secara terbalik				

14.	Monitor denyut jantung janin setelah ketuban pecah dengan fetoskop atau doppler				
15.	Bereskan alat- alat				
16.	Mencuci tangan dengan 6 langkah menggunakan sabun dan keringkan dengan handuk bersih				
17.	Dokumentasikan prosedur dan hasil observasi.				
C. Terminasi					
1.	Melakukan evaluasi tindakan				14
2.	Berpamitan dengan pasien				
3.	Membereskan dan mengembalikan alat				
4.	Mencuci tangan				
5.	Melaksanakan secara sistematis				
6.	Menggunakan bahasa yang mudah dimengerti				
7.	Mendokumentasikan hasil tindakan				
Total Score					
Nilai Akhir = Jumlah score yang diperoleh: Total Score keseluruhan x 100/total score					
Tanda Tangan Penguji					
Referensi : Fatimah, F. (2022). <i>Modul Praktikum Asuhan Kebidanan Persalinan dan BBL</i> Yogyakarta: Universitas Alma Ata Yogyakarta.					

E. Daftar Pustaka

- Fatimah, F. (2022). *Modul Praktikum Asuhan Kebidanan Persalinan dan BBL*. Yogyakarta: Universitas Alma Ata Yogyakarta.
- Kurniawati, D. (2017). Manajemen intervensi fase laten ke fase aktif pada kemajuan persalinan. *Nurscope: Jurnal Keperawatan dan Pemikiran Ilmiah*, 3(4), 27-34.
- Lusa, R., & Rista, N. (2021). Modul Praktikum Asuhan Kebidanan Persalinan dan Bayi Baru Lahir. In: Zahir Publishing.
- Sukmanawati, D., Hermansyah, H., & Nurmalasari, N. (2021). Profil Lama Persalinan Kala II Berdasarkan Tindakan Amniotomi Di RSUD 45 Kuningan. *Jurnal Ilmu Kesehatan Bhakti Husada: Health Sciences Journal*, 12(1), 71-79.

F. Glosarium

A

APD: Alat Pelindung Diri yang digunakan saat bekerja seperti penutup kepala, masker, kacamata google, celemek dan sepatu boat

Amnion: Ketuban.

Akselerasi Persalinan: Tindakan terhadap ibu hamil inpartu untuk meningkatkan frekuensi, lama, dan kekuatan kontraksi uterus dalam persalinan.

D

Doppler: Alat medis yang digunakan untuk mengukur frekuensi denyut jantung janin.

F

Fase Laten: Tahap persalinan memasuki kondisi dari mulainya kontraksi uterus sampai dengan pembukaan servik menunjukkan pembukaan 1-3 cm.

Fase Aktif: Tahap persalinan memasuki kondisi dari pembukaan dari 3 cm sampai lengkap atau 10 cm, berlangsung sekitar enam jam.

Fetoskop: Alat medis yang digunakan untuk mengukur frekuensi denyut jantung janin

H

HIS: Kekuatan nyeri fisiologis yang utama selama kala II. His yang terjadi pada responden bersifat normal, yaitu kontraksi uterus terjadi 3 – 4 kali dalam 10 menit selama 40 – 60 menit dengan interval 2 – 3 menit.

I

Infeksi: Kondisi tubuh saat ada mikroorganisme atau virus masuk ke dalam tubuh dan menimbulkan penyakit tertentu.

Induksi Persalinan: Suatu tindakan yang dilakukan untuk merangsang kontraksi rahim guna mempercepat proses persalinan.

Informed Consent: Persetujuan tindakan atau prosedur medik yang diberikan oleh pasien atau keluarga kepada petugas kesehatan.

K

Kontraksi Rahim: Proses pengerutan dan penegangan otot rahim terjadi saat tubuh melepaskan hormon oksitosin yang ditunjukkan dengan tanda perut ibu bersalin dibagian atas rahim mengencang, sehingga bayi terdorong ke bawah untuk masuk ke jalan lahir.

P

Polihidramnion: Kondisi ibu hamil mengalami penumpukkan cairan ketuban dengan volume air ketuban banyak.

Plasenta Previa: Kondisi ketika ari-ari atau plasenta berada di bagian bawah rahim sehingga menutupi sebagian atau seluruh jalan lahir.

Preterm: Proses persalinan yang terjadi pada usia kehamilan 20-36 minggu.

S

Serviks: Bagian dari rahim yang menonjol kedalam vagina pada kondisi normal berwarna pink dan permukaannya licin.

BAB X

PRAKTIKUM EPISIOTOMI

Putu Ayu Ratna Darmayanti, S.Tr.Keb.,M.Kes



BAB X

PRAKTIKUM EPISIOTOMI

Putu Ayu Ratna Darmayanti, S.Tr.Keb.,M.Kes

A. Pendahuluan

BAB ini mengenalkan pada mahasiswa untuk memberikan asuhan kebidanan pada ibu dalam persalinan dan bayi segera setelah lahir dengan pendekatan manajemen kebidanan didasari konsep - konsep, sikap dan keterampilan serta hasil *evidence based*. Tujuan pembelajaran umum yaitu setelah mengikuti penuntun belajar praktik ini, mahasiswa mampu melakukan praktik episiotomi pada ibu bersalin dengan baik dan benar. Sedangkan, tujuan pembelajaran khusus yaitu setelah mempelajari materi ini diharapkan mahasiswa mampu memahami tentang konsep episiotomi pada ibu bersalin dan mahasiswa mampu melakukan tindakan episiotomi pada ibu bersalin dengan baik dan benar.

B. Tujuan Pembelajaran

1. Tujuan Pembelajaran Umum

Setelah mengikuti penuntun belajar praktik ini, mahasiswa mampu melakukan praktik episiotomi pada ibu bersalin dengan baik dan benar.

2. Tujuan Pembelajaran Khusus

Setelah mempelajari materi ini diharapkan mahasiswa mampu:

- a. Memahami tentang konsep episiotomi pada ibu bersalin
- b. Melakukan tindakan episiotomi pada ibu bersalin dengan baik dan benar

C. Uraian Materi

1. Definisi

Episiotomi adalah suatu tindakan penyayatan atau insisi bagian perineum yang dimulai dari cincin vulva ke bawah, menghindari anus dan muskulus spingter dimana insisi menyebabkan terpotongnya selaput lendir vagina, cincin selaput dara, jaringan pada septum rektovaginal, otot-otot dan fascia perineum dan kulit sebelah depan perineum untuk melebarkan orifisium vulva sehingga mempermudah jalan keluar bayi (Lusa & Rista, 2021).

Menurut Wahyuningsih (2019), terdapat dua jenis episiotomi yang di gunakan yaitu episiotomi pada garis tengah dan episiotomi mediolateral, yaitu seperti dibawah ini.

a. Episiotomi Garis tengah (Midline Episiotomi)

Sayatan yang di buat di garis tengah, dimana Insisi atau sayatan dimulai dari ujung terbawah introitus vagina atau pada garis tengah komissura

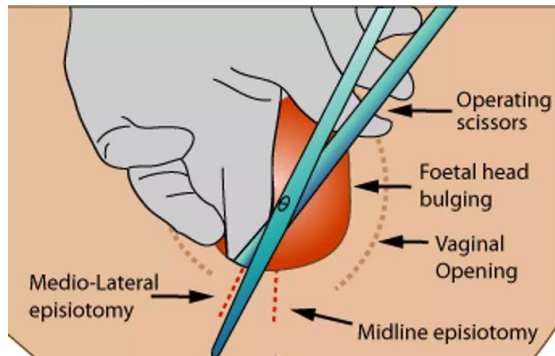
posterior sampai batas atas otot-otot sfingter ani (tidak sampai mengenai serabut sfingter ani).

- 1) Keuntungannya yaitu perdarahan yang timbul dari luka episiotomi lebih sedikit oleh karena daerah yang relatif sedikit mengandung pembuluh darah, sayatan bersifat simetris dan anatomis sehingga penjahitan kembali lebih mudah dan penyembuhan lebih memuaskan, tidak akan mempengaruhi keseimbangan otot di kanan kiri dasar pelvis, insisi akan lebih mudah sembuh, karena bekas insisi tersebut mudah dirapatkan, tidak begitu sakit pada masa nifas yaitu masa setelah melahirkan, dispareuni jarang terjadi
- 2) Kerugiannya adalah terjadi perluasan laserasi ke sfingter ani (laserasi median sfingter ani) sehingga terjadi laserasi perineal tingkat III inkomplet atau laserasi menjangkau hingga rektum (laserasi dinding rektum), sehingga terjadi ruptur perineal komplis yang mengakibatkan kehilangan darah lebih banyak dan lebih sulit dijahit.

b. Episiotomi Medio Lateral

Sayatan yang di buat dari garis tengah kesamping menjauhi anus yang sengaja dilakukan menjauhi otot sfingter ani untuk mencegah ruptura perineal tingkat III, dimana insisi dimulai dari ujung terbawah introitus vagina menuju ke belakang dan samping kiri atau kanan ditengah antara spina ischiadica dan anus. Dilakukan pada ibu yang memiliki perineum pendek, pernah ruptur grade 3, dengan panjang sayatan kira-kira 4 cm dan insisi dibuat pada sudut 45° terhadap forset posterior pada satu sisi kanan atau kiri tergantung pada kebiasaan orang yang melakukannya.

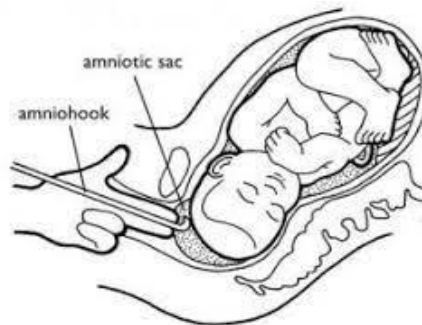
- 1) Keuntungannya yaitu perluasan laserasi akan lebih kecil kemungkinannya mencapai otot sfingter ani dan rektum sehingga dapat mencegah terjadinya laserasi perineal tingkat III ataupun laserasi perineum yang lebih parah yang sampai pada rectum.
- 2) Kerugiannya yaitu perdarahan luka lebih banyak oleh karena melibatkan daerah yang banyak pembuluh darahnya, Otot-otot perineum terpotong sehingga penjahitan luka lebih sukar dan penyembuhan terasa lebih sakit dan lama, insisi lateral akan menyebabkan distorsi keseimbangan dasar pelvis, otot agak lebih sulit untuk disatukan secara benar (aposisinya sulit), sehingga terbentuk jaringan parut yang kurang baik, rasa nyeri pada sepertiga kasus selama beberapa hari dan terkadang diikuti dispareuni (Intiyaswati, 2020).



Gambar 10.1. Jenis Episiotomi

2. Tujuan

Tujuan dari episiotomi pada ibu bersalin yaitu untuk mencegah robekan spontan, mencegah ruptur perinii totalis, membentuk insisi atau sayatan bedah yang lurus, sebagai pengganti robekan tak teratur yang mungkin terjadi selama persalinan, mempersingkat waktu ibu dalam mendorong bayinya, mempersingkat waktu persalinan dengan melebarkan jalan lahir, mengurangi tekanan kepala anak sehingga dapat mencegah trauma kepala pada janin akibat jalan lahir yang sempit dan mencegah kerusakan pada spintcher ani akibat desakan kepala bayi (Wahyuningsih, 2019).



Gambar 10.2. Episiotomi

3. Indikasi

Menurut Muharyani (2016), indikasi episiotomi yaitu jika perineum telah menipis dan kepala janin tidak masuk ke dalam vagina. Selain itu, tindakan episiotomi dapat dilakukan, atas indikasi, yaitu sebagai berikut:

- Pada persalinan dengan alat atau tindakan seperti vakum ekstraksi dan forcep
- Pada persalinan janin besar
- Pada perineum yang akan robek dengan sendiri (menipis dan pucat)
- Pada persalinan prematur
- Pada perineum kaku
- Jika terjadi gawat janin

- g. Pada kasus kelainan letak atau presentasi abnormal (bokong, muka, ubun-ubun kecil di belakang)
- h. Adanya jaringan parut pada perineum atau vagina.

4. Kontra Indikasi

Kontra indikasi episiotomi pada ibu bersalin yaitu jika persalinan tidak berlangsung secara pervaginam dan jika terdapat kondisi yang memicu terjadinya perdarahan yang banyak seperti penyakit kelainan darah maupun terdapatnya varises yang luas pada vulva dan vagina (Prahayu, 2017).

5. Hal-hal yang diperhatikan

Menurut Lusa and Rista (2021), hal-hal yang diperhatikan saat melakukan episiotomi adalah kondisi ibu pada saat pembukaan 10 cm atau lengkap dengan bagian terendah janin telah berada di depan vulva.

6. Persiapan Alat

Menurut Fatimah (2022), Alat dan bahan yang diperlukan selama melakukan episiotomi, yaitu sebagai berikut:

- a. Phantom panggul lengkap dengan bayi
- b. Perlak dan alas nya
- c. Korentang 1 buah
- d. APD (Kaca mata, sepatu tertutup, tutup kepala, masker, skort)
- e. Gunting episiotomy
- f. Larutan antiseptic dalam kom kecil
- g. Kassa steril
- h. Fetoskop/Doppler
- i. S spuit 10 cc
- j. Bak instrumen berisi : Sarung tangan steril 1 pasang, ½ koher
- k. Kom berisi kapas DTT
- l. Lidocain Inj 1%
- m. Larutan klorin

7. Prosedur Tindakan dan Rating scale Tindakan

Menurut Fatimah (2022), prosedur episiotomi, yaitu sebagai berikut:

- a. Menjelaskan maksud, tujuan dan *informed consent*
- b. Memasang sampiran
- c. Mencuci tangan dengan 6 langkah menggunakan sabun dan keringkan dengan handuk bersih
- d. Ambil 10 ml larutan lidokain 1% tanpa epinefrin ke dalam spuit 10 ml dan pastikan bahwa spuit memiliki jarum ukuran 22 dan panjang 4 cm
- e. Letakkan dua jari ke dalam vagina diantara kepala bayi
- f. Masukkan jarum di tengah fourchette dan arahkan jarum sepanjang tempat yang akan di episiotomi

- g. Aspirasi untuk memastikan bahwa jarum tidak berada di dalam pembuluh darah
- h. Tarik jarum perlahan-lahan sambil menyuntikkan maksimum 10 ml lidokain
Keluarkan jari tangan dari dalam vagina
- i. Tarik jarum bila sudah kembali ke titik asal jarum suntik ditusukkan kulit melambung karena anastesi bias terlihat dan dipalpasi pada perineum disepanjang garis yang akan dilakukan episiotomi
- j. Tunda tindakan episiotomi sampai perineum menipis, pucat, dan 3-4 cm kepala bayi sudah terlihat pada saat kontraksi
- k. Masukkan dua jari ke dalam vagina diantara kepala bayi dan perinium. Kedua jari agak ditegangkan dan berikan sedikit tekanan lembut ke arah luar pada perineum
- l. Gunakan gunting epis tajam DTT steril, tempatkan gunting di tengah-tengah fourchette posterior dan gunting mengarah ke sudut yang diinginkan untuk melakukan episiotomi mediolateral.
- m. Pastikan untuk melakukan palpasi atau mengidentifikasi sfingter ani ekstern dan mengarahkan gunting cukup jauh ke arah samping untuk menghindari stingter
- n. Gunting perineum sekitar 3-4 cm dengan arah mediolateral dengan Gerakan yang mantap
- o. Gunakan gunting untuk memotong sekitar 2-3 cm ke dalam vagina
- p. Rendam gunting epis kedalam larutan klorin 0,5%
- q. Jika kepala bayi belum lahir lakukan tekanan pada luka episiotomi dengan dilapisi kasa steril diantara kontraksi untuk membantu mengurangi perdarahan
- r. Celupkan tangan dalam larutan klorin 0,5% lalu lepaskan secara terbalik
- s. Monitor denyut jantung janin setelah episiotomi
- t. Setelah bayi dan plasenta lahir, periksa dengan hati-hati apakah episiotomi, perineum dan vagina mengalami perluasan atau laserasi, lakukan penjahitan jika terjadi perluasan episiotomi atau laserasi tambahan
- u. Bereskan alat-alat
- v. Mencuci tangan dengan 6 langkah menggunakan sabun dan keringkan dengan handuk bersih
- w. Dokumentasikan prosedur dan hasil observasi.

D. Rating Scale Belajar Keterampilan

EPISIOTOMI

Nilailah setiap langkah/kinerja yang diamati dengan menggunakan skala sbb:

- 0 = Bila Langkah atau tugas tidak dikerjakan
- 1 = Langkah dilakukan tetapi tidak sempurna
- 2 = Langkah dilakukan dengan sempurna

No	Komponen	Nilai			
		0	1	2	Score
A. Sikap					
1.	Menyapa klien dengan ramah dan sopan				10
2.	Memperkenalkan diri kepada klien				
3.	Teruji menjaga privacy klien				
4.	Percaya diri				
5.	Teruji menjelaskan maksud, tujuan dan <i>informed consent</i>				
B. Isi					46
1.	Memasang sampiran				
2.	Mencuci tangan dengan 6 langkah menggunakan sabun dan keringkan dengan handuk bersih				
3.	Ambil 10 ml larutan lidokain 1% tanpa epinefrin ke dalam spuit 10 ml dan pastikan bahwa spuit memiliki jarum ukuran 22 dan panjang 4 cm				
4.	Letakkan dua jari ke dalam vagina diantara kepala bayi				
5.	Masukkan jarum di tengah fourchette dan arahkan jarum sepanjang tempat yang akan di episiotomi				
6.	Aspirasi untuk memastikan bahwa jarum tidak berada di dalam pembuluh darah				
7.	Tarik jarum perlahan-lahan sambil menyuntikkan maksimum 10 ml lidokain Keluarkan jari tangan dari dalam vagina				
8.	Tarik jarum bila sudah kembali ke titik asal jarum suntik ditusukkan kulit melambung karena anastesi bias terlihat dan dipalpasi pada perineum disepanjang garis yang akan dilakukan episiotomi				

9.	Tunda tindakan episiotomi sampai perineum menipis, pucat, dan 3-4 cm kepala bayi sudah terlihat pada saat kontraksi				
10.	Masukkan dua jari ke dalam vagina diantara kepala bayi dan perinium. Kedua jari agak ditegangkan dan berikan sedikit tekanan lembut ke arah luar pada perineum				
11.	Gunakan gunting epis tajam DTT steril, tempatkan gunting di tengah-tengah fourchette posterior dan gunting mengarah ke sudut yang diinginkan untuk melakukan episiotomi mediolateral				
12.	Pastikan untuk melakukan palpasi atau mengidentifikasi sfingter ani ekstern dan mengarahkan gunting cukup jauh ke arah samping untuk menghindari sfingter				
13.	Gunting perineum sekitar 3-4 cm dengan arah mediolateral dengan Gerakan yang mantap				
14.	Gunakan gunting untuk memotong sekitar 2-3 cm ke dalam vagina				
15.	Rendam gunting epis kedalam larutan klorin 0,5%				
16.	Jika kepala bayi belum lahir lakukan tekanan pada luka episiotomi dengan dilapisi kasa steril diantara kontraksi untuk membantu mengurangi perdarahan				
17.	Celupkan tangan dalam larutan klorin 0,5% lalu lepaskan secara terbalik				
18.	Monitor denyut jantung janin setelah episiotomi dengan fetoskop atau doppler				
19.	Celupkan tangan dalam larutan klorin 0,5 % lalu lepaskan secara terbalik				
20.	Setelah bayi dan plasenta lahir, periksa dengan hati-hati apakah episiotomi, perineum dan vagina mengalami perluasan atau laserasi, lakukan penjahitan jika terjadi perluasan episiotomi atau laserasi tambahan				
21.	Bereskan alat- alat				
22.	Mencuci tangan dengan 6 langkah menggunakan sabun dan keringkan dengan handuk bersih				

23.	Dokumentasikan prosedur dan hasil observasi.				
C. Terminasi					
1.	Melakukan evaluasi tindakan				14
2.	Berpamitan dengan pasien				
3.	Membereskan dan mengembalikan alat				
4.	Mencuci tangan				
5.	Melaksanakan secara sistematis				
6.	Menggunakan bahasa yang mudah dimengerti				
7.	Mendokumentasikan hasil tindakan				
Total Score					
Nilai Akhir = Jumlah score yang diperoleh: Total Score keseluruhan x 100/total score					
Tanda Tangan Penguji					
Referensi : Fatimah, F. (2022). <i>Modul Praktikum Asuhan Kebidanan Persalinan dan BBL</i> Yogyakarta: Universitas Alma Ata Yogyakarta.					

E. Daftar Pustaka

- Fatimah, F. (2022). *Modul Praktikum Asuhan Kebidanan Persalinan dan BBL* Yogyakarta: Universitas Alma Ata Yogyakarta.
- Intiyaswati, I. (2020). Faktor–Faktor Yang Mempengaruhi Penyembuhan Luka Episiotomi Pada Ibu Post Partum Di Pmb Istiqomah Surabaya. *Jurnal Kebidanan*, 9(1), 17-25.
- Lusa, R., & Rista, N. (2021). Modul Praktikum Asuhan Kebidanan Persalinan dan Bayi Baru Lahir. In: Zahir Publishing.
- Muharyani, P. W. (2016). Pengaruh Terapi Ice Pack Terhadap Perubahan Skala Nyeri Pada Ibu Post Episiotomi. *Jurnal Kedokteran dan Kesehatan: Publikasi Ilmiah Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya*, 3(1), 377-382.
- Prahayu, T. (2017). *Manajemen Asuhan Kebidanan Ibu Nifas pada Ny “M” dengan Luka Episiotomi di RSUD Syech Yusuf Gowa Tahun 2017*. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar,
- Wahyuningsih, S. (2019). *Buku Ajar Asuhan Keperawatan Post Partum Dilengkapi Dengan Panduan Persiapan Praktikum Mahasiswa Keperawatan*: Deepublish.

F. Glosarium

A

Anus: Lubang akhir dari sistem pencernaan sebagai tempat keluarnya feses.

APD: Alat Pelindung Diri yang digunakan saat bekerja seperti penutup kepala, masker, kacamata google, celemek dan sepatu boot.

D

Distorsi: Penyimpangan.

Dispareuni: Nyeri saat berhubungan.

Doppler: Alat medis yang digunakan untuk mengukur frekuensi denyut jantung janin.

F

Fetoskop: Alat medis yang digunakan untuk mengukur frekuensi denyut jantung janin

I

Insisi: Metode penyayatan kulit yang dilakukan untuk mengencangkan kulit wajah atau menciptakan lipatan untuk penampilan estetika.

Informed Consent: Persetujuan tindakan atau prosedur medik yang diberikan oleh pasien atau keluarga kepada petugas kesehatan.

K

Kontraksi Rahim: Proses pengerutan dan penegangan otot rahim terjadi saat tubuh melepaskan hormon oksitosin yang ditunjukkan dengan tanda perut ibu bersalin dibagian atas rahim mengencang, sehingga bayi terdorong ke bawah untuk masuk ke jalan lahir.

L

Laserasi: Luka terbuka yang umumnya disebabkan oleh benda tumpul, daripada benda tajam, yang menyebabkan robeknya jaringan atau disintegritas jaringan.

O

Orifisium: Lubang atau muara.

P

Palpasi: Metode pemeriksaan fisik yang dilakukan dengan melakukan perabaan pada permukaan tubuh dengan tangan dan jari.

Plasenta: Ari-ari.

Prematur: Kelahiran yang terjadi sebelum minggu ke-37 atau lebih awal dari hari perkiraan lahir.

R

Ruptur Perineii: Robekan perineum yang terjadi pada saat bayi lahir baik secara spontan maupun dengan menggunakan alat atau tindakan.

BAB XI

PRAKTIKUM PERTOLONGAN

PERSALINAN SUNGSANG METODE BRACHT

Amanda Via Maulinda, S.Tr.Keb., M.K.M



**Nuansa
Fajar
Cemerlang**

BAB XI

**PRAKTIKUM PERTOLONGAN PERSALINAN SUNGSANG
METODE BRACHT**

Amanda Via Maulinda, S.Tr.Keb., M.K.M

A. Deskripsi

Keberhasilan program kesehatan ibu dan anak dinilai dari jumlah angka kematian ibu bersalin dan angka kematian perinatal. Sebagian besar, kematian perinatal letak sungsang lebih tinggi dibandingkan letak kepala. Kehamilan dengan presentasi bokong adalah kehamilan yang memiliki resiko. Hal ini dikaitkan dengan abnormalitas janin dan ibu (Putra *et al.*, 2016). Angka kematian perinatal dengan persalinan presentasi sungsang mempunyai presentase 16,8 - 38,5% di Indonesia (Dinda *et al.*, 2021). Menurut penelitian Silinaung *et al* (2016), persalinan letak sungsang berdasarkan jenis persalinan, terbanyak pada metode bracht sebanyak 101 kasus (47,19%), Pertolongan persalinan sungsang metode bracht merupakan upaya pemerintah dalam menurunkan risiko morbiditas dan mortalitas ibu dan bayi.

Pada bab ini mahasiswa mempelajari tentang konsep dan prosedur tindakan pertolongan persalinan sungsang metode Bracht yang didasari pada pambaharuan kelimuan.

B. Tujuan Pembelajaran

1. Tujuan Pembelajaran Umum

Setelah mempelajari praktikum ini mahasiswa mampu mempraktikkan pertolongan persalinan sungsang dengan metode bracht.

2. Tujuan Pembelajaran Khusus

Setelah mempelajari materi ini diharapkan:

- a. Mahasiswa mampu memahami tentang pertolongan persalinan sungsang metode bracht.
- b. Mahasiswa mampu mempraktikkan pertolongan persalinan metode bracht.

C. Uraian Materi

1. Definisi

Metode bracht merupakan teknik pertolongan sungsang pervaginam dengan presentasi bokong sempurna, dimana janin dilahirkan dengan kekuatan dan tenaga ibu sendiri. Metode bracht merupakan cara yang paling mendekati persalinan fisiologik, sehingga mengurangi trauma pada janin (Rosdianah *et al.*, 2019).

2. Tujuan

- a. Untuk membantu kelahiran bayi

- b. Memimpin ibu untuk mengejan dengan benar
- c. Menjaga keselamatan ibu dan bayi
- d. Mengurangi terjadinya komplikasi persalinan (Setyarini *et al.*, 2016).

3. Indikasi

Indikasi dilakukan pertolongan persalinan sungsang adalah presentasi bokong janin sempurna (*complete breech*) (Setyarini dan Suprapti, 2016)

4. Kontrak Indikasi

Kontra indikasi dilakukan pertolongan asuhan persalinan sungsang metode bracht sebagai berikut:

Persalinan secara Bracht mengalami kegagalan terutama dalam keadaan panggul sempit, janin besar, jalan lahir kaku misalnya pada primigravida, adanya lengan menjungkit atau menunjuk, terjadi kemacetan baik pada waktu melahirkan bahu atau kepala (Setyarini dan Suprapti, 2016).

5. Hal-hal yang diperhatikan

Hal – hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan pertolongan persalinan metode bracht adalah sebagai berikut:

- a. Menyiapkan inform consent
- b. Menyiapkan inform choice
- c. Menjaga privasi pasien
- d. Menjaga Kesterilan alat
- e. Tindakan dilakukan sesuai dengan tahapan prosedur

6. Persiapan Alat

Menurut Arfiana *et al* (2020) dalam buku kewaspadaan kegawatdaruratan maternal neonatal, persiapan alat dan bahan yang dibutuhkan untuk melakukan pertolongan persalinan normal adalah sebagai berikut:

- a. Alat Pelindung diri (Celemek, penutup kepala, kacamata, masker, alas kaki)
- b. Klorin 0,5%
- c. Sarung tangan steril
- d. 1 handuk
- e. 1 selimut bayi
- f. 1 topi bayi

7. Prosedur Tindakan dan Rating scale Tindakan

Prosedur tindakan dan rating scale pertolongan persalinan sungsang metode bracht sebagai berikut:

Teknik pertolongan persalinan Bracht

- a. Menggunakan APD (celemek, topi, masker, alas kaki, sarung tangan)
- b. Memastikan kelengkapan alat dan meletakkan secara ergonomis.
- c. Memberikan informed consent
- d. Mencuci tangan dan memakai sarung tangan

- e. Memberitahu ibu pembukaan sudah lengkap dan membantu ibu posisi litotomi serta memimpin meneran bila ada his
- f. Segera setelah bokong lahir, bokong dicekam dengan kedua ibu jari penolong sejajar dengan paha, jari-jari yang lain memegang daerah panggul
- g. Paha dicekam, bokong jangan ditarik, tidak melakukan intervensi dan ikuti proses keluarnya janin sesuai kurve jalan lahir
- h. Longgarkan tali pusat setelah lahirnya perut dan sebagian dada (setelah selesai memposisikan kembali kedua tangan penolong mencengkam bokong janin)

Hiperlordosis badan bayi

- a. Lakukan hiperlordosis janin pada saat angulus scapula inferior tampak dibawah simfisis (dengan mengikuti gerak rotasi anterior yaitu punggung janin di dekatkan ke arah perut ibu tanpa tarikan) di sesuaikan dengan lahirnya badan janin
- b. Gerakkan ke atas hingga lahir dagu, mulut, hidung, dahi dan kepala bayi lahir

Meletakkan bayi di atas perut ibu

- a. Letakkan bayi di atas perut ibu dengan kepala lebih rendah dari tubuh
- b. Keringkan bayi dan bungkus dengan handuk bersih serta gunakan topi bayi
- c. Melakukan IMD
- d. Membereskan alat dan merendamnya dalam larutan klorin 0,5 %
- e. Mencuci tangan dalam larutan klorin 0.5% dan melepas sarung tangan secara terbalik
- f. Memberitahukan ibu hasil tindakan

D. Rating Scale Belajar Keterampilan

ASUHAN PERSALINAN BRACHT

Nilailah setiap langkah/kinerja yang diamati dengan menggunakan skala sbb:

- 0** = Bila Langkah atau tugas tidak dikerjakan
- 1** = Langkah dilakukan tetapi tidak sempurna
- 2** = Langkah dilakukan dengan sempurna

No	Komponen	Nilai			
		0	1	2	Score
A. Sikap					
1.	Menyambut dengan sopan dan ramah serta memposisikan klien				14
2.	Menjelaskan tujuan tindakan dan meminta persetujuan				
3.	Teruji menjaga privacy klien				
4.	Merespon terhadap reaksi klien				
5.	Percaya diri				
6.	Teruji memberikan rasa empati pada klien				
7.	Teruji menjelaskan prosedur yang akan dilakukan				
B. Isi					
1.	Menggunakan APD (celemek, topi, masker, alas kaki, sarung tangan)				28
2.	Memastikan kelengkapan alat dan meletakkan secara ergonomis.				
3.	Memberikan informed consent				
4.	Mencuci tangan dan memakai sarung tangan				
5.	Memberitahu ibu pembukaan sudah lengkap dan membantu ibu posisi litotomi serta memimpin meneran bila ada his				
6.	Segera setelah bokong lahir, bokong dicekam dengan kedua ibu jari penolong sejajar dengan paha, jari-jari yang lain memegang daerah panggul				
7.	Paha dicekam, bokong jangan ditarik, tidak melakukan intervensi dan ikuti proses keluarnya janin sesuai kurve jalan lahir				
8.	Longgarkan tali pusat setelah lahirnya perut dan sebagian dada (setelah selesai memposisikan kembali kedua tangan penolong mencengkam bokong janin)				
	Hiperlordosis badan bayi				
9.	Lakukan hiperlordosis janin pada saat angulus scapula inferior tampak dibawah simfisis (dengan mengikuti gerak rotasi anterior yaitu punggung janin di dekatkan ke arah perut ibu tanpa tarikan) di sesuaikan dengan lahirnya badan janin				
10.	Gerakkan ke atas hingga lahir dagu, mulut, hidung, dahi dan kepala bayi lahir				
	Meletakkan bayi di atas perut ibu				
11.	a. Letakkan bayi di atas perut ibu dengan kepala lebih rendah dari tubuh b. Keringkan bayi dan bungkus dengan handuk bersih serta gunakan topi bayi c. Melakukan IMD				
12.	Membereskan alat dan merendamnya dalam larutan klorin 0,5 %				
13.	Mencuci tangan dalam larutan klorin 0.5% dan melepas sarung tangan secara terbalik				

14.	Memberitahukan ibu hasil tindakan				
C. Terminasi					
1.	Melakukan evaluasi tindakan				14
2.	Berpamitan dengan pasien				
3.	Membereskan dan mengembalikan alat				
4.	Mencuci tangan				
5.	Melaksanakan secara sistematis				
6.	Menggunakan bahasa yang mudah dimengerti				
7.	Mendokumentasikan hasil tindakan				
Total Score					
Nilai Akhir = Jumlah score yang diperoleh: Total Score keseluruhan x 100					
Tanda Tangan Penguji					
Referensi : Arfiana, <i>et al</i> (2020) dalam buku Kewaspadaan Kegawatdaruratan Maternal Neonatal.					

E. Daftar Pustaka

- Arfiana *et al.* (2020) *Kewaspadaan Kegawatdaruratan Maternal Neonatal*. Edited by Yusuf. Jakarta: Medical service & training 119.
- Putra *et al.* (2016) *Gambaran Persalinan Letak Sungsang di RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou Manado*. Manado: Universitas Sam Ratulangi.
- Rosdianah *et al.* (2019) *Manajemen Asuhan Kebidanan Intranatal Patologi dengan Persalinan Letak Sungsang (Literatur Review)*. Edited by Kembong. Makassar: CV Cahaya bintang cemerlang.
- Setyarini and Suprpti (2016) *Asuhan kebidanan kegawatdaruratan maternal neonatal*. Edited by Kementerian Kesehatan RI. Jakarta.
- Silinaung, Kaeng and Erna, S. (2016) 'Karakteristik persalinan letak sungsang di RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou.', *e-Clinic (eCI)*, 4(1).

F. Glosarium

A

AKI: Angka kematian ibu, jumlah kematian ibu akibat dari proses kehamilan, persalinan dan pasca persalinan per 100.000 kelahiran hidup pada masa tertentu.

I

inform consent : penyampaian informasi dari dokter, maupun tenaga medis lainnya, kepada pasien sebelum suatu tindakan medis dilakukan

M

Malposisi : abnormal dari vertek kepala janin (dengan ubun-ubun kecil sebagai penanda) terhadap panggul ibu. Dalam keadaan malposisi dapat terjadi partus macet atau partus lama.

BAB XII

PRAKTIKUM KOMPRESI BIMANUAL INTERNA (KBI)

Amanda Via Maulinda, S.Tr.Keb., M.K.M



**Nuansa
Fajar
Cemerlang**

A. Deskripsi

Indikator derajat kesehatan masyarakat adalah Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB). Makin tinggi angka kematian ibu dan bayi di suatu negara maka dapat dipastikan bahwa derajat kesehatan negara tersebut buruk (Kemenkes RI, 2021).

Jumlah kematian ibu di Indonesia empat tahun terakhir semakin meningkat dari tahun 2018 hingga 2021. Pada tahun, 2018 berjumlah 4.226, tahun 2019 (4.221), tahun 2020 (4.627) dan tahun 2021 (7.389). Penyebab paling tinggi adalah perdarahan sebanyak 1.320 kasus (Kemenkes RI, 2021). Perdarahan dapat terjadi karena atonia uteri, dimana uterus tidak berkontraksi dengan baik setelah lahirnya bayi dan plasenta. Perlunya, Tindakan untuk menghentikan perdarahan tersebut, salah satunya dengan Kompresi Bimanual Interna (KBI).

Pada bab ini mahasiswa mempelajari tentang konsep dan prosedur tindakan penanganan perdarahan pasca persalinan dengan kompresi bimanual interna yang didasari pada pambaharuan kelimuan.

B. Tujuan Pembelajaran**1. Tujuan Pembelajaran Umum**

Setelah mempelajari praktikum ini mahasiswa mampu menerapkan asuhan kebidanan dengan tindakan kompresi bimanual interna.

2. Tujuan Pembelajaran Khusus

Setelah mempelajari materi ini diharapkan:

- a. Mahasiswa mampu memahami tentang penanganan perdarahan pasca persalinan dengan kompresi bimanual interna.
- b. Mahasiswa mampu mempraktikkan tindakan penanganan perdarahan pasca persalinan dengan kompresi bimanual interna.

C. Uraian Materi**1. Definisi**

Kompresi Bimanual Interna (KBI) merupakan suatu tindakan untuk mengontrol perdarahan post partum dengan melibatkan kompresi uterus dengan dua tangan, satu menekan dari dalam dan yang lainnya menekan dari luar. KBI harus segera dilakukan apabila uterus tidak berkontraksi dalam 15 detik setelah di lakukan rangsangan taktil (masase) pada fundus uteri dan

terjadi perdarahan lebih dari 500-600 ml selama 24 jam setelah anak lahir (Setyarini dan Suprapti, 2016).

2. Tujuan

- a. Menjepit pembuluh darah dalam dinding uterus
- b. Merangsang myometrium untuk berkontraksi
- c. Menghentikan perdarahan segera

3. Indikasi

Indikasi dilakukan kompresi bimanual interna menurut menurut Nurwahyuni dan Melani, (2022):

- a. Perdarahan.
- b. Terjadi retensio plasenta, sisa selaput ketuban dan iversio uteri
- c. Atonia uteri (myometrium tidak dapat berkontraksi)

4. Kontrak Indikasi

Kontra indikasi dilakukan kompresi bimanual interna menurut Nurwahyuni dan Melani (2022) yaitu, jika kondisi uterus ibu berkontraksi dengan baik dan tidak terjadinya perdarahan.

5. Hal-hal yang diperhatikan

Hal – hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan kompresi bimanual interna adalah sebagai berikut:

- a. Menyiapkan inform consent
- b. Menyiapkan inform choice
- c. Menjaga privasi pasien
- d. Menjaga Kesterilan alat
- e. Tindakan dilakukan sesuai dengan tahapan prosedur

6. Persiapan Alat

Menurut Arfiana *et al* (2020) dalam buku kewaspadaan kegawatdaruratan maternal neonatal, persiapan alat dan bahan yang dibutuhkan untuk melakukan Kompresi Bimanual Interna (KBI) adalah sebagai berikut:

- a. Alat Pelindung diri (Celemek, penutup kepala, kacamata, masker, alas kaki)
- b. Sarung tangan steril dan DTT
- c. Perlak pengalas
- d. Kapas DTT
- e. Bengkok
- f. Kassa steril
- g. Air Klorin 0,5%
- h. Kateter nelaton

7. Prosedur Tindakan dan Rating scale Tindakan

Prosedur tindakan dan rating scale Kompresi Bimanual Interna (KBI) sebagai berikut:

Teknik Kompresi Bimanual Interna (KBI)

- a. Menggunakan APD (celemek, topi, masker, alas kaki, sarung tangan)
- b. Memastikan kelengkapan alat dan meletakkan secara ergonomis.
- c. Memberikan informed consent segera
- d. Mencuci tangan dan memakai sarung tangan
- e. Memasang alas bokong
- f. Melakukan massase uterus untuk mengeluarkan gumpalan darah
- g. Melakukan vulva hygiene
- h. Kosongkan kandung kemih menggunakan kateter nelaton steril
- i. Memasukan tangan secara obstetrik ke dalam lumen vagina
- j. Merubah tangan obtetrik menjadi kepalan tangan dengan dataran punggung jari telunjuk hingga kelingking sampai fornix anterior dan dorong segmen bawah rahim ke kranio anterior.
- k. Upayakan tangan diluar mencakup bagian belakang korpus uteri sebanyak mungkin
- l. Melakukan kompresi uterus dengan mendekatkan telapak tangan luar dengan kepalan dalam pada fornix anterior, sampai perdarahan berhenti dan uterus berkontraksi. Pertahankan posisi tersebut hingga uterus berkontraksi dengan baik
- m. Perhatikan perdarahan yang terjadi, lakukan KBI maksimal 5 menit, bila perdarahan berhenti pertahankan hingga 2 menit lalu lakukan tindakan observasi kala IV, namun bila perdarahan belum berhenti lanjutkan dengan tindakan KBE
- n. Setelah uterus berkontraksi baik, secara perlahan keluarkan tangan dengan mengubah kepalan menjadi tangan obstetric.
- o. Membereskan alat dan merendamnya dalam larutan klorin 0,5 %.
- p. Mencuci tangan dalam larutan klorin 0.5% dan melepas sarung tangan secara terbalik
- q. Memberitahukan ibu hasil tindakan

D. Rating Scale Belajar Keterampilan

KOMPRESI BIMANUAL INTERNAL

Nilailah setiap langkah/kinerja yang diamati dengan menggunakan skala sbb:

- 0** = Bila Langkah atau tugas tidak dikerjakan
- 1** = Langkah dilakukan tetapi tidak sempurna
- 2** = Langkah dilakukan dengan sempurna

No	Komponen	Nilai			
		0	1	2	Score
A. Sikap					
1.	Memperkenalkan diri dengan singkat				14
2.	Menjelaskan prosedur yang akan dilakukan				
3.	Teruji menjaga privacy klien				
4.	Merespon terhadap reaksi klien				
5.	Percaya diri				
6.	Teruji memberikan rasa empati pada klien				
7.	Teruji menjelaskan prosedur yang akan dilakukan				
B. Isi					
1.	Menggunakan APD (celemek, topi, masker, alas kaki, sarung tangan)				34
2.	Memastikan kelengkapan alat dan meletakkan secara ergonomis.				
3.	Memberikan informed consent segera				
4.	Mencuci tangan dan memakai sarung tangan				
5.	Memasang alas bokong				
6.	Melakukan massase uterus untuk mengeluarkan gumpalan darah				
7.	Melakukan vulva hygiene				
8.	Kosongkan kandung kemih menggunakan kateter nelaton steril				
9.	Memasukan tangan secara obstetrik ke dalam lumen vagina				
10.	Merubah tangan obtetrik menjadi kepalan tangan dengan dataran punggung jari telunjuk hingga kelingking sampai fornix anterior dan dorong segmen bawah rahim ke kranio anteior				
11.	Upayakan tangan diluar mencakup bagian belakang korpus uteri sebanyak mungkin				
12.	Melakukan kompresi uterus dengan mendekatkan telapak tangan luar dengan kepalan dalam pada fornix anterior, sampai perdarahan berhenti dan uterus berkontraksi. Pertahankan posisi tersebut hingga uterus berkontraksi dengan baik				
13.	Perhatikan perdarahan yang terjadi, lakukan KBI maksimal 5 menit, bila perdarahan berhenti pertahankan hingga 2 menit lalu lakukan tindakan observasi kala IV, namun bila perdarahan belum berhenti lanjutkan dengan tindakan KBE				
14.	Setelah uterus berkontraksi baik, secara perlahan keluarkan tangan dengan mengubah kepalan menjadi tangan obstetrik				
15.	Membereskan alat dan merendamnya dalam larutan klorin 0,5 %				
16.	Mencuci tangan dalam larutan klorin 0.5% dan melepas sarung tangan secara terbalik				

17.	Memberitahukan ibu hasil tindakan				
C. Terminasi					
8.	Melakukan evaluasi tindakan				14
9.	Berpamitan dengan pasien				
10.	Membereskan dan mengembalikan alat				
11.	Mencuci tangan				
12.	Melaksanakan secara sistematis				
13.	Menggunakan bahasa yang mudah dimengerti				
14.	Mendokumentasikan hasil tindakan				
Total Score					
Nilai Akhir = Jumlah score yang diperoleh: Total Score keseluruhan x 100					
Tanda Tangan Penguji					
Referensi : Arfiana, <i>et al</i> (2020) dalam buku Kewaspadaan Kegawatdaruratan Maternal Neonatal.					

E. Daftar Pustaka

Arfiana *et al.* (2020) *Kewaspadaan Kegawatdaruratan Maternal Neonatal*. Edited by Yusuf. Jakarta: Medical service & training 119.

Kemenkes RI (2021) *Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2021*. Jakarta.

Nurwahyuni and Melani (2022) 'Analisis faktor yang berhubungan dengan demand atas pemanfaatan penolong persalinan di Provinsi Banten: Analisis data Susenas 2019.', *Inovasi Penelitian*, 10(2).

Setyarini and Suprpti (2016) *Asuhan kebidanan kegawatdaruratan maternal neonatal*. Edited by Kementerian Kesehatan RI. Jakarta.

F. Glosarium

A

Atonia Uteri : Uterus tidak berkontraksi dan terasa lembek

I

Inversio Uteri : Uterus terputar baik sehingga fundus uteri terdapat dalam Lahir.

R

Retensio plasenta: Plasenta belum lahir dalam waktu 30 menit setelah bayi vagina dengan selaput lendirnya sebelah luar

BAB XIII

PRAKTIKUM KOMPRESI BIMANUAL EKSTERNA

(KBE)

Amanda Via Maulinda, S.Tr.Keb., M.K.M



**Nuansa
Fajar
Cemerlang**

A. Deskripsi

Jumlah kematian ibu di Indonesia empat tahun terakhir semakin meningkat dari tahun 2018 hingga 2021. Pada tahun, 2018 berjumlah 4.226, tahun 2019 (4.221), tahun 2020 (4.627) dan tahun 2021 (7.389). Penyebab paling tinggi adalah perdarahan sebanyak 1.320 kasus (Kemenkes RI, 2021). Perdarahan post partum merupakan penyebab kematian maternal terbanyak. Atonia uteri merupakan penyebab terbanyak perdarahan pospartum dini (50%), dan merupakan alasan paling sering untuk melakukan histerektomi postpartum.

Kompresi bimanual interna (KBI) dan kompresi bimanual eksterna (KBE) merupakan salah satu upaya pertolongan pertama pada perdarahan pasca persalinan yang disebabkan oleh atonia uteri. Namun, Kompresi Bimanual Eksternal (KBE) dapat dilakukan jika kompresi bimanual internal gagal. Dalam hal ini, keluarga dapat berperan serta dalam membantu tindakan penanganan perdarahan dengan Kompresi Bimanual Eksterna (KBE) (Kurniawan, 2016).

Pada bab ini mahasiswa mempelajari tentang konsep dan prosedur tindakan penanganan perdarahan pasca persalinan dengan kompresi bimanual eksterna yang didasari pada pambaharuan kelimuan.

B. Tujuan Pembelajaran**1. Tujuan Pembelajaran Umum**

Setelah mempelajari praktikum ini mahasiswa mampu menerapkan asuhan kebidanan dengan tindakan kompresi bimanual eksterna.

2. Tujuan Pembelajaran Khusus

Setelah mempelajari materi ini diharapkan:

- a. Mahasiswa mampu memahami tentang penanganan perdarahan pasca persalinan dengan kompresi bimanual eksterna.
- b. Mahasiswa mampu mempraktikkan tindakan penanganan perdarahan pasca persalinan dengan kompresi bimanual eksterna.

C. Uraian Materi**1. Definisi**

Kompresi Bimanual Eksterna (KBE) merupakan suatu tindakan yang efektif untuk mengendalikan perdarahan post partum seperti akibat dari atonia uteri. Kompresi bimanual eksterna dapat diteruskan hingga uterus berkontraksi dan perdarahan dapat berhenti. Kompresi pada KBE hampir

sama dengan kompresi KBI, hanya saja penekanan di lakukan di luar rahim (Setyarini dan Suprapti, 2016).

2. Tujuan

- a. Merangsang myometrium untuk berkontraksi
- b. Menghentikan perdarahan segera (Setyarini dan Suprapti, 2016).

3. Indikasi

Indikasi dilakukan kompresi bimanual eksterna menurut Nurwahyuni dan Melani (2022), jika telah dilakukan kompresi bimanual interna namun gagal, masih terdapat perdarahan dan uterus tidak berkontraksi.

4. Kontra Indikasi

Kontra indikasi dilakukan kompresi bimanual eksterna menurut Nurwahyuni dan Melani (2022) yaitu, jika kondisi uterus ibu berkontraksi dengan baik dan tidak terjadinya perdarahan.

5. Hal-hal yang diperhatikan

Hal – hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan kompresi bimanual eksterna adalah sebagai berikut:

- a. Menyiapkan inform consent
- b. Menyiapkan inform choice
- c. Menjaga privasi pasien
- d. Menjaga Kesterilan alat
- e. Tindakan dilakukan sesuai dengan tahapan prosedur

6. Persiapan Alat

Menurut Arfiana *et al* (2020) dalam buku kewaspadaan kegawatdaruratan maternal neonatal, persiapan alat dan bahan yang dibutuhkan untuk melakukan Kompresi Bimanual Eksterna (KBE) adalah sebagai berikut:

- a. Alat Pelindung diri (Celemek, penutup kepala, kacamata, masker, alas kaki)
- b. Sarung tangan steril dan DTT
- c. Infus set dan cairan infus (Jarum 16 atau 18)
- d. Obat uterotonika (oksitosin 20 IU, 1 ampul methergine atau 600-1000 mg/anal)
- e. Oksigen
- f. Bengkok
- g. Sput
- h. Air Klorin 0,5%

7. Prosedur Tindakan dan Rating scale Tindakan

Prosedur tindakan dan rating scale Kompresi Bimanual Eksterna (KBE) sebagai berikut:

Tekhnik Kompresi Bimanual Eksterna (KBE)

- a. Menggunakan APD (celemek, topi, masker, alas kaki, sarung tangan)

- b. Mencuci tangan dan memakai sarung tangan.
- c. Ajarkan keluarga/asisten KBE.
- d. Gunakan handscoon pendek kanan dan kiri.
- e. Tekan dinding perut bagian bawah untuk menaikkan fundus uteri agar telapak tangan kiri dapat mencakup dinding belakang uterus.
- f. Pindahkan posisi tangan kanan sehingga posisi tangan kanan dapat menekan korpus uteri bagian depan.
- g. Tekanan korpus uteri dengan cara mendekatkan telapak tangan kiri dan kanan serta perhatikan jika terjadi perdarahan.
- h. Bila perdarahan terjadi, pertahankan posisi tersebut hingga uterus dapat berkontraksi dengan baik.
- i. Bila perdarahan terjadi, pertahankan posisi tersebut hingga uterus dapat berkontraksi dengan baik.
- j. Sementara keluarga / tim pelaksana lain melakukan KBE, bidan melakukan pemasangan infuse RL + oxytosin 20 IU tetesan cepat dan memberi 1 ampul methergin IM atau 600- 1000 mg/anal.
- k. Lepaskan handscoon pendek tangan kanan gunakan kembali handscoon panjang. Lakukan KBI (lihat langkah KBI).
- l. Bila gagal rujuk sambil melakukan KBE, lakukan sampai ditempat rujukan dengan pengawasan infus dan O2 terpasang dan dengan sistem BAKSOKUDA.
- m. Bila perdarahan berkurang atau berhenti, pertahankan posisi tersebut dan lakukan massage uterus (oleh asisten) hingga uterus berkontraksi dengan baik.
- n. Membereskan alat dan merendamnya dalam larutan klorin 0,5 %.
- o. Mencuci tangan dalam larutan klorin 0.5% dan melepas sarung tangan secara terbalik.

D. Rating Scale Belajar Keterampilan

KOMPRESI BIMANUAL EKSTERNA

Nilailah setiap langkah/kinerja yang diamati dengan menggunakan skala sbb:

- 0** = Bila Langkah atau tugas tidak dikerjakan
- 1** = Langkah dilakukan tetapi tidak sempurna
- 2** = Langkah dilakukan dengan sempurna

No	Komponen	Nilai			
		0	1	2	Score
A. Sikap					
1.	Memperkenalkan diri dengan singkat				14
2.	Menjelaskan prosedur yang akan dilakukan				
3.	Teruji menjaga privacy klien				
4.	Merespon terhadap reaksi klien				
5.	Percaya diri				
6.	Teruji memberikan rasa empati pada klien				
7.	Teruji menjelaskan prosedur yang akan dilakukan				
B. Isi					
1.	Menggunakan APD (celemek, topi, masker, alas kaki, sarung tangan)				32
2.	Mencuci tangan dan memakai sarung tangan				
3.	Ajarkan keluarga/asisten KBE.				
4.	Gunakan handscoon pendek kanan dan kiri.				
5.	Tekan dinding perut bagian bawah untuk menaikan fundus uteri agar telapak tangan kiri dapat mencakup dinding belakang uterus.				
6.	Pindahkan posisi tangan kanan sehingga posisi tangan kanan dapat menekan korpus uteri bagian depan.				
7.	Tekanan korpus uteri dengan cara mendekatkan telapak tangan kiri dan kanan serta perhatikan jika terjadi perdarahan				
8.	Bila perdarahan terjadi , pertahankan posisi tersebut hingga uterus dapat berkontraksi dengan baik				
9.	Bila perdarahan terjadi , pertahankan posisi tersebut hingga uterus dapat berkontraksi dengan baik				
10.	Sementara keluarga / tim pelaksana lain melakukan KBE, bidan melakukan pemasangan infuse RL + oxytosin 20 IU tetesan cepat dan memberi 1 ampul methergin IM atau 600- 1000 mg/anal.				
11.	Lepaskan handscoon pendek tangan kanan gunakan kembali handscoen panjang. Lakukan KBI (lihat langkah KBI).				
12.	Bila gagal rujuk sambil melakukan KBE, lakukan sampai ditempat rujukan dengan pengawasan infus dan O2 terpasang dan dengan sistem BAKSOKUDA.				
13.	Bila perdarahan berkurang atau berhenti, pertahankan posisi tersebut dan lakukan massage uterus (oleh asisten) hingga uterus berkontraksi dengan baik				
14.	Membereskan alat dan merendamnya dalam larutan klorin 0,5 %				
15.	Mencuci tangan dalam larutan klorin 0.5% dan melepas sarung tangan secara terbalik				
16.	Memberitahukan ibu hasil tindakan				
C. Terminasi					

15.	Melakukan evaluasi tindakan				14
16.	Berpamitan dengan pasien				
17.	Membereskan dan mengembalikan alat				
18.	Mencuci tangan				
19.	Melaksanakan secara sistematis				
20.	Menggunakan bahasa yang mudah dimengerti				
21.	Mendokumentasikan hasil tindakan				
Total Score					
Nilai Akhir = Jumlah score yang diperoleh: Total Score keseluruhan x 100					
Tanda Tangan Penguji					
Referensi : Arfiana, <i>et al</i> (2020) dalam buku Kewaspadaan Kegawatdaruratan Maternal Neonatal.					

E. Daftar Pustaka

Arfiana *et al.* (2020) *Kewaspadaan Kegawatdaruratan Maternal Neonatal*. Edited by Yusuf. Jakarta: Medical service & training 119.

Kemenkes RI (2021) *Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2021*. Jakarta.

Kurniawan (2016) *Asuhan Kebidanan Persalinan dan Bayi Baru Lahir*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.

Nurwahyuni and Melani (2022) 'Analisis faktor yang berhubungan dengan demand atas pemanfaatan penolong persalinan di Provinsi Banten: Analisis data Susenas 2019.', *Inovasi Penelitian*, 10(2).

Setyarini and Suprpti (2016) *Asuhan kebidanan kegawatdaruratan maternal neonatal*. Edited by Kementerian Kesehatan RI. Jakarta.

F. Glosarium

A

AKI: Angka kematian ibu, jumlah kematian ibu akibat dari proses kehamilan, persalinan dan pasca persalinan per 100.000 kelahiran hidup pada masa tertentu.

I

inform consent : penyampaian informasi dari dokter, maupun tenaga medis lainnya, kepada pasien sebelum suatu tindakan medis dilakukan

M

Malposisi : abnormal dari vertek kepala janin (dengan ubun-ubun kecil sebagai penanda) terhadap panggul ibu. Dalam keadaan malposisi dapat terjadi partus macet atau partus lama.

PROFIL PENULIS



Irfana Tri Wijayanti, S.Si.T., M.Kes., M.Keb.

Penulis lahir di Kudus pada tanggal 25 Agustus 1983. Riwayat pendidikan penulis telah menyelesaikan pendidikan D4 di Program Studi Kebidanan STIKES Ngudi Waluyo Ungaran lulus tahun 2008, menyelesaikan pendidikan S2 Kesehatan di Program Studi Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro lulus Tahun 2011 kemudian menyelesaikan Pendidikan S2 Kebidanan di Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta lulus tahun 2019. Penulis pernah bekerja di Rumah Bersalin (RB) Utami sebagai bidan pelaksana mulai tahun 2004 s.d 2006. Pada tahun 2006-2008 bekerja Akbid Bakti Utama Pati sebagai laboran. Awal karier sebagai dosen penulis aktif dalam

kegiatan mengajar, penelitian, pengabdian masyarakat sejak tahun 2008 di Akbid Bakti Utama Pati hingga saat ini berubah menjadi STIKes Bakti Utama Pati. Beberapa penelitian yang telah dilakukan memperoleh pendanaan dari DRPM/Kemenristek DIKTI. Luaran dari hasil penelitian dan pengabdian masyarakat telah dipublikasikan di jurnal nasional, nasional terakreditasi dan internasional (accepted) serta buku yang memperoleh sertifikat HaKi. Selain itu, pada tahun 2018 penulis mendapatkan penghargaan berupa "*Best Artike*" dari NTUNHS. Hasil karya lainnya penulis, yaitu berupa buku yang telah diterbitkan oleh EGC, PT Kanisius, Yayasan Barcode, K-Media, Optimal, Sada serta menciptakan sebuah aplikasi yang diberi nama "*IrFa Contraction*" yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat utamanya ibu hamil dan ibu dalam proses persalinan. Selain menjalankan tugas sebagai dosen, saat ini penulis aktif pada Organisasi Ahli Dosen Republik Indonesia (ADRI) Propinsi Jawa Tengah pada divisi kedharmaan PT, Forkom Institusi Kebidanan Propinsi Jawa Tengah dan reviewer artikel jurnal pada beberapa institusi di Indonesia serta aktif mengikuti kegiatan seminar/webinar/workshop/pelatihan. Penulis mempunyai harapan untuk selalu dapat berkontribusi positif dan memberikan manfaat kepada masyarakat, nusa, bangsa dan negara ini.

Email Penulis: irfanawijayanti@gmail.com atau irfana_tri@yahoo.co.id

PROFIL PENULIS



Putu Ayu Ratna Darmayanti, S.Tr.Keb.,M.Kes

Penulis lahir Kota Denpasar Provinsi Bali. Berasal dari Kabupaten Gianyar Provinsi Bali. Saat ini penulis tinggal di Kota Denpasar Provinsi Bali. Ratna telah menyelesaikan Pendidikan D3 kebidanan di Akademi Kebidanan Kartini Bali pada tahun 2013. Selanjutnya, melanjutkan pendidikan D4 Kebidanan jurusan pendidik di STIKES Ngudi Waluyo Semarang dan lulus pada tahun 2015. Tidak hanya berhenti disitu penulis melanjutkan pendidikan S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat dengan Konsentrasi KIA-Kespro Konsentrasi di Universitas Udayana Denpasar Bali dan telah lulus pada tahun 2018. Saat ini, penulis mulai aktif mengajar sebagai dosen kebidanan program studi Sarjana Kebidanan di Institut Teknologi dan Kesehatan Bali sejak tahun 2018 sampai sekarang. Penulis aktif dalam menulis buku, Hasil penulisan buku tersebut diterbitkan oleh Nuansa Fajar Cemerlang dan Mahakarya Citra Utama. Penulis juga memiliki karya jurnal penelitian dan pengabdian masyarakat yang telah terbit pada jurnal nasional dan jurnal internasional. Beberapa karya penulis telah terdaftar pada Hak Kekayaan Intelektual (HKI) oleh Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.

e-mail penulis: darmayantiratna@gmail.com



Amanda Via Maulinda, S.Tr.Keb.,M.K.M.

Lahir di Pekalongan, 17 Juli 1997. Penulis telah menyelesaikan pendidikan D4 Kebidanan di Poltekkes Kemenkes Semarang tahun 2019, kemudian menyelesaikan pendidikan S2 Kesehatan Masyarakat di Universitas Sebelas Maret tahun 2022. Sejak tahun 2022 penulis mulai aktif mengajar sebagai Dosen Kebidanan di STIKES Bakti Utama Pati. Penulis mengajar mata kuliah Asuhan Persalinan dan BBL, Pemeriksaan fisik ibu dan bayi, Asuhan Kebidanan Keluarga dan Masyarakat, KB dan Pelayanan Kontrasepsi. Penulis juga aktif menulis buku, buku yang sudah diterbitkan adalah buku ajar asuhan kebidanan pada persalinan. Penulis juga mengembangkan skill dalam bidang kewirausahaan Kasih Bunda Spa yang berada di Kota Pekalongan. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail viaamanda80@gmail.com

SINOPSIS

Penuntun praktikum asuhan kebidanan persalinan ini adalah salah satu buku penuntun praktikum yang dapat membimbing, mengarahkan dan mengajarkan mahasiswa kebidanan dalam mempelajari tentang praktikum persalinan fisiologis maupun patologis sesuai dengan perasat/ kompetensi yang akan dicapai mahasiswa. Selain itu buku penuntun praktikum ini juga memberikan pengalaman bagi mahasiswa dalam melakukan tindakan pada ibu bersalin yang di praktikumkan di laboratoriaorium sebelum mahasiswa diterjunkan di lahan praktik, baik itu di Rumah Sakit, Praktik Mandiri Bidan, maupun di tempat pelayanan kesehatan lainnya. Penuntun praktikum asuhan kebidanan persalinan ini meliputi: praktikum pengisian partograf, posisi meneran, asuhan persalinan normal, heating perineum, vaginal toucher, distosia bahu, manual plasenta, kompresi aorta abdominalis, amniotomi, episiotomi, pertolongan persalinan sungsang metode bracht, kompresi bimanual interna, kompresi bimanual eksterna.

Penuntun praktikum asuhan kebidanan persalinan ini adalah salah satu buku penuntun praktikum yang dapat membimbing, mengarahkan dan mengajarkan mahasiswa kebidanan dalam mempelajari tentang praktikum persalinan fisiologis maupun patologis sesuai dengan perasat/ kompetensi yang akan dicapai mahasiswa. Selain itu buku penuntun praktikum ini juga memberikan pengalaman bagi mahasiswa dalam melakukan tindakan pada ibu bersalin yang di praktikumkan di laboratorium sebelum mahasiswa diterjunkan di lahan praktik, baik itu di Rumah Sakit, Praktik Mandiri Bidan, maupun di tempat pelayanan kesehatan lainnya. Penuntun praktikum asuhan kebidanan persalinan ini meliputi: praktikum pengisian partograf, posisi meneran, asuhan persalinan normal, heating perineum, vaginal toucher, distosia bahu, manual plasenta, kompresi aorta abdominalis, amniotomi, episiotomi, pertolongan persalinan sungsang metode bracht, kompresi bimanual interna, kompresi bimanual eksterna.

ISBN 978-623-88659-0-1



 **IKAPI**
IKATAN PENERBIT INDONESIA
Anggota IKAPI
No. 624/DKI/2022

Penerbit :
PT Nuansa Fajar Cemerlang
Grand Slipi Tower Lt. 5 Unit F
Jalan S. Parman Kav. 22-24
Kel. Palmerah, Kec. Palmerah
Jakarta Barat, DKI Jakarta, Indonesia, 11480
Telp: (021) 29866919